

Buku Ajar
**KEPERAWATAN
KRITIS**

Hairunnisa • Hesti Prawita Widiastuti • Fathimi
Moza Suzana • Riyan Dwi Prasetyawan • Aliana Dewi



BUKU AJAR KEPERAWATAN KRITIS

Penulis:

Ns. Hairunnisa, S.Kep., M.Kep.

Ns. Hesti Prawita Widiastuti, SST., M.Kes.

Fathimi, S.Kep., M.K.M.

Ns. Moza Suzana, M.Kep.

Riyan Dwi Prasetyawan, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Aliana Dewi., SKp., MN.

BUKU AJAR KEPERAWATAN KRITIS

Penulis: Ns. Hairunnisa, S.Kep., M.Kep.
Ns. Hesti Prawita Widiastuti, SST., M.Kes.
Fathimi, S.Kep., M.K.M.
Ns. Moza Suzana, M.Kep.
Riyan Dwi Prasetyawan, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Aliana Dewi., SKp., MN.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-20-3

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan Buku Ajar Keperawatan Kritis ini. Buku ini disusun sebagai sumber belajar komprehensif bagi mahasiswa keperawatan, praktisi, serta tenaga pengajar dalam memahami dan mengembangkan kompetensi keperawatan di ruang perawatan kritis. Keperawatan kritis menuntut keterampilan klinis tinggi, kemampuan berpikir analitis, serta sensitivitas etik dan holistik dalam memberikan pelayanan kepada pasien dalam kondisi yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, penyusunan buku ini berfokus pada integrasi antara konsep dasar, filosofi, proses keperawatan kritis, dan implementasi praktik berbasis bukti.

Struktur buku ini dirancang secara sistematis mencakup enam bab utama. Bab pertama membahas fondasi filosofis dan pendekatan holistik dalam keperawatan kritis. Bab kedua mengeksplorasi pentingnya analisis kasus dengan mengintegrasikan hasil penelitian mutakhir. Bab ketiga menyoroti peran strategis advokasi perawat dalam melindungi hak pasien kritis, termasuk isu etika dan hukum yang relevan. Bab keempat menitikberatkan pada strategi pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga. Selanjutnya, Bab kelima mendalami asuhan keperawatan kritis yang berfokus pada sistem tubuh dan keterkaitannya dengan aspek legal serta etis. Bab keenam mengulas tren dan isu kontemporer dalam keperawatan kritis, seperti telehealth, keterbatasan sumber daya, dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Kami menyadari bahwa perkembangan ilmu dan teknologi di bidang keperawatan kritis terus berlangsung secara dinamis. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan edisi selanjutnya. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi akademik yang dapat memperkaya wawasan, meningkatkan kemampuan klinis, serta memperkuat landasan profesionalisme perawat dalam menghadapi kompleksitas kasus di unit perawatan intensif. Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan manfaat yang maksimal bagi kemajuan praktik keperawatan di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 FILOSOFI, KONSEP HOLISTIK DAN PROSES KEPERAWATAN KRITIS	1
A. Filosofi Keperawatan Kritis	3
B. Konsep Holistik.....	6
C. Proses Keperawatan Kritis.....	9
D. Latihan	10
E. Rangkuman Materi	11
F. Glosarium.....	12
G. Daftar Pustaka.....	12
BAB 2 ANALISIS KASUS DENGAN MENINGTEGRASIKAN HASIL PENELITIAN DALAM KEPERAWATAN KRITIS	15
A. Konsep Dasar Analisis Kasus dalam Keperawatan Kritis.....	17
B. Pemilihan dan Integrasi Hasil Penelitian.....	18
C. Metode Analisis Kasus.....	19
D. Evaluasi Kritis Terhadap Penelitian.....	22
E. Rekomendasi Intervensi Berbasis Bukti.....	24
F. Latihan Soal	26
G. Rangkuman Materi	28
H. Glosarium.....	29
I. Daftar Pustaka.....	31
BAB 3 PERAN DAN FUNGSI ADVOKASI PERAWAT PADA KASUS KRITIS	33
A. Konsep Dasar Advokasi dalam Keperawatan Kritis	35
B. Peran Perawat dalam Advokasi Pasien Kritis.....	36
C. Fungsi Advokasi Perawat dalam Melindungi Hak Pasien	38
D. Isu Etika dan Hukum dalam Advokasi.....	40
E. Keterampilan Komunikasi Efektif dalam Advokasi.....	42
F. Latihan Soal	43
G. Rangkuman Materi	46
H. Glosarium.....	47
I. Daftar Pustaka.....	49

BAB 4 PENDIDIKAN KESEHATAN PADA KASUS KRITIS	51
A. Konsep Dasar dan Prinsip Pendidikan Kesehatan.....	53
B. Identifikasi Kebutuhan Edukasi Pasien dan Keluarga	54
C. Strategi Komunikasi Efektif dalam Pendidikan Kesehatan	56
D. Evaluasi Efektivitas Pendidikan Kesehatan.....	58
E. Latihan Soal	59
F. Rangkuman Materi	62
G. Glosarium.....	62
H. Daftar Pustaka.....	65
 BAB 5 ASUHAN KEPERAWATAN KASUS KRITIS PADA BERBAGAI SISTEM DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LEGAL DAN ETIS	 67
A. Konsep Dasar Keperawatan Kritis dan Integrasi Aspek Legal Etis.....	69
B. Aspek Legal dalam Keperawatan Kritis.....	70
C. Aspek Etis dalam Keperawatan Kritis	71
D. Asuhan Keperawatan pada Sistem Kardiovaskuler.....	72
E. Asuhan Keperawatan pada Sistem Respirasi	74
F. Asuhan Keperawatan pada Sistem Neurologi.....	75
G. Asuhan Keperawatan pada Sistem Gastrointestinal.....	76
H. Advokasi, Komunikasi, dan Dokumentasi dalam Praktik Keperawatan Kritis	78
I. Latihan Soal	79
J. Rangkuman Materi	81
K. Glosarium.....	82
L. Daftar Pustaka.....	85
 BAB 6 TREN DAN ISU DALAM KEPERAWATAN KRITIS	 87
A. Tren Global dan Nasional.....	89
B. Teknologi Digital dan Telehealth.....	90
C. Isu Etika dan Legal	91
D. Manajemen Nyeri, Sedasi, dan Delirium.....	93
E. Keterbatasan Sumber Daya.....	95
F. Manajemen Stres dan Burnout pada Perawat.....	97
G. Rekomendasi Berbasis Bukti.....	99
H. Latihan Soal	101
I. Rangkuman Materi	103
J. Glosarium.....	104
K. Daftar Pustaka.....	107

PROFIL PENULIS	109
-----------------------------	------------

BAB 1

FILOSOFI, KONSEP HOLISTIK DAN PROSES KEPERAWATAN KRITIS

Pendahuluan:

Keperawatan pada area perawatan kritis merupakan suatu bidang yang dinamis dan menuntut keterampilan dan pengetahuan khusus bagi perawat untuk memberikan perawatan secara optimal bagi pasien yang menghadapi kondisi yang mengancam jiwa atau kritis. Perawat sebagai tulang punggung tim perawatan kritis memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan pasien, memberikan edukasi mengenai perawatan yang optimal, dan menciptakan lingkungan perawatan yang mendukung.

Bab ini membahas tentang filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan kritis. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan kembali mengenai filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan kritis. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga keperawatan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah definisi, tujuan keperawatan kritis, peran perawat kritis, tantangan dalam keperawatan perawatan kritis, definisi holistik serta perawatan holistik dan model sinergi di unit perawatan kritis. Pada Bab ini juga akan diuraikan mengenai proses keperawatan kritis. Bab ini juga dilengkapi dengan rangkuman, latihan soal dalam bentuk pilihan ganda dan essay serta glosarium.

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep filosofi keperawatan kritis, konsep holistik keperawatan kritis dan proses keperawatan kritis.

Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan:

1. Definisi keperawatan kritis
2. Tujuan keperawatan kritis
3. Peran perawat kritis
4. Tantangan dalam keperawatan perawatan kritis
5. Definisi holistik
6. Perawatan holistik dan model sinergi di unit perawatan kritis
7. Proses Keperawatan Kritis

Capaian Pembelajaran:**1. Kognitif:**

- a. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan kritis.
- b. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip keperawatan dalam skenario klinis.

2. Psikomotor:

Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep holistik dalam pemberian asuhan keperawatan di area perawatan kritis.

3. Afektif:

- a. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan.
- b. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Uraian Materi

Uraian materi dalam buku ajar ini mencakup berbagai aspek penting dalam keperawatan kritis, antara lain: definisi dan tujuan keperawatan kritis, peran perawat dalam unit perawatan kritis, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik keperawatan kritis. Selain itu, dibahas pula konsep holistik, pendekatan perawatan holistik, model sinergi yang diterapkan di unit perawatan kritis, dan proses keperawatan kritis secara komprehensif.

A. Filosofi Keperawatan Kritis

1. Definisi

Keperawatan kritis berasal dari 2 kata yaitu "Keperawatan" dan "Kritis". Menurut Kepmenkes Nomor HK 01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat, keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan kritis yaitu dalam keadaan kritis, gawat, genting (tentang suatu keadaan (<https://kbbi.web.id/kritis>)).

Menurut *American Association of Critical Care Nursing* (AACN) Keperawatan kritis adalah suatu layanan keperawatan yang secara khusus menangani respon pasien terhadap masalah yang mengancam nyawa (Perrin and MacLeod, 2018). Keperawatan kritis merupakan area spesialisik dari keperawatan yang dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan klien dengan masalah kesehatan akut dan mengancam jiwa yang memerlukan perawatan secara intensif (Urden, Stacy, & Lough, 2006). Jadi dapat disimpulkan bahwa keperawatan kritis adalah suatu kegiatan pemberian asuhan keperawatan kepada pasien dalam keadaan kritis atau mengancam nyawa.

2. Tujuan Keperawatan Kritis

Tujuan dari keperawatan kritis adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemberian layanan yang aman dan berkualitas secara optimal kepada pasien kritis dan keluarganya dengan memberikan perawatan sesuai kebutuhan individu sehingga kelainan fisiologis serta psikologis di ruang rawat intensif (ICU) dapat dikendalikan.
- b. Memberikan perawatan pasien kritis dengan menggunakan pendekatan holistik, dengan mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, budaya dan spiritual pasien tanpa memandang diagnosis atau kondisi klinisnya.

- c. Menggunakan pengetahuan, sikap caring dan keterampilan klinis yang tepat dan terkini, didukung oleh teknologi canggih untuk pencegahan, deteksi dini dan pengobatan komplikasi untuk memfasilitasi pemulihan.
- d. Memberikan perawatan paliatif kepada pasien kritis dalam situasi di mana status kesehatan mereka berkembang menuju kematian yang tidak dapat dihindari, dan untuk membantu pasien dan keluarganya melewati penderitaan yang menyakitkan.

3. Peran Perawat Kritis

Perawat kritis, sering disebut sebagai perawat ICU, adalah perawat terdaftar (*Registered Nurses*) yang telah memiliki pelatihan lanjutan dalam memberikan perawatan kepada pasien kritis atau tidak stabil. Pasien-pasien ini biasanya menderita penyakit atau cedera yang parah dan mengancam jiwa yang memerlukan pemantauan terus-menerus, intervensi lanjutan, dan keahlian klinis tingkat tinggi. Perawat kritis adalah anggota integral dari tim perawatan kesehatan, bekerja sama dengan dokter, terapis pernapasan, dan profesional kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang komprehensif.

Peran perawat kritis antara lain:

- a. Pemantauan dan penilaian berkelanjutan

Perawat yang bertugas pada area perawatan kritis mempunyai tugas untuk memantau kondisi pasien secara terus menerus seperti tanda-tanda vital. Jika terdapat perubahan pada tanda-tanda vital perawat harus merespon dengan cepat. Perawat di perawatan kritis juga melakukan penilaian secara berkala mengenai status klinis termasuk melakukan interpretasi data diagnostik, pengenalan terhadap terjadinya perubahan pada nilai diagnostik dan pengambilan keputusan secara cepat pada situasi darurat.

- b. Dukungan kehidupan tingkat lanjut

Perawat di area perawatan kritis dilatih untuk memberikan respon yang cepat dalam menghadapi pasien yang mengalami serangan jantung dan dalam keadaan gawat darurat lainnya yang dapat mengancam jiwa pasien. Perawat menjadi ujung tombak dalam memberikan intervensi bantuan hidup tingkat lanjut termasuk pemberian intervensi resusitasi jantung paru, defibrilasi dan manajemen jalan napas. Keterampilan perawat dalam menggunakan peralatan yang mendukung kelangsungan hidup seperti ventilator, *infus pump* dan *intra aortic ballon pump* (IABP) sangat penting dalam memberikan perawatan yang efektif kepada pasien.

- c. Koordinasi tim perawatan interdisipliner

Untuk memastikan perawatan pasien dilakukan secara komprehensif, perawatan kritis mempunyai ciri khas yaitu kolaborasi dengan tim interdisipliner di mana perawat berkoordinasi dengan dokter, apoteker dan professional lainnya. Dalam melakukan perawatan kritis pada pasien kerja tim dan komunikasi yang efektif menjadi bagian yang sangat penting karena pengambilan Keputusan yang tepat dapat berdampak secara signifikan terhadap hasil akhir perawatan pasien.

d. Administrasi obat

Perawat mempunyai tanggung jawab dalam memberikan obat-obatan yang kompleks sehingga memerlukan titrasi yang tepat dan pemantauan secara ketat terhadap efek pengobatan pada pasien termasuk pemberian obat-obatan golongan vasoaktif, sedatif dan antibiotik. Selain itu perawat juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan pengobatan, memantau reaksi yang merugikan dan melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan.

e. Perawatan pasien holistik

Perawat di area perawatan kritis memberikan perawatan secara holistik bagi pasien dan keluarga dengan memperhatikan semua aspek yang meliputi biopsikososial dan spiritual. Perawat memberikan tindakan yang memberikan dukungan kenyamanan, edukasi dan memberikan dukungan kesejahteraan pada pasien dan keluarga secara menyeluruh.

f. Advokasi untuk perawatan optimal

Perawat di area perawatan kritis berperan sebagai advokat untuk memastikan pasien mendapatkan hak-haknya, memfasilitasi komunikasi antara pasien dengan penyedia layanan Kesehatan dan mempromosikan perawatan terpusat.

4. Tantangan Dalam Keperawatan Perawatan Kritis

Dalam memberikan rangkaian perawatan pada pasien kritis, perawat menghadapi tantangan yaitu:

a. Ketajaman pasien tinggi

Unit perawatan kritis biasanya melayani pasien yang mengalami kondisi yang mengancam nyawa dan memerlukan perawatan medis yang kompleks. Perawat harus memiliki keterampilan dalam memahami perubahan pada status pasien, menginterpretasikan data fisiologis yang kompleks dan membuat Keputusan cepat agar memastikan perawatan yang diberikan secara efektif.

b. Stress emosional

Perawat yang bekerja di area perawatan kritis sering kali menyaksikan pasien dan keluarga mengalami tekanan secara emosional ketika menghadapi

kondisi pasien yang gawat dan memerlukan pengambilan keputusan dengan cepat. Perawat kadang kala dihadapkan pada perasaan sedih, kelelahan atau tekanan moral terutama saat menghadapi dilema etika.

c. Pengambilan keputusan yang cepat

Kondisi pasien yang cenderung berubah dengan cepat memerlukan pengambilan Keputusan yang cepat dan tegas. Sebagai seorang perawat harus dapat menilai kondisi pasien serta memprioritaskan intervensi dan berkomunikasi secara efektif untuk mengoptimalkan hasil perawatan. Kemampuan untuk mengambil Keputusan secara tepat merupakan ciri khas keperawatan kritis. Tantangan dalam mengambil keputusan mengharuskan bagi perawat untuk meningkatkan pendidikan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, simulasi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis.

d. Ketahanan dan perawatan diri

Untuk menghadapi tantangan keperawatan kritis, menumbuhkan ketahanan sangatlah penting bagi perawat. Perawat yang tangguh dapat beradaptasi terhadap pemicu stres, bangkit kembali dari situasi sulit, dan mempertahankan rasa sejahtera. Untuk meningkatkan ketahanan diri pada perawat dilakukan dengan cara mendorong perawat untuk terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, mencari peluang untuk pembekalan dan refleksi, dan mewaspadaai tanda-tanda kelelahan.

e. Mekanisme pendukung

Institusi pemberi layanan kesehatan harus membangun mekanisme dukungan yang kuat untuk staf perawat yang mencakup akses terhadap layanan konseling, sesi pembekalan, dan program dukungan sebaya. Menciptakan budaya yang menghargai dan memprioritaskan kesehatan mental perawat di area perawatan kritis sangat penting untuk menumbuhkan tenaga kerja yang tangguh dan berkelanjutan.

B. Konsep Holistik

1. Definisi

Kata “holistic” berasal dari bahasa Yunani “holos (whole, wholism)” yang berarti satu kesatuan yang utuh (Dossey, Keegan, & Guzzetta, 2000). Hal ini berarti manusia holistik adalah suatu kesatuan yang utuh, lebih dari atau bukan hanya merupakan gabungan dari beberapa komponen penyusunnya. Asosiasi Perawat Holistik Amerika (2007) mendefinisikan “keperawatan holistik” sebagai praktik keperawatan yang menekankan pada penyembuhan (healing) dari

manusia secara utuh yang meliputi aspek badan (body), jiwa (spirit), dan pikiran (mind).

2. Perawatan Holistik dan Model Sinergi di Unit Perawatan Kritis

Pemberian perawatan holistik pada pasien yang menjalani perawatan di ruang perawatan intensif memerlukan berbagai pertimbangan baik dari faktor individu maupun lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pasien serta kemampuan pasien dan keluarga dalam menghadapi situasi krisis seperti sakit baik akut maupun kronis. Oleh karena itu perawat perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai anatomi fisiologi, proses penyakit, regimen tindakan, perilaku, spiritualitas, dan respon manusia. Perawat di area perawatan kritis tidak hanya mampu bekerja dengan teknologi tinggi, melainkan juga harus “tahu pasien” dalam artian memahami pasien seutuhnya agar bisa memberikan asuhan keperawatan yang humanistik, individual, dan holistik.

Untuk menerapkan perawatan holistik perawat harus memiliki keterampilan interpersonal. Menurut Wysong dan Driver (2009), keterampilan yang harus dimiliki oleh perawat yang bekerja di area perawatan kritis menurut persepsi pasien antara lain:

- a. Ramah, ceria, senyum, gembira
- b. Perduli, baik, kasih sayang
- c. Percaya diri
- d. Memperlakukan pasien sebagai manusia
- e. Mencintai pekerjaan
- f. Berjiwa humor
- g. Memiliki waktu untuk pasien
- h. Terorganisir
- i. Memiliki ingatan yang baik
- j. Rapih penampilan fisik
- k. Baik dalam bertutur/menggunakan bahasa
- l. Pendengar yang baik
- m. Menyenangkan/memberikan kenyamanan
- n. Kontak emosional

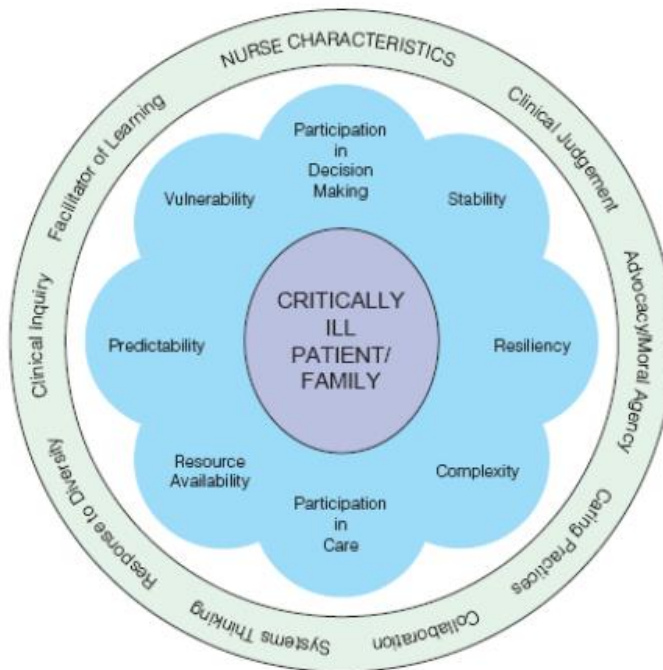
Selain keterampilan interpersonal, kemampuan untuk berpikir kritis yang penting dimiliki oleh perawat yang bekerja di area perawatan kritis antara lain:

- a. Mampu membuat keputusan klinis yang akurat
- b. Dapat mengkaji situasi dan mengambil tindakan yang tepat
- c. Menggunakan akal sehat (logika)
- d. Memberikan jawaban dan informasi yang jelas
- e. Menawarkan saran dan arahan

- f. Memberikan penjelasan tentang prosedur tindakan, kondisi klinis, dan pengobatan

American Association of Critical Care Nursing (AACN) sejak tahun 1990 mengembangkan dan mengaplikasikan model yang dikenal sebagai “Synergy Model” untuk menghubungkan antara praktik perawat kritis yang tersertifikasi dengan luaran pelayanan keperawatan (Relf & Kaplow, NA). Model perawatan ini menjelaskan bahwa praktik keperawatan bukan berdasarkan penyakit dan terapi modalitas melainkan berdasarkan pada kebutuhan dan karakteristik pasien. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kebutuhan dan karakteristik pasien dan keluarga akan mempengaruhi dan mengarahkan kompetensi dan karakteristik perawat. Setiap pasien merupakan makhluk holistik yang memiliki karakteristik unik dalam situasi klinis tertentu, perawat harus merespon dengan kompetensi dan karakteristik unik. Apabila karakteristik pasien cocok dengan kompetensi yang ditampilkan perawat maka hasil perawatan pasien akan optimal sehingga sinergi dapat tercapai. Dua hal penting dalam model ini adalah karakteristik pasien yang menjadi perhatian utama bagi perawat dan kompetensi perawat menjadi bagian terpenting dari pasien.

Walaupun pasien dan keluarga memiliki kenunikan masing-masing namun mereka memiliki kebutuhan dan pengalaman dalam suatu rentang kontinum dari tingkat rendah ke tinggi. Semakin berat gangguan pada pasien akan berbanding lurus dengan kompleks permasalahan yang dialami oleh pasien. Pemberian asuhan keperawatan ditentukan oleh kebutuhan pasien dan keluarga. Model sinergi berfokus pada kontribusi unik dari keperawatan terhadap asuhan pasien dengan menekankan pada peran profesional perawat. Terdapat delapan (8) karakteristik baik pada pasien maupun kompetensi perawat yang saling bersinergi dalam suatu rentang kontinum dari kompeten ke ahli serta mencerminkan hubungan yang harmonis antara pasien dan keluarga serta pasien dan perawat. Model tersebut dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1.1: Hubungan antara pasien/ keluarga dan perawat dan Model Sinergi (Relf & Kaplow, NA)

C. Proses Keperawatan Kritis

1. Pengkajian

Pengkajian dilakukan pada semua sistem tubuh untuk menompang dan mempertahankan sistem-sistem tersebut agar tetap sehat dan tidak terjadi kegagalan sistem tubuh.

2. Diagnosis Keperawatan

Ditegaskan untuk mencari perbedaan serta mencari tanda dan gejala yang sulit diketahui untuk mencegah kerusakan atau gangguan yang lebih luas.

3. Perencanaan Keperawatan

Ditunjukan pada penerimaan dan adaptasi pasien secara konstan terhadap status/ kondisi pasien yang selalu berubah.

4. Implementasi

Ditunjukan untuk memberikan terapi pada gejala-gejala yang muncul pertama kali untuk mencegah krisis yang secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama sampai dapat beradaptasi dengan tercapainya tingkat kesembuhan yang lebih tinggi atau terjadi kematian.

5. Intervensi

Semua tindakan dilakukan dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien sesuai dengan rencana tindakan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan

tindakan keperawatan dapat dalam bentuk observasi, terapeutik, edukasi dan kolaboratif (OTEK). Dalam melakukan tindakan perlu pengawasan terus menerus terhadap kondisi pasien termasuk evaluasi perilaku.

6. Evaluasi

Dilakukan secara cepat, terus menerus dan dalam waktu yang lama untuk mencapai keefektifan masing-masing tindakan atau terapi, secara terus menerus menilai kriteria hasil untuk mengetahui perubahan status pasien.

D. Latihan

Soal Pilihan Ganda

1. Apa yang dimaksud dengan keperawatan kritis menurut AACN?
 - A. Layanan keperawatan yang hanya fokus pada perawatan fisik pasien
 - B. Kegiatan perawatan di rumah sakit umum untuk semua pasien.
 - C. Layanan keperawatan yang menangani respon pasien terhadap masalah yang mengancam nyawa.
 - D. Perawatan dasar yang dilakukan di rumah sakit.
 - E. Tindakan keperawatan yang hanya dilakukan oleh dokter.
2. Salah satu tujuan keperawatan kritis adalah...
 - A. Memberikan terapi alternatif dan herbal kepada pasien.
 - B. Melakukan pembedahan pada pasien kritis.
 - C. Menghilangkan semua penyakit kronis secara total.
 - D. Mengganti peran dokter dalam unit perawatan intensif.
 - E. Menggunakan teknologi canggih untuk memfasilitasi pemulihan pasien.
3. Model Sinergi dari AACN menekankan bahwa...
 - A. Praktik keperawatan didasarkan pada terapi dan obat-obatan
 - B. Praktik keperawatan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pasien.
 - C. Perawat bertugas menggantikan dokter dalam pengambilan keputusan.
 - D. Semua pasien diperlakukan dengan cara yang sama.
 - E. Pasien harus menyesuaikan diri dengan sistem rumah sakit.
4. Dalam proses keperawatan kritis, tahap pengkajian dilakukan untuk...
 - A. Membuat keputusan hukum atas pasien.
 - B. Menilai efek samping dari obat-obatan herbal.
 - C. Menentukan jenis pembedahan yang akan dilakukan.
 - D. Menopang dan mempertahankan sistem tubuh tetap sehat.
 - E. Mengatur administrasi ruang ICU.
5. Berikut ini adalah peran perawat kritis, kecuali...
 - A. Dukungan kehidupan tingkat lanjut
 - B. Pemantauan dan penilaian berkelanjutan

- C. Pembedahan ringan pada pasien
- D. Administrasi obat kompleks
- E. Koordinasi dengan tim interdisipliner

Soal Essay

1. Sebutkan pengertian keperawatan kritis menurut AACN?
2. Sebutkan peran perawat yang bekerja di area perawatan kritis?
3. Jelaskan tantangan dalam melakukan perawatan di area perawatan kritis?
4. Sebutkan keterampilan interpersonal yang penting dimiliki oleh perawat yang bekerja di area perawatan kritis?
5. Jelaskan aplikasi model sinergi dalam perawatan kritis?

Kunci Jawaban

1. C
2. E
3. B
4. D
5. C

E. Rangkuman Materi

1. Keperawatan kritis adalah asuhan keperawatan kepada pasien dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa.
2. Tujuan Keperawatan Kritis:
 - a. Memberikan pelayanan aman dan berkualitas untuk pasien dan keluarganya.
 - b. Menggunakan pendekatan holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis, budaya, dan spiritual.
 - c. Menggunakan teknologi canggih dan keterampilan klinis terkini.
 - d. Memberikan perawatan paliatif saat pasien menuju kematian yang tidak terhindarkan.
3. Peran Perawat Kritis antara lain Pemantauan dan penilaian berkelanjutan , dukungan kehidupan tingkat lanjut, koordinasi tim interdisipliner, administrasi obat, perawatan holistik dan advokasi pasien
4. Tantangan dalam Keperawatan Kritis antara lain ketajaman kondisi pasien yang tinggi, stres emosional, pengambilan keputusan cepat, ketahanan dan perawatan diri dan mekanisme pendukung.
5. Perawatan holistik memandang pasien sebagai makhluk utuh (fisik, pikiran, dan jiwa). Perawat perlu memahami aspek medis dan nonmedis pasien serta memiliki

keterampilan interpersonal seperti ramah, penuh perhatian, percaya diri, dan pendengar yang baik.

6. Model Sinergi (*Synergy Model*) merupakan model yang dikembangkan oleh AACN dan menyatukan karakteristik pasien dengan kompetensi perawat. Keberhasilan perawatan tergantung pada kecocokan keduanya. Fokusnya bukan pada penyakit, tetapi pada kebutuhan dan karakteristik pasien.

F. Glosarium

Holistik	: satu kesatuan yang utuh
Infus Pump	: alat medis yang digunakan untuk memberikan cairan infus secara terkontrol ke tubuh pasien. Alat ini bekerja dengan mengatur kecepatan tetesan cairan infus menggunakan sistem pompa elektronik.
Intra aortic Ballon Pump (IABP)	: suatu alat mekanik yang memiliki fungsi meningkatkan perfusi oksigen myocard dan pada saat yang sama juga akan meningkatkan cardiac output. Peningkatan cardiac output ini akan meningkatkan aliran darah koroner yang membawa oksigen menuju myocard.
Model sinergi	: model perawatan ini menjelaskan bahwa praktik keperawatan bukan berdasarkan penyakit dan terapi modalitas melainkan berdasarkan pada kebutuhan dan karakteristik pasien. Terdapat delapan (8) karakteristik baik pada pasien maupun kompetensi perawat yang saling bersinergi dalam satu rentang kontinum dari kompeten ke ahli serta mencerminkan hubungan yang harmonis antara pasien dan keluarga serta pasien dan perawat.
Titrasi	: proses penyesuaian dosis suatu obat untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa efek samping
Obat Vasoaktif Resusitasi jantung paru	: sekelompok obat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan darah atau kecepatan jantung seseorang berdetak. pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan napas dan sirkulasi darah yang terhenti karena kondisi atau situasi tertentu.
Sedatif	: Zat yang menyebabkan sedasi dengan mengurangi iritabilitas atau kegembiraan. Obat-obatan tersebut merupakan depresan sistem saraf pusat dan berinteraksi dengan aktivitas otak yang menyebabkan perlambatan aktivitas otak.

G. Daftar Pustaka

Alfano, A., Riddle, K., Nordstrom, K., Buterakos, R., & Keiser, M. (2024). The Impact of Nursing Education on Ventilator-Associated Pneumonia Prevention Bundle to

- Reduce Incidence of Infection: A Quality Improvement Project. *Dimensions of Critical Care Nursing*, 43(1), 40-46.
- American Association of Critical-Care Nurses. (2021). AACN Scope and Standards for Acute and Critical Care Nursing Practice. American Association of Critical-Care Nurses.
- Dossey, B.M., Keegan, L., & Guzzetta, C.E. (2000). *Holistic Nursing: A Handbook for Practice*, 3rd eds. Gaithersburg: Aspen Publisher.
- Gautam, A. (2024). The Crucial Role of Nurses in Critical Care: A Comprehensive Review. *Brio International Journal of Nursing Research (BIJNR)*, 5(1), 97-103.
- Ibrahim, Kusman. 2012. Aplikasi Keperawatan Holistik di Area Keperawatan Kritis. Disampaikan pada Symposium Himpunan Perawat Critical Care Indonesia (HIPERCCI) Ke-X di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung, 10 Maret 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI). <https://kbbi.web.id/kritis>
- Kepmenkes Nomor HK 01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat, keperawatan
- McNeill, J. M. (2017). Evidence-based Critical Care Nursing. John Wiley & Sons.
- Perrin, K. O. and MacLeod, C. E. 2018. Understanding the Essentials of Critical Care Nursing. Third, Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain). Third. New York: Pearson Education, Inc.
- Relf, M., & Kaplow, R. (NA). Critical Care Nursing Practice: An Integration of Caring, Competence, and Commitment to Excellence.
- Urden, L.D., Stacy, K.M., & Lough, M.E. (2006). *Thelan's Critical care Nursing, Diagnosis and Management*, St. Louis: Mosby.
- Wyson, P.R., & Driver, E. (2009). Patients' Perceptions of Nurses' Skill. *Critical Care Nurse*, 29, (4), 24-29

BAB 2

ANALISIS KASUS DENGAN MENGINTEGRASIKAN HASIL PENELITIAN DALAM KEPERAWATAN KRITIS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian dalam analisis kasus keperawatan kritis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti ilmiah.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu melakukan analisis kasus keperawatan kritis secara komprehensif dengan mengintegrasikan hasil penelitian terkini sebagai dasar pengambilan keputusan klinis dalam situasi gawat darurat (C4).

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar analisis kasus berbasis evidence-based practice dalam keperawatan kritis.
- Mengidentifikasi dan memilih hasil penelitian terkini yang relevan untuk digunakan dalam analisis kasus.
- Menerapkan metode analisis kasus secara sistematis dalam konteks keperawatan kritis.
- Melakukan analisis kritis terhadap penelitian yang digunakan dalam analisis kasus untuk menentukan validitas dan aplikabilitasnya.
- Menyusun rekomendasi intervensi keperawatan berbasis bukti ilmiah dari hasil analisis kasus.

Pendahuluan

Keperawatan kritis merupakan bidang yang menuntut perawat memiliki kemampuan analitis dan pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat. Keterampilan ini dapat diasah melalui analisis kasus nyata dengan pendekatan evidence-based practice (EBP), yaitu dengan mengintegrasikan hasil penelitian terkini ke dalam pengambilan keputusan klinis. Metode analisis kasus ini penting dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, memastikan efektivitas intervensi, serta mengurangi risiko kesalahan yang dapat berdampak fatal bagi pasien dalam kondisi kritis. Bab ini akan menguraikan proses analisis kasus dengan integrasi penelitian ilmiah terkini, yang bertujuan meningkatkan kompetensi perawat dalam memberikan asuhan yang berbasis bukti ilmiah.

A. Konsep Dasar Analisis Kasus dalam Keperawatan Kritis

Konsep dasar analisis kasus dalam keperawatan kritis merujuk pada proses evaluasi yang mendalam dan sistematis mengenai kondisi klinis pasien dengan penyakit atau kondisi yang mengancam jiwa dan memerlukan intervensi segera serta intensif. Proses ini melibatkan kajian menyeluruh terhadap data klinis yang didapatkan melalui pengkajian fisik yang komprehensif, riwayat kesehatan pasien, hasil laboratorium, serta hasil pemeriksaan diagnostik lainnya. Selain itu, analisis kasus juga mempertimbangkan kondisi spesifik pasien, termasuk usia, komorbiditas, latar belakang sosial, dan psikologis pasien. Elemen-elemen ini merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari analisis kasus, karena kondisi pasien secara keseluruhan sangat mempengaruhi keputusan klinis dan intervensi yang tepat.

Dalam konteks pelayanan keperawatan kritis, lingkungan pelayanan juga memainkan peranan penting. Analisis kasus memperhitungkan faktor-faktor lingkungan, seperti fasilitas rumah sakit, ketersediaan peralatan medis canggih, sumber daya manusia yang kompeten, serta budaya kerja organisasi yang mendukung atau menghambat praktik keperawatan berbasis bukti. Kondisi lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi intervensi, mengingat pasien kritis sering kali memerlukan penanganan segera yang bersifat multidisiplin dan berteknologi tinggi.

Selanjutnya, konsep analisis kasus dalam keperawatan kritis secara spesifik didasarkan pada pendekatan Evidence-Based Practice (EBP). Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap keputusan klinis yang diambil oleh perawat harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaru yang paling relevan, valid, dan andal. Menurut LoBiondo-Wood dan Haber (2021), EBP tidak hanya sekedar mengandalkan hasil penelitian, melainkan juga mengintegrasikan bukti penelitian yang mutakhir dengan pengalaman klinis perawat, preferensi pasien, serta nilai-nilai etis dalam pemberian pelayanan kesehatan. Proses integrasi ini menuntut perawat memiliki kemampuan kritis dalam menelaah berbagai literatur penelitian terbaru untuk mendukung keputusan klinis yang diambil.

Penggunaan hasil penelitian terbaru dalam analisis kasus bertujuan memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar terbukti secara ilmiah efektif dan aman bagi pasien. Sebagai contoh, penelitian tentang penggunaan ventilasi mekanik, terapi farmakologis tertentu, atau protokol pemberian cairan resusitasi pada pasien kritis dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan klinis yang tepat. Dengan demikian, analisis kasus dalam keperawatan kritis berfungsi sebagai panduan ilmiah yang jelas dan objektif, membantu perawat

untuk tidak hanya sekedar menjalankan praktik berdasarkan kebiasaan atau intuisi semata, melainkan berdasarkan data dan bukti ilmiah yang terkini dan teruji.

Dalam penerapan konsep ini, perawat kritis harus memiliki keterampilan khusus dalam mengakses dan menilai bukti ilmiah yang relevan, memahami metodologi penelitian, serta kemampuan untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam praktik klinis sehari-hari. Proses ini tidak mudah dan membutuhkan dukungan institusional dalam bentuk pendidikan berkelanjutan, akses ke jurnal ilmiah, serta budaya organisasi yang mendukung penerapan evidence-based practice. Dengan penerapan konsep dasar analisis kasus ini secara optimal, perawat kritis akan mampu memberikan asuhan keperawatan yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga meningkatkan hasil klinis pasien secara signifikan.

B. Pemilihan dan Integrasi Hasil Penelitian

Pemilihan dan integrasi hasil penelitian dalam analisis kasus berbasis bukti di keperawatan kritis merupakan langkah krusial yang menentukan efektivitas intervensi klinis yang diberikan kepada pasien. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi secara cermat berbagai sumber literatur ilmiah terbaru yang relevan dengan kasus klinis yang sedang dihadapi. Dalam tahap ini, perawat kritis perlu memiliki keahlian khusus dalam mencari, mengakses, dan mengevaluasi literatur penelitian melalui berbagai basis data ilmiah seperti PubMed, Cochrane Library, CINAHL, Scopus, maupun jurnal khusus yang relevan dengan bidang keperawatan kritis.

Menurut Melnyk dan Fineout-Overholt (2022), pemilihan literatur penelitian harus mempertimbangkan beberapa aspek utama yaitu validitas, reliabilitas, dan generalisasi hasil penelitian. Validitas berkaitan dengan kemampuan suatu penelitian dalam mengukur dan menggambarkan apa yang seharusnya diukur dan dijelaskan, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya. Reliabilitas merujuk pada konsistensi hasil penelitian apabila diulang atau diuji kembali pada situasi serupa. Generalisasi hasil penelitian adalah kemampuan untuk menerapkan hasil penelitian pada populasi atau kondisi klinis yang berbeda tetapi memiliki karakteristik yang serupa.

Dalam konteks keperawatan kritis, bukti ilmiah dengan tingkat kualitas paling tinggi dan yang paling direkomendasikan adalah penelitian dengan desain Randomized Controlled Trials (RCT) dan tinjauan sistematis atau systematic review. Penelitian dengan desain RCT memiliki tingkat bukti tertinggi karena metode ini secara acak mengalokasikan partisipan penelitian ke dalam kelompok intervensi dan

kontrol, sehingga mengurangi bias dan meningkatkan validitas internal. Metode ini memberikan kepercayaan tinggi bahwa perbedaan hasil antar kelompok benar-benar disebabkan oleh intervensi yang diuji, bukan faktor lain yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, hasil dari RCT sering dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan klinis yang spesifik dan kritis, seperti penggunaan obat-obatan, strategi ventilasi mekanik, manajemen cairan, atau protokol-protokol keperawatan intensif lainnya.

Selanjutnya, systematic review menempati posisi penting dalam proses pemilihan dan integrasi bukti ilmiah karena memberikan sintesis menyeluruh terhadap berbagai penelitian individu tentang suatu topik tertentu. Systematic review dilakukan dengan metode yang terstruktur, transparan, dan objektif untuk menggabungkan hasil-hasil penelitian yang relevan secara kritis dan ketat. Melalui systematic review, perawat kritis dapat memahami gambaran menyeluruh tentang efektivitas intervensi tertentu, mendapatkan wawasan tentang pola atau tren umum dari hasil penelitian, serta mengetahui aspek mana yang memiliki bukti paling kuat dan mana yang masih kontroversial atau kurang jelas.

Ketika memilih dan mengintegrasikan hasil penelitian dalam praktik klinis, perawat kritis juga perlu mempertimbangkan konteks klinis spesifik pasien. Hal ini penting karena tidak semua hasil penelitian dapat langsung diterapkan secara umum tanpa mempertimbangkan variabel seperti karakteristik pasien, komorbiditas, status klinis, preferensi pasien, serta sumber daya yang tersedia di lingkungan pelayanan. Dalam praktik nyata, terkadang ditemukan bahwa hasil penelitian yang sangat kuat secara ilmiah belum tentu langsung dapat diterapkan sepenuhnya di lingkungan klinis tertentu, karena keterbatasan sumber daya atau perbedaan karakteristik populasi.

C. Metode Analisis Kasus

Metode analisis kasus merupakan pendekatan sistematis yang digunakan oleh perawat dalam mengevaluasi kondisi pasien yang kompleks, khususnya di unit perawatan kritis. Metode ini melibatkan proses ilmiah yang terstruktur dan berurutan, bertujuan untuk mengoptimalkan intervensi yang diberikan kepada pasien, berdasarkan integrasi data klinis pasien dengan bukti penelitian yang relevan serta terbaru. Proses ini memastikan keputusan klinis yang diambil bersifat ilmiah, valid, dan efektif untuk meningkatkan keselamatan serta hasil klinis pasien.

Secara rinci, pendekatan langkah demi langkah dalam metode analisis kasus ini terdiri atas tahapan berikut:

1. Identifikasi masalah klinis secara jelas.

Langkah awal dalam analisis kasus adalah mengidentifikasi masalah klinis pasien secara spesifik, jelas, dan akurat. Dalam tahap ini, perawat mendefinisikan masalah utama pasien dengan menentukan diagnosis keperawatan, kondisi patologis yang menjadi penyebab utama masalah pasien, serta potensi komplikasi yang mungkin muncul.

Tahap identifikasi masalah mencakup:

- a. Menentukan diagnosis keperawatan berdasarkan tanda, gejala, hasil pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pasien.
- b. Menegaskan secara jelas gejala utama, penyebabnya, dan dampak potensialnya pada pasien.
- c. Merinci kondisi-kondisi yang perlu segera ditangani secara klinis untuk menghindari komplikasi lebih lanjut.

Kejelasan dalam identifikasi ini menjadi pijakan untuk langkah analisis berikutnya, sehingga perawat dapat menetapkan fokus intervensi yang spesifik dan tepat.

2. Kumpulan data klinis pasien secara komprehensif.

Setelah masalah klinis teridentifikasi secara jelas, perawat harus mengumpulkan data klinis pasien secara lengkap dan sistematis. Proses ini mencakup data objektif dan subjektif pasien, yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesehatan pasien.

Proses pengumpulan data meliputi:

- a. Pengkajian fisik menyeluruh: pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan sistem tubuh yang relevan, serta observasi klinis pasien.
- b. Riwayat kesehatan pasien: riwayat penyakit sebelumnya, riwayat pengobatan, riwayat alergi, dan informasi penting lainnya.
- c. Hasil pemeriksaan diagnostik: data laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya yang relevan.
- d. Informasi psikososial: kondisi emosional pasien, status sosial-ekonomi, dukungan keluarga, serta preferensi pasien.

Data yang dikumpulkan ini menjadi dasar objektif dalam mengambil keputusan klinis dan merumuskan intervensi keperawatan.

3. Identifikasi penelitian relevan yang mendukung pemecahan masalah.

Pada langkah ini, perawat melakukan pencarian bukti penelitian ilmiah yang relevan dengan permasalahan klinis pasien. Proses ini penting karena intervensi keperawatan yang dipilih harus didasarkan pada bukti ilmiah yang valid.

Langkah identifikasi penelitian mencakup:

- a. Mencari literatur ilmiah melalui database terpercaya, seperti PubMed, Cochrane Library, Scopus, CINAHL, dan sumber jurnal ilmiah lainnya.

- b. Memprioritaskan penelitian yang memiliki desain berkualitas tinggi, seperti Randomized Controlled Trials (RCT), systematic review, meta-analysis, serta pedoman klinis terbaru.
- c. Memastikan literatur yang dipilih memiliki relevansi langsung terhadap masalah klinis pasien, baik dari segi intervensi, populasi penelitian, maupun outcome yang dievaluasi.

4. Lakukan evaluasi kritis terhadap penelitian yang dipilih.

Langkah evaluasi kritis ini merupakan proses penilaian kualitas metodologis penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya. Perawat harus secara cermat dan kritis menguji validitas, reliabilitas, dan aplikabilitas hasil penelitian terhadap kondisi klinis pasien yang sedang ditangani.

Proses evaluasi kritis mencakup:

- a. Menilai kualitas metodologi penelitian, termasuk desain penelitian, jumlah sampel, metode randomisasi, serta analisis statistik yang digunakan.
- b. Menilai validitas hasil penelitian, apakah hasil penelitian benar-benar merepresentasikan kenyataan klinis yang akurat.
- c. Menilai relevansi hasil penelitian terhadap kondisi klinis spesifik pasien, apakah dapat secara langsung diaplikasikan dalam konteks perawatan pasien tersebut.

Evaluasi kritis ini memastikan bahwa hanya bukti-bukti ilmiah yang terbaik, paling relevan, dan valid yang dijadikan dasar dalam merancang intervensi.

5. Sintesis informasi untuk merumuskan intervensi berbasis bukti.

Setelah evaluasi kritis dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan sintesis informasi secara cermat untuk merumuskan intervensi yang optimal. Sintesis ini merupakan integrasi bukti penelitian yang telah dievaluasi secara kritis, dengan kondisi klinis pasien serta pengalaman klinis perawat.

Tahap sintesis ini mencakup:

- a. Mengkombinasikan hasil penelitian terbaik dengan situasi unik pasien secara logis dan sistematis.
- b. Menentukan secara spesifik intervensi yang paling efektif, aman, dan sesuai dengan preferensi serta kondisi pasien.
- c. Merancang rencana intervensi yang mencakup waktu implementasi, dosis atau intensitas intervensi, serta indikator evaluasi efektivitas intervensi.

Sintesis informasi ini membantu memastikan intervensi yang dipilih benar-benar berbasis bukti, relevan, dan tepat sasaran.

6. Implementasi intervensi dan evaluasi efektivitasnya secara berkala.

Langkah terakhir adalah implementasi intervensi yang telah disusun berdasarkan sintesis informasi, disertai dengan evaluasi efektivitas intervensi tersebut secara rutin. Dalam tahap ini, perawat melaksanakan intervensi dengan

memperhatikan situasi klinis pasien secara real-time dan mengevaluasi respons pasien secara berkala.

Proses implementasi dan evaluasi mencakup:

- a. Melaksanakan intervensi secara konsisten, sistematis, dan sesuai prosedur.
- b. Mengamati secara kontinu respons klinis pasien terhadap intervensi, mencatat setiap perubahan yang terjadi.
- c. Melakukan evaluasi berkala untuk menentukan efektivitas intervensi, mencakup penilaian klinis pasien, tanda vital, hasil pemeriksaan laboratorium, serta respons subjektif pasien.
- d. Melakukan revisi atau modifikasi intervensi jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

D. Evaluasi Kritis Terhadap Penelitian

Evaluasi kritis terhadap penelitian merupakan suatu tahap penting dalam praktik keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice), khususnya dalam konteks keperawatan kritis. Evaluasi ini merupakan proses sistematis yang dilakukan perawat untuk menilai kualitas, relevansi, serta keandalan hasil penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Evaluasi kritis ini harus dilakukan secara teliti dan hati-hati agar keputusan klinis yang diambil benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Polit dan Beck (2021), evaluasi kritis penelitian harus dilakukan berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu validitas internal, validitas eksternal, ukuran sampel, metode pengumpulan data, serta kekuatan dan kelemahan dari hasil penelitian.

1. Validitas Internal

Validitas internal mengacu pada sejauh mana hasil penelitian benar-benar menggambarkan kenyataan klinis yang sebenarnya, dan apakah hubungan sebab-akibat yang ditemukan dalam penelitian tersebut dapat dipercaya. Validitas internal sangat penting dalam evaluasi penelitian karena memastikan bahwa hasil penelitian bukan disebabkan oleh bias atau variabel pengganggu lain yang tidak dikendalikan dengan baik.

Evaluasi validitas internal meliputi:

- a. Desain penelitian: Penelitian dengan desain Randomized Controlled Trial (RCT) memiliki validitas internal yang tinggi karena randomisasi mengurangi bias dan faktor pengganggu.
- b. Pengendalian variabel pengganggu (confounding factors): Penelitian harus jelas dalam mengontrol variabel-variabel yang berpotensi mempengaruhi hasil.

- c. Prosedur intervensi yang jelas dan konsisten: Intervensi harus dijelaskan secara rinci agar dapat dipastikan bahwa hasil penelitian benar-benar disebabkan oleh intervensi yang diteliti.

2. Validitas Eksternal

Validitas eksternal merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diaplikasikan pada populasi yang lebih luas di luar populasi yang diteliti. Evaluasi validitas eksternal memastikan bahwa hasil penelitian memiliki manfaat praktis yang jelas di lingkungan klinis yang nyata.

Evaluasi validitas eksternal meliputi:

- a. Kesamaan populasi penelitian: Apakah karakteristik pasien dalam penelitian (usia, jenis kelamin, diagnosis klinis, dll.) relevan dengan pasien yang akan menerima intervensi dalam praktik klinis nyata.
- b. Kondisi lingkungan penelitian: Menilai apakah kondisi penelitian mirip dengan kondisi pelayanan klinis yang nyata, sehingga hasil penelitian mudah diterapkan.
- c. Intervensi dan prosedur penelitian yang jelas dijelaskan sehingga mudah direplikasi dalam praktik klinis sesungguhnya.

3. Ukuran Sampel

Ukuran sampel merupakan kriteria evaluasi penting karena ukuran sampel yang cukup besar dan memadai secara statistik meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Ukuran sampel yang kecil cenderung memiliki risiko kesalahan statistik (false positive atau false negative).

Evaluasi ukuran sampel mencakup:

- a. Kecukupan jumlah sampel: Menilai apakah jumlah sampel mencukupi berdasarkan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian.
- b. Metode pengambilan sampel yang representatif: Menilai apakah metode sampling yang digunakan memungkinkan hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting untuk memastikan keakuratan dan ketepatan data penelitian. Evaluasi metode pengumpulan data mencakup penilaian terhadap alat ukur atau instrumen yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan prosedur yang diterapkan selama penelitian.

Evaluasi metode pengumpulan data meliputi:

- a. Reliabilitas instrumen pengumpulan data: Menilai konsistensi dan keandalan instrumen yang digunakan dalam penelitian, seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan alat ukur medis.
- b. Validitas instrumen: Menilai apakah alat ukur atau instrumen penelitian tersebut benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur.

- c. Teknik pengumpulan data yang sistematis: Menilai prosedur pengumpulan data apakah dilakukan secara jelas, terstruktur, konsisten, serta minim potensi bias.

5. Kekuatan dan Kelemahan Hasil Penelitian

Evaluasi ini bertujuan untuk memahami secara mendalam nilai ilmiah dari penelitian tersebut. Setiap penelitian pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan sebelum menerapkan hasilnya ke dalam praktik klinis.

Evaluasi kekuatan dan kelemahan hasil penelitian mencakup:

- a. Kekuatan hasil penelitian: Menilai aspek positif seperti desain penelitian yang kuat, penggunaan analisis statistik yang tepat, serta hasil yang signifikan secara statistik dan klinis.
- b. Kelemahan hasil penelitian: Mengidentifikasi potensi keterbatasan seperti bias pengukuran, sampel yang kurang representatif, atau analisis statistik yang kurang tepat, sehingga dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian.
- c. Penjelasan keterbatasan oleh peneliti: Menilai apakah penulis penelitian secara transparan dan objektif menjelaskan keterbatasan yang dimiliki oleh penelitiannya.

E. Rekomendasi Intervensi Berbasis Bukti

Rekomendasi intervensi berbasis bukti dalam keperawatan kritis adalah suatu tahapan lanjutan setelah perawat menyelesaikan proses analisis kasus secara sistematis dan mendalam. Intervensi yang dirumuskan pada tahap ini tidak semata-mata didasarkan pada pengalaman klinis atau kebiasaan, tetapi dikembangkan dari integrasi hasil penelitian ilmiah yang relevan, terbaru, valid, dan berkualitas tinggi. Tujuan utama dari rekomendasi intervensi berbasis bukti adalah untuk memastikan bahwa tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien benar-benar efektif, aman, sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mampu meningkatkan hasil klinis secara signifikan.

Dalam proses merumuskan rekomendasi intervensi, perawat secara aktif menggabungkan berbagai hasil penelitian yang telah dievaluasi secara kritis dengan kondisi klinis spesifik pasien serta lingkungan perawatan intensif yang tersedia. Pada tahapan ini, perawat harus mempertimbangkan seluruh aspek penting yang telah diidentifikasi selama proses analisis kasus, termasuk kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan, tingkat keparahan penyakit, potensi komplikasi yang mungkin terjadi, preferensi pasien dan keluarganya, serta sumber daya rumah sakit yang tersedia. Proses integrasi yang komprehensif ini memastikan bahwa rekomendasi intervensi yang dibuat benar-benar relevan dengan situasi klinis yang sedang dihadapi.

Selanjutnya, rekomendasi intervensi berbasis bukti yang telah dirumuskan juga mencakup prosedur intervensi secara rinci. Hal ini berarti setiap tindakan atau prosedur keperawatan yang direkomendasikan dijelaskan secara jelas, detail, dan terstruktur. Penjelasan ini meliputi tahapan intervensi, teknik pelaksanaan yang tepat, durasi intervensi, alat atau instrumen yang digunakan, serta protokol yang wajib diikuti selama pelaksanaan intervensi. Dengan penjelasan yang jelas ini, perawat yang akan menjalankan intervensi di ruang perawatan intensif memiliki panduan yang jelas dan konsisten, yang memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar berbasis bukti dan efektif dalam mencapai hasil klinis yang diinginkan.

Selain prosedur intervensi, rekomendasi juga mencakup evaluasi hasil intervensi secara terencana. Evaluasi ini merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menggunakan indikator-indikator klinis yang relevan dan valid. Indikator-indikator ini biasanya meliputi parameter fisiologis pasien seperti tekanan darah, saturasi oksigen, frekuensi pernapasan, dan kadar elektrolit darah. Selain indikator fisiologis, evaluasi juga dapat mencakup aspek subjektif dari pasien, seperti penilaian tingkat nyeri, kenyamanan pasien, serta kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima. Evaluasi secara rutin ini membantu perawat dalam memonitor respons pasien terhadap intervensi yang diberikan, serta menjadi dasar dalam menentukan efektivitas intervensi secara objektif.

Lebih lanjut, dalam rekomendasi intervensi berbasis bukti juga disiapkan rencana modifikasi intervensi jika diperlukan. Rencana ini merupakan bagian integral dari proses intervensi yang berorientasi pada hasil terbaik untuk pasien. Artinya, perawat harus siap untuk melakukan penyesuaian atau modifikasi intervensi jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa intervensi awal kurang efektif atau tidak memberikan hasil yang diharapkan. Modifikasi tersebut didasarkan pada analisis ulang terhadap bukti ilmiah yang ada, data klinis terbaru pasien, serta dinamika kondisi klinis pasien selama masa perawatan. Kemampuan untuk menyesuaikan dan melakukan perubahan intervensi secara cepat, tepat, dan ilmiah sangat penting, khususnya di lingkungan perawatan intensif yang kondisi pasiennya dapat berubah dengan cepat.

Pada akhirnya, seluruh rekomendasi intervensi berbasis bukti yang dibuat melalui tahapan ini memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan outcome klinis pasien secara signifikan, meningkatkan keselamatan pasien selama perawatan kritis, serta mengoptimalkan proses pemulihan pasien secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan bukti penelitian terbaik, pengalaman klinis perawat, dan

preferensi pasien serta keluarganya, rekomendasi intervensi berbasis bukti memastikan bahwa keputusan klinis dalam keperawatan kritis bersifat ilmiah, humanistik, efektif, dan aman, sesuai dengan tuntutan perawatan modern yang mengutamakan kualitas pelayanan keperawatan yang tinggi dan berbasis bukti ilmiah terkini.

F. Latihan Soal

Kasus 1

Seorang pasien laki-laki berusia 62 tahun masuk ruang ICU dengan diagnosis sindrom gagal napas akut (ARDS). Pasien menunjukkan sesak napas berat, saturasi oksigen 82%, frekuensi napas 32 kali/menit, dan denyut jantung 110 kali/menit. Perawat akan merencanakan intervensi keperawatan berbasis bukti. Sebelum memilih intervensi, langkah pertama yang harus dilakukan oleh perawat adalah:

- A. Mengimplementasikan terapi oksigen segera
- B. Melakukan pencarian literatur ilmiah terbaru terkait ARDS
- C. Melakukan sintesis intervensi yang optimal berdasarkan data pasien
- D. Mengidentifikasi masalah klinis pasien secara jelas dan spesifik
- E. Mengevaluasi respons pasien setelah terapi oksigen diberikan

Kunci jawaban: D

Rasional: Langkah pertama dalam analisis kasus berbasis bukti adalah mengidentifikasi secara jelas dan spesifik masalah klinis pasien sebelum melakukan langkah-langkah analisis berikutnya.

Kasus 2

Seorang wanita berusia 55 tahun dirawat di ICU dengan diagnosis sepsis berat. Data klinis pasien meliputi tekanan darah 78/48 mmHg, suhu tubuh 39°C, hasil laboratorium menunjukkan leukosit 18.000/ μ L, dan kadar laktat darah 4,2 mmol/L. Setelah perawat mengidentifikasi masalah klinis, langkah berikutnya yang paling tepat dilakukan oleh perawat adalah:

- A. Melakukan implementasi terapi cairan secara langsung
- B. Melakukan evaluasi efektivitas intervensi sebelumnya
- C. Mengumpulkan data klinis tambahan untuk melengkapi data pasien secara komprehensif
- D. Melakukan sintesis informasi intervensi
- E. Mengidentifikasi kembali masalah klinis

Kunci jawaban: C

Rasional: Setelah mengidentifikasi masalah, perawat harus melanjutkan dengan mengumpulkan data klinis secara lengkap dan komprehensif sebelum memulai intervensi.

Kasus 3

Pasien laki-laki usia 70 tahun dirawat intensif akibat gagal jantung kongestif akut. Perawat menemukan beberapa penelitian terbaru terkait terapi farmakologis di database seperti PubMed dan Cochrane Library. Tahapan berikutnya yang harus dilakukan perawat setelah menemukan literatur tersebut adalah:

- A. Mengidentifikasi masalah klinis pasien lagi
- B. Melakukan evaluasi kritis terhadap penelitian yang dipilih
- C. Langsung melakukan implementasi intervensi dari hasil literatur
- D. Menjalankan intervensi berdasarkan kebiasaan klinis
- E. Mengevaluasi efektivitas terapi farmakologis sebelumnya

Kunci jawaban: B

Rasional: Setelah mengidentifikasi penelitian relevan, langkah wajib berikutnya adalah melakukan evaluasi kritis terhadap penelitian tersebut untuk memastikan validitas dan relevansi hasil sebelum digunakan dalam sintesis intervensi.

Kasus 4

Seorang pasien wanita, 48 tahun, dirawat di ICU dengan kondisi stroke hemoragik akut. Pasien mengalami penurunan kesadaran dengan skor Glasgow Coma Scale (GCS) 7. Setelah perawat mengevaluasi secara kritis penelitian terbaru mengenai perawatan pasien stroke hemoragik, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah:

- A. Sintesis informasi dari bukti penelitian dengan data klinis pasien
- B. Melakukan implementasi intervensi berdasarkan rekomendasi umum
- C. Mengulangi evaluasi kritis terhadap penelitian
- D. Mengulang identifikasi masalah pasien
- E. Langsung melakukan evaluasi terhadap pasien

Kunci jawaban: A

Rasional: Setelah evaluasi kritis penelitian dilakukan, langkah selanjutnya adalah sintesis informasi dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kondisi spesifik pasien, untuk menghasilkan intervensi berbasis bukti yang tepat.

Kasus 5

Seorang pria, 56 tahun, masuk ruang ICU dengan diagnosis infark miokard akut (IMA). Intervensi berbasis bukti telah diimplementasikan selama 24 jam terakhir,

berupa pemberian terapi antikoagulan dan analgesik. Langkah berikutnya yang wajib dilakukan perawat sesuai prinsip analisis kasus berbasis bukti adalah:

- A. Menghentikan intervensi untuk mengobservasi respons alami pasien
- B. Melanjutkan intervensi tanpa evaluasi tambahan
- C. Melakukan evaluasi efektivitas intervensi secara berkala dan objektif
- D. Melakukan identifikasi masalah klinis kembali
- E. Mengimplementasikan intervensi tambahan tanpa evaluasi

Kunci jawaban: C

Rasional: Setelah implementasi intervensi, perawat harus melakukan evaluasi efektivitas intervensi secara berkala, menggunakan indikator klinis yang objektif agar dapat menentukan apakah intervensi perlu dilanjutkan, dihentikan, atau dimodifikasi.

G. Rangkuman Materi

Analisis kasus dalam keperawatan kritis merupakan proses sistematis yang sangat penting dalam mengevaluasi kondisi pasien dengan penyakit kritis yang memerlukan tindakan segera dan intensif. Proses ini melibatkan integrasi mendalam antara data klinis pasien—yang mencakup hasil pemeriksaan fisik, diagnostik, riwayat kesehatan, serta kondisi psikososial—dengan bukti penelitian ilmiah terbaru yang relevan, valid, dan terpercaya. Analisis kasus ini juga mempertimbangkan kondisi lingkungan pelayanan, seperti fasilitas kesehatan, ketersediaan peralatan medis canggih, sumber daya manusia yang kompeten, serta budaya kerja organisasi yang mendukung praktik berbasis bukti.

Pemilihan dan integrasi hasil penelitian menjadi langkah krusial dalam analisis kasus ini. Penelitian dengan desain Randomized Controlled Trials (RCT) dan systematic review diprioritaskan karena memiliki validitas internal dan eksternal yang tinggi, sehingga memberikan keyakinan yang kuat terhadap efektivitas intervensi. Evaluasi kritis terhadap penelitian dilakukan secara mendalam, mencakup validitas internal dan eksternal, ukuran sampel, metode pengumpulan data, serta kekuatan dan kelemahan hasil penelitian, guna memastikan bahwa hanya bukti-bukti terbaik yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.

Metode analisis kasus dalam keperawatan kritis dilakukan melalui tahapan-tahapan terstruktur: identifikasi masalah klinis secara jelas, pengumpulan data klinis secara komprehensif, identifikasi penelitian relevan, evaluasi kritis terhadap hasil penelitian, sintesis informasi untuk menentukan intervensi berbasis bukti, serta implementasi intervensi dengan evaluasi efektivitas secara berkala. Melalui tahapan

ini, intervensi keperawatan yang diberikan dipastikan efektif, aman, dan relevan dengan kebutuhan spesifik pasien.

Pada tahap akhir, rekomendasi intervensi berbasis bukti disusun secara rinci, mencakup prosedur pelaksanaan, indikator evaluasi, dan rencana modifikasi jika diperlukan. Intervensi tersebut selalu dievaluasi secara teratur untuk memastikan efektivitas dan keamanan, serta untuk melakukan penyesuaian sesuai perkembangan kondisi klinis pasien. Dengan demikian, analisis kasus berbasis bukti dalam keperawatan kritis memastikan perawatan yang berkualitas tinggi, aman, efektif, humanistik, serta mampu meningkatkan hasil klinis pasien secara signifikan, sesuai dengan prinsip perawatan modern yang berbasis bukti ilmiah terkini.

H. Glosarium

Analisis kasus:

Proses evaluasi mendalam dan sistematis terhadap kondisi klinis pasien yang kompleks, bertujuan merumuskan intervensi berbasis bukti ilmiah.

Evidence-Based Practice (EBP):

Pendekatan pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti penelitian ilmiah terbaru, pengalaman klinis perawat, preferensi pasien, serta aspek etis dalam praktik keperawatan.

Validitas internal:

Tingkat kepercayaan bahwa hasil penelitian benar-benar menunjukkan hubungan sebab-akibat secara akurat tanpa dipengaruhi bias atau variabel lain yang tidak dikontrol.

Validitas eksternal:

Kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan atau digeneralisasikan pada populasi atau kondisi lain di luar populasi penelitian awal.

Randomized Controlled Trials (RCT):

Desain penelitian eksperimen dengan metode pengacakan partisipan ke dalam kelompok intervensi dan kontrol, dianggap sebagai standar tertinggi untuk validitas internal.

Systematic review:

Kajian ilmiah yang secara sistematis menggabungkan hasil dari beberapa penelitian terkait suatu topik tertentu untuk menyajikan kesimpulan yang komprehensif.

Generalisasi:

Kemampuan menerapkan hasil penelitian pada populasi atau kondisi lain yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi yang diteliti.

Komorbiditas:

Kondisi medis tambahan atau penyakit yang dialami pasien bersamaan dengan penyakit utama, yang dapat mempengaruhi pengelolaan klinis.

Reliabilitas:

Konsistensi hasil penelitian apabila pengukuran atau penelitian tersebut dilakukan berulang pada kondisi atau situasi yang serupa.

Pengkajian fisik:

Pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik pasien, mencakup pemeriksaan tanda vital, status sistem tubuh, dan observasi klinis.

Data subjektif:

Informasi atau data yang diperoleh berdasarkan persepsi atau pernyataan pasien, seperti keluhan nyeri atau rasa tidak nyaman.

Data objektif:

Informasi yang diperoleh melalui pengukuran atau observasi langsung oleh tenaga medis, seperti tekanan darah, hasil laboratorium, dan tanda-tanda fisik lainnya.

Evaluasi kritis:

Penilaian yang teliti dan sistematis terhadap kualitas metodologis, validitas, relevansi, serta keandalan hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar keputusan klinis.

Sintesis informasi:

Proses integrasi secara logis dan sistematis dari berbagai sumber informasi atau bukti ilmiah untuk merumuskan intervensi yang paling efektif dan sesuai kondisi pasien.

Intervensi berbasis bukti:

Tindakan keperawatan yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terbaru, divalidasi melalui evaluasi kritis, dan disesuaikan dengan kondisi serta preferensi pasien.

Implementasi intervensi:

Proses penerapan tindakan atau prosedur keperawatan yang telah dirancang secara sistematis berdasarkan bukti ilmiah untuk mencapai tujuan klinis tertentu.

Evaluasi efektivitas intervensi:

Penilaian berkala terhadap respons pasien terhadap intervensi yang diberikan, menggunakan indikator klinis objektif dan subjektif.

Modifikasi intervensi:

Penyesuaian atau perubahan intervensi yang dilakukan apabila evaluasi efektivitas menunjukkan bahwa intervensi awal tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Outcome klinis:

Hasil akhir dari suatu intervensi yang mencerminkan perubahan atau perbaikan kondisi klinis pasien, mencakup aspek fisiologis, psikologis, dan sosial.

Protokol keperawatan:

Panduan terstruktur yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah pelaksanaan intervensi keperawatan tertentu berdasarkan bukti ilmiah.

Budaya organisasi berbasis bukti:

Lingkungan kerja yang mendukung dan memfasilitasi penerapan praktik berbasis bukti melalui penyediaan sumber daya, pelatihan, akses terhadap literatur ilmiah, dan kolaborasi antarprofesi.

I. Daftar Pustaka

- LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2021). *Nursing research: Methods and critical appraisal for evidence-based practice* (10th ed.). Elsevier.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2022). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Urden, L. D., Stacy, K. M., & Lough, M. E. (2021). *Critical care nursing: Diagnosis and management* (9th ed.). Elsevier.

BAB 3

PERAN DAN FUNGSI ADVOKASI PERAWAT PADA KASUS KRITIS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menunjukkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam menjalankan peran advokasi secara profesional, berdasarkan prinsip-prinsip etika, komunikasi terapeutik, serta pendekatan berbasis bukti dalam keperawatan kritis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan prinsip advokasi perawat secara efektif dalam kasus-kasus kritis, dengan mempertimbangkan aspek etik, hukum, psikososial, dan klinis pasien.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar advokasi dalam keperawatan kritis secara komprehensif.
- Mengidentifikasi peran spesifik perawat dalam advokasi pasien kritis.
- Menjelaskan fungsi advokasi perawat dalam melindungi hak-hak pasien kritis.
- Menganalisis isu-isu etika dan hukum dalam menjalankan advokasi pada kasus kritis.
- Mengaplikasikan keterampilan komunikasi efektif dalam praktik advokasi keperawatan kritis.

Pendahuluan

Keperawatan kritis merupakan salah satu bidang pelayanan kesehatan yang kompleks dan multidimensional, di mana pasien sering kali berada dalam kondisi kesehatan yang tidak stabil, membutuhkan tindakan medis intensif serta berisiko tinggi mengalami komplikasi serius. Dalam situasi ini, perawat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi asuhan klinis, namun juga memiliki peran penting sebagai advokat bagi pasien. Advokasi dalam keperawatan kritis menempatkan perawat sebagai pembela hak pasien, pemberi suara bagi kebutuhan pasien, serta fasilitator komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Peran ini sangat vital, mengingat pasien kritis sering kali tidak mampu menyuarakan kebutuhan mereka sendiri akibat kondisi medis yang dialami. Bab ini akan membahas secara rinci peran dan fungsi advokasi perawat dalam konteks kasus kritis.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Advokasi dalam Keperawatan Kritis

Konsep dasar advokasi dalam keperawatan kritis merupakan landasan esensial yang melandasi praktik keperawatan untuk melindungi, mewakili, serta memperjuangkan hak dan kebutuhan pasien yang tengah berada dalam kondisi kritis. Pasien dengan kondisi kritis sering kali mengalami berbagai hambatan fisik, psikologis, maupun kognitif yang menyulitkan mereka dalam menyampaikan kebutuhan dan keputusan secara jelas dan langsung. Pasien-pasien ini mungkin tidak mampu berkomunikasi secara efektif karena berbagai faktor seperti intubasi, sedasi, penurunan kesadaran, atau ketidakmampuan fisik lainnya akibat kondisi medis yang mereka alami. Dalam kondisi semacam ini, peran perawat sebagai advokat menjadi krusial untuk memastikan bahwa pasien menerima pelayanan yang optimal, menghormati martabat manusia, serta melindungi hak-hak dasar mereka.

Advokasi dalam konteks keperawatan kritis mencakup beberapa aspek penting yang bersifat holistik. Pertama, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik pasien terpenuhi secara optimal melalui identifikasi yang akurat, penilaian komprehensif, dan komunikasi efektif dengan tim medis multidisiplin. Perawat perlu memantau secara ketat kondisi pasien, memastikan bahwa tindakan dan terapi medis yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan klinis pasien, serta mengadvokasi intervensi tambahan atau revisi terapi jika dinilai perlu.

Kedua, advokasi dalam keperawatan kritis juga melibatkan aspek psikologis dan emosional. Pasien kritis sering mengalami kecemasan, stres, ketakutan, bahkan depresi yang mendalam akibat situasi ketidakpastian dan ancaman terhadap kehidupan mereka. Perawat sebagai advokat bertugas untuk mendukung pasien secara emosional melalui interaksi empati, komunikasi terapeutik, serta penguatan mental dan emosional yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan selama pasien menjalani perawatan intensif.

Lebih lanjut, konsep advokasi juga menitikberatkan pada aspek etika dan hukum dalam praktik keperawatan. Dalam hal ini, perawat harus mampu memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesional, seperti otonomi pasien, keadilan, beneficence (berbuat baik), dan non-maleficence (tidak merugikan). Dalam konteks ini, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mengenai pengobatan pasien dilakukan secara terbuka, transparan, dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik pasien, serta memastikan bahwa hak pasien untuk memberikan persetujuan yang terinformasi (informed consent) terpenuhi dengan benar.

Selain itu, peran advokasi dalam keperawatan kritis juga mencakup perlindungan terhadap hak pasien dalam mendapatkan informasi kesehatan yang jelas dan mudah dipahami. Pasien kritis dan keluarga mereka memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas mengenai kondisi kesehatan pasien, prognosis, pilihan pengobatan yang tersedia, risiko dan manfaat setiap intervensi, serta potensi hasil yang mungkin diperoleh. Dalam konteks ini, perawat bertindak sebagai jembatan komunikasi antara tim medis dan pasien atau keluarga, memastikan informasi disampaikan secara jelas, akurat, dan empati sehingga pasien dan keluarga dapat membuat keputusan yang tepat dan berbasis informasi.

Terakhir, advokasi dalam keperawatan kritis tidak terbatas hanya pada pasien itu sendiri, tetapi juga mencakup dukungan terhadap keluarga pasien. Keluarga sering kali berada dalam kondisi stres tinggi, menghadapi tekanan emosional yang besar, dan membutuhkan informasi serta dukungan emosional secara terus-menerus. Perawat bertugas untuk memberikan edukasi, mendampingi keluarga dalam proses pengambilan keputusan yang sulit, serta membantu keluarga dalam memahami kondisi pasien dan intervensi medis yang diperlukan.

Dengan demikian, advokasi dalam keperawatan kritis adalah suatu konsep yang mencakup pendekatan menyeluruh, menempatkan pasien sebagai pusat perhatian, dan melibatkan keterampilan komunikasi, empati, pengetahuan klinis, serta pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai etika dan hukum untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan pasien kritis selalu terpenuhi dan terlindungi secara optimal.

B. Peran Perawat dalam Advokasi Pasien Kritis

Peran perawat dalam advokasi pasien kritis merupakan komponen yang sangat penting dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, holistik, dan berorientasi pada kebutuhan individu. Pasien kritis menghadapi kondisi kesehatan yang serius, kompleks, dan sering kali mengancam nyawa, sehingga tidak mampu secara penuh menyampaikan kebutuhan atau preferensi mereka secara mandiri. Dalam situasi ini, perawat memainkan berbagai peran sentral yang mencakup mediator, fasilitator komunikasi, pembela hak pasien, serta edukator bagi keluarga pasien.

Sebagai mediator, perawat bertindak sebagai penghubung penting antara pasien, keluarga, dan tim medis multidisiplin. Perawat bertanggung jawab untuk menyelaraskan perspektif berbagai pihak yang terlibat, khususnya dalam situasi di mana terdapat ketegangan atau perbedaan pandangan mengenai rencana perawatan dan keputusan medis. Misalnya, saat terdapat dilema etik tentang

keputusan akhir kehidupan, perawat sebagai mediator berperan dalam membantu keluarga dan tim medis memahami pandangan masing-masing pihak, menjembatani komunikasi agar tercapai solusi yang menghormati martabat pasien, serta sesuai dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, sebagai fasilitator komunikasi, perawat memegang peran penting dalam memastikan bahwa informasi klinis tentang kondisi pasien, pilihan terapi, prognosis, serta potensi komplikasi disampaikan secara jelas, akurat, dan empati kepada pasien maupun keluarganya. Perawat bertanggung jawab untuk menerjemahkan istilah medis yang kompleks menjadi bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarga, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berbasis informasi. Dalam konteks ini, kemampuan komunikasi terapeutik yang dimiliki perawat sangat penting, di mana perawat harus mampu berkomunikasi dengan penuh empati, mendengarkan secara aktif, serta merespons kekhawatiran pasien dan keluarga dengan cara yang menenangkan dan meyakinkan.

Peran perawat juga mencakup sebagai pembela hak pasien (patient advocate). Dalam konteks ini, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak pasien untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang aman, efektif, dan bermartabat selalu terlindungi. Perawat harus sigap mengenali potensi situasi yang dapat merugikan pasien, seperti tindakan medis yang kurang tepat atau berisiko tinggi tanpa persetujuan yang jelas, dan secara aktif berpartisipasi dalam diskusi tim medis untuk memastikan pasien tidak mendapatkan tindakan yang merugikan. Perawat juga berperan dalam memastikan bahwa setiap keputusan medis didasarkan pada prinsip etika seperti otonomi pasien, beneficence, dan non-maleficence. Dalam praktiknya, hal ini mungkin mencakup intervensi langsung dengan tim medis atau manajemen rumah sakit untuk memperjuangkan keputusan yang benar-benar mengutamakan kepentingan pasien.

Sebagai edukator, perawat bertugas memberikan pendidikan kesehatan yang komprehensif kepada keluarga pasien kritis. Kondisi pasien kritis sering kali membuat keluarga merasa cemas, bingung, atau tidak berdaya karena kurangnya pemahaman tentang situasi kesehatan yang sedang dialami pasien. Dalam hal ini, perawat memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi pasien, prosedur medis yang sedang dilakukan, efek samping terapi, serta potensi komplikasi yang mungkin terjadi. Edukasi ini membantu keluarga memahami kondisi pasien secara utuh, sehingga dapat mendukung keluarga dalam mengambil keputusan kesehatan yang tepat dan realistis serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan.

Perawat juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasien secara cermat dan mendetail. Kemampuan untuk mengenali tanda-tanda klinis yang subtil,

perubahan kondisi pasien yang mungkin diabaikan oleh anggota tim medis lainnya, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan temuan ini dengan efektif kepada tim kesehatan, adalah keterampilan yang sangat vital dalam advokasi pasien kritis. Dalam praktiknya, hal ini membutuhkan kewaspadaan klinis yang tinggi, kemampuan pengkajian yang mendalam, serta kompetensi klinis yang mumpuni.

C. Fungsi Advokasi Perawat dalam Melindungi Hak Pasien

Fungsi advokasi perawat dalam melindungi hak pasien merupakan bagian integral dari praktik keperawatan, khususnya dalam perawatan pasien kritis yang rentan terhadap berbagai pelanggaran hak akibat kompleksitas kondisinya. Pasien kritis sering kali mengalami keterbatasan fisik, mental, atau emosional yang membuat mereka tidak dapat secara efektif memperjuangkan atau mempertahankan hak mereka secara mandiri. Dalam situasi inilah peran advokasi perawat menjadi sangat penting dan sentral.

Salah satu fungsi utama advokasi perawat dalam melindungi hak pasien kritis adalah memastikan hak pasien untuk memperoleh informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami. Pasien dan keluarga memiliki hak penuh untuk mengetahui secara detail kondisi pasien, jenis penyakit, tindakan medis yang direncanakan, prognosis atau kemungkinan hasil dari tindakan tersebut, risiko dan manfaat terapi, serta alternatif lain yang tersedia. Dalam kapasitas ini, perawat bertindak sebagai penghubung antara tim medis dan pasien atau keluarganya, memastikan bahwa komunikasi mengenai informasi medis tidak hanya jelas dan lengkap, tetapi juga disampaikan dengan bahasa yang empatik dan menghargai martabat manusia. Hal ini bertujuan agar pasien atau keluarganya mampu mengambil keputusan yang terinformasi (*informed consent*), sehingga mereka memiliki kendali atas keputusan kesehatan yang akan diambil.

Selain itu, advokasi perawat berfungsi memastikan bahwa hak pasien atas privasi selalu dihormati. Dalam konteks perawatan pasien kritis, hak atas privasi dapat terancam karena pasien memerlukan perawatan intensif, sering melibatkan banyak tenaga medis, serta lingkungan unit perawatan intensif yang terbuka. Oleh karena itu, perawat harus secara proaktif memastikan bahwa privasi pasien terlindungi selama proses pemberian perawatan. Hal ini mencakup menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, menjaga martabat pasien selama tindakan medis yang invasif, serta memastikan lingkungan fisik perawatan diatur sedemikian rupa agar privasi dan kenyamanan pasien tetap terjaga.

Selanjutnya, advokasi perawat dalam konteks ini juga berfungsi untuk melindungi hak pasien dalam menentukan pilihan untuk menerima atau menolak

pengobatan. Setiap pasien, termasuk pasien kritis, memiliki hak untuk menerima atau menolak setiap intervensi medis yang ditawarkan kepadanya setelah diberikan penjelasan yang memadai tentang risiko dan manfaatnya. Fungsi perawat dalam hal ini mencakup mendukung dan menguatkan hak otonomi pasien dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil pasien atau keluarga dilakukan atas dasar informasi yang lengkap dan bukan karena tekanan atau paksaan dari pihak lain. Perawat juga bertugas memastikan bahwa tim medis menghormati dan menjalankan keputusan pasien secara konsisten, bahkan dalam situasi yang kompleks sekalipun.

Lebih lanjut, perawat memiliki fungsi advokasi penting dalam melindungi pasien dari tindakan medis yang tidak perlu atau berlebihan. Dalam praktik klinis, khususnya di unit perawatan intensif, sering kali terjadi kecenderungan pemberian terapi agresif yang dapat meningkatkan risiko komplikasi tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi pasien. Fungsi advokasi perawat adalah memastikan bahwa setiap intervensi medis yang diberikan benar-benar memiliki manfaat klinis yang jelas bagi pasien dan dilakukan berdasarkan indikasi medis yang kuat, bukan hanya sebagai prosedur rutin atau karena alasan lain yang tidak relevan secara klinis. Dalam situasi tertentu, perawat bertugas mengintervensi atau berdiskusi langsung dengan tim medis guna mencegah tindakan yang dapat merugikan pasien, serta memastikan bahwa setiap tindakan didasarkan pada prinsip keadilan, kebaikan (beneficence), serta menghindari bahaya (non-maleficence).

Di samping itu, fungsi advokasi perawat mencakup tanggung jawab melindungi pasien dari diskriminasi atau perlakuan tidak adil akibat faktor seperti usia, ras, latar belakang sosial ekonomi, agama, atau status kesehatan tertentu. Perawat harus memastikan bahwa semua pasien kritis mendapatkan perlakuan yang setara, layak, serta bebas dari diskriminasi apa pun dalam pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, fungsi advokasi perawat dalam melindungi hak pasien mencakup berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada melindungi hak-hak pasien yang bersifat fisik atau medis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak psikososial, emosional, dan etis pasien. Dengan menjalankan fungsi advokasi secara optimal, perawat dapat memastikan bahwa pasien kritis menerima perawatan yang aman, efektif, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai etika keperawatan serta prinsip hak asasi manusia. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kualitas perawatan, kepuasan pasien dan keluarga, serta keberhasilan hasil akhir dari intervensi medis yang diberikan.

D. Isu Etika dan Hukum dalam Advokasi

Isu etika dan hukum dalam advokasi perawat di bidang keperawatan kritis merupakan aspek yang kompleks, dinamis, serta membutuhkan pemahaman mendalam karena sangat terkait erat dengan berbagai keputusan penting yang berdampak langsung terhadap kehidupan pasien. Advokasi dalam keperawatan kritis bukan hanya tentang memastikan hak pasien terpenuhi secara teknis, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai nilai, prinsip moral, serta peraturan hukum yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap kerangka etika dan hukum adalah kunci penting bagi perawat dalam menjalankan advokasi yang efektif, bertanggung jawab, dan profesional.

Salah satu isu etik yang paling sering ditemui dalam praktik advokasi adalah pengambandilema dalam keputusan akhir kehidupan (end-of-life decisions). Pasien kritis seringkali berada dalam kondisi yang sangat berat, di mana prognosis mereka tidak jelas, dan terapi lanjutan mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan. Di sini, perawat menghadapi dilema etik yang mendalam antara prinsip menghargai kehidupan (sanctity of life) dan prinsip untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu atau menjaga kualitas hidup pasien (quality of life). Dalam kondisi seperti ini, perawat berperan penting sebagai advokat yang membantu keluarga dan tim medis dalam mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia, memfasilitasi komunikasi efektif, serta memastikan bahwa keputusan akhir diambil berdasarkan prinsip etika, terutama menghormati otonomi pasien dan keluarga serta memastikan tidak ada penderitaan tambahan yang tidak perlu (non-maleficence).

Selanjutnya, informed consent atau persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien setelah memperoleh informasi secara lengkap merupakan isu etika dan hukum yang sangat penting dalam konteks advokasi perawat. Secara hukum dan etik, setiap pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang tindakan medis yang akan mereka terima, termasuk risiko, manfaat, dan alternatif terapi lainnya. Namun, dalam situasi pasien kritis, sering kali pasien tidak mampu secara langsung memberikan persetujuan akibat gangguan kesadaran atau kondisi medis yang berat. Di sinilah perawat sebagai advokat memainkan peran penting untuk memastikan bahwa keluarga atau wali sah pasien menerima semua informasi secara lengkap dan memahami konsekuensi tindakan medis yang diajukan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik pasien dan menghormati prinsip otonomi serta hukum yang berlaku.

Isu distribusi sumber daya yang terbatas juga merupakan tantangan besar dalam advokasi di lingkungan perawatan kritis. Perawat kerap dihadapkan pada situasi di mana ketersediaan sumber daya medis, seperti tempat tidur unit perawatan intensif (ICU), alat bantu napas, ventilator, atau obat-obatan khusus, sangat terbatas dibandingkan jumlah pasien yang membutuhkan. Dalam kondisi tersebut, perawat dapat menghadapi dilema moral yang signifikan, yaitu memilih pasien mana yang mendapat prioritas untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Di sini, perawat sebagai advokat harus memahami prinsip-prinsip etika distribusi yang adil (*justice*), termasuk pertimbangan medis yang obyektif, prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, serta prinsip-prinsip moral lainnya seperti kebutuhan pasien, prognosis, dan manfaat klinis potensial dari intervensi medis yang diberikan. Dalam konteks ini, perawat perlu secara aktif berpartisipasi dalam diskusi multidisiplin, menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan secara etik, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat transparan, obyektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pemahaman terhadap aspek hukum dalam advokasi juga merupakan kewajiban mendasar yang harus dikuasai perawat. Kerangka hukum mencakup undang-undang dan peraturan yang mengatur praktik keperawatan, termasuk perlindungan hukum terhadap pasien, kewajiban hukum terkait *informed consent*, kewajiban menjaga kerahasiaan pasien, serta batasan tanggung jawab hukum dari setiap tindakan perawat. Perawat sebagai advokat harus mampu mengintegrasikan pengetahuan tentang aspek hukum ini dalam praktik sehari-hari agar tidak hanya melindungi pasien tetapi juga melindungi diri sendiri dan institusi dari potensi masalah hukum. Misalnya, jika terjadi perselisihan mengenai keputusan akhir kehidupan, perawat harus memahami batasan hukum tentang penghentian terapi suportif atau terapi aktif lainnya, serta prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam konteks advokasi yang bersifat lintas budaya, perawat juga perlu memahami kerangka etik dan hukum dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai budaya, agama, atau tradisi keluarga pasien dapat berpengaruh besar terhadap keputusan-keputusan etis yang diambil, terutama terkait dengan keputusan akhir kehidupan atau penggunaan terapi tertentu. Oleh karena itu, perawat harus peka dan responsif terhadap konteks budaya pasien, serta mampu melakukan negosiasi secara etis untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai budaya pasien sekaligus memenuhi kewajiban etika dan hukum profesional.

E. Keterampilan Komunikasi Efektif dalam Advokasi

Keterampilan komunikasi efektif dalam advokasi keperawatan kritis merupakan kemampuan penting yang wajib dimiliki perawat untuk memastikan bahwa proses advokasi berjalan optimal dan memberikan hasil terbaik bagi pasien serta keluarganya. Dalam konteks perawatan kritis, komunikasi menjadi aspek fundamental karena situasi pasien yang kompleks, tekanan emosional yang tinggi, serta keterlibatan berbagai pihak seperti tim medis multidisiplin, keluarga pasien, dan pihak lainnya. Oleh karena itu, perawat perlu menguasai secara mendalam berbagai jenis komunikasi, khususnya komunikasi terapeutik, komunikasi asertif, serta keterampilan negosiasi dan mediasi.

Komunikasi terapeutik adalah teknik komunikasi yang digunakan oleh perawat untuk menciptakan hubungan interpersonal yang efektif, hangat, penuh empati, dan berorientasi pada tujuan terapeutik. Dalam situasi pasien kritis, komunikasi terapeutik sangat penting karena pasien maupun keluarganya sering mengalami kecemasan tinggi, ketakutan, serta ketidakpastian yang mendalam. Perawat yang mahir dalam komunikasi terapeutik mampu memberikan dukungan emosional dengan cara mendengarkan secara aktif, memberikan validasi terhadap perasaan pasien dan keluarga, serta menunjukkan empati yang tulus terhadap situasi yang dialami. Teknik ini menciptakan rasa percaya dan hubungan saling pengertian, sehingga pasien dan keluarga merasa dihargai, aman, dan didukung secara emosional dalam menghadapi situasi yang sulit.

Komunikasi terapeutik juga melibatkan penggunaan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pasien maupun keluarganya. Perawat perlu secara cermat menghindari istilah-istilah medis yang terlalu teknis atau rumit tanpa penjelasan yang memadai, karena hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Sebaliknya, perawat harus mampu menyampaikan informasi medis penting, termasuk prognosis, risiko terapi, dan alternatif pengobatan, dengan bahasa yang lugas dan empatik, sehingga pasien atau keluarga dapat membuat keputusan kesehatan yang terinformasi dengan baik.

Selanjutnya, komunikasi asertif juga merupakan keterampilan penting dalam advokasi. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, serta hak pasien secara jelas, langsung, tegas namun tetap menghargai dan menghormati pandangan orang lain. Dalam konteks perawatan pasien kritis, komunikasi asertif sangat diperlukan ketika perawat menghadapi situasi yang menuntut pengambilan keputusan cepat, atau ketika terdapat perbedaan pendapat dengan anggota tim medis mengenai pilihan terapi atau intervensi tertentu. Dengan komunikasi asertif, perawat mampu mengartikulasikan kebutuhan pasien secara

jelas dan meyakinkan, serta mampu mempertahankan argumen secara objektif dan profesional tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Hal ini akan membantu memastikan bahwa suara pasien benar-benar terdengar dan dihormati dalam setiap keputusan klinis yang dibuat.

Keterampilan negosiasi juga merupakan komponen komunikasi penting dalam advokasi keperawatan kritis. Dalam situasi klinis, perawat sering kali menghadapi berbagai pandangan atau preferensi yang bertentangan dari pasien, keluarga, atau anggota tim medis lainnya. Untuk mencapai keputusan bersama yang optimal, perawat harus mampu bernegosiasi secara efektif. Dalam proses ini, perawat perlu menunjukkan empati terhadap semua pihak yang terlibat, mengidentifikasi secara jelas kebutuhan dan tujuan bersama, serta mengelola perbedaan pendapat dengan cara yang produktif dan profesional. Kemampuan ini membantu mengurangi potensi konflik, menciptakan suasana kolaboratif, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan terbaik pasien.

Selain keterampilan negosiasi, keterampilan mediasi juga tidak kalah penting dalam advokasi keperawatan kritis. Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan perawat sebagai pihak yang netral dan objektif, berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pasien, keluarga, dan tim medis menemukan kesepakatan bersama. Dalam perawatan pasien kritis, mediasi sering kali diperlukan ketika terjadi konflik atau ketidaksepakatan serius mengenai keputusan akhir hidup, pilihan pengobatan, atau prioritas sumber daya. Sebagai mediator, perawat bertanggung jawab memastikan bahwa setiap pihak dapat mengungkapkan pandangan secara terbuka, saling memahami perspektif yang berbeda, dan menemukan solusi kompromi yang adil serta menghormati nilai-nilai yang dianut pasien dan keluarganya.

F. Latihan Soal

Soal 1

Seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ICU dalam kondisi koma akibat stroke hemoragik. Tim medis mengusulkan pemasangan ventilator, tetapi keluarga pasien merasa ragu tentang manfaat tindakan tersebut karena prognosisnya buruk. Sebagai perawat advokat, langkah terbaik yang harus Anda lakukan adalah:

- A. Menyarankan keluarga mengikuti saran dokter tanpa diskusi lebih lanjut
- B. Memfasilitasi pertemuan keluarga dengan tim medis untuk berdiskusi lebih mendalam
- C. Memutuskan sendiri demi keselamatan pasien

- D. Memaksa keluarga menyetujui tindakan karena kondisi pasien kritis
- E. Menghindari diskusi untuk mencegah konflik emosional

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Perawat sebagai advokat berperan memediasi komunikasi antara keluarga dan tim medis. Pertemuan bersama memungkinkan diskusi yang terbuka, transparan, dan berbasis informasi sehingga keputusan terbaik yang menghormati otonomi dan hak pasien dapat diambil.

Soal 2

Seorang pasien perempuan berusia 40 tahun dirawat di ICU pasca operasi besar. Pasien tersebut tampak sangat cemas, sulit tidur, dan emosional. Keluarga pasien juga merasa stres akibat kondisi pasien. Sebagai perawat advokat, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah:

- A. Membatasi kunjungan keluarga agar pasien bisa beristirahat
- B. Menyediakan obat tidur tanpa konsultasi lebih lanjut
- C. Melibatkan tim psikolog untuk memberikan dukungan tambahan
- D. Mengabaikan kecemasan karena dianggap wajar dalam kondisi kritis
- E. Menginstruksikan keluarga agar tidak menunjukkan kecemasan di depan pasien

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Kecemasan emosional pasien perlu diatasi melalui pendekatan holistik. Sebagai advokat, perawat bertanggung jawab mengintegrasikan dukungan psikologis dengan tim multidisiplin, memastikan pasien dan keluarganya mendapatkan dukungan emosional yang memadai.

Soal 3

Seorang pasien kritis dengan penurunan kesadaran direncanakan mendapatkan tindakan medis invasif oleh tim medis tanpa informasi lengkap kepada keluarganya. Sebagai advokat pasien, tindakan yang harus dilakukan perawat adalah:

- A. Membiarkan dokter mengambil keputusan penuh karena pasien tidak sadar
- B. Segera mendiskusikan dengan tim medis tentang pentingnya informed consent kepada keluarga
- C. Menandatangani persetujuan tindakan mewakili pasien tanpa berdiskusi dengan keluarga
- D. Menunda tindakan sampai pasien sadar kembali
- E. Tidak terlibat karena dianggap bukan tanggung jawab perawat

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Perawat wajib memastikan bahwa informed consent diperoleh sebelum tindakan medis invasif. Jika pasien tidak mampu, maka keluarga harus menerima informasi lengkap tentang tindakan medis tersebut sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan otonomi dan hak pasien.

Soal 4

Di sebuah ICU, terdapat dua pasien kritis yang membutuhkan ventilator, namun hanya ada satu ventilator tersedia. Pasien pertama memiliki prognosis buruk, sedangkan pasien kedua memiliki prognosis yang lebih baik. Sebagai perawat advokat, tindakan Anda yang paling tepat dalam situasi ini adalah:

- A. Memberikan ventilator pada pasien yang datang lebih dulu
- B. Menghindari terlibat dalam pengambilan keputusan untuk menghindari konflik
- C. Mengambil keputusan sendiri berdasarkan kedekatan emosional dengan pasien
- D. Berpartisipasi aktif dalam diskusi multidisiplin untuk menentukan pasien yang paling sesuai mendapatkan ventilator berdasarkan prinsip etika
- E. Memberikan ventilator secara bergiliran antara kedua pasien

Kunci Jawaban: D**Rasional:**

Dalam situasi sumber daya terbatas, perawat advokat harus terlibat dalam diskusi multidisiplin yang transparan dan berdasarkan prinsip keadilan, manfaat, dan prognosa klinis yang objektif untuk menentukan prioritas terbaik bagi pasien.

Soal 5

Pasien kritis di ICU merasa khawatir karena informasi yang diberikan dokter sulit dimengerti oleh keluarga, menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Sebagai perawat advokat, komunikasi efektif yang perlu Anda lakukan dalam situasi ini adalah:

- A. Menyampaikan informasi secara detail menggunakan istilah medis
- B. Mengulang informasi dokter tanpa penyesuaian bahasa
- C. Menggunakan bahasa sederhana, jelas, dan empatik dalam menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga
- D. Membatasi informasi agar keluarga tidak panik
- E. Meminta keluarga mencari sendiri informasi tambahan di internet

Kunci Jawaban: C**Rasional:**

Keterampilan komunikasi terapeutik yang efektif mengharuskan perawat menggunakan bahasa sederhana, jelas, empatik agar keluarga benar-benar

memahami kondisi pasien dan mampu mengambil keputusan berbasis informasi dengan nyaman dan percaya diri.

G. Rangkuman Materi

Advokasi dalam keperawatan kritis merupakan suatu konsep mendasar yang menempatkan pasien sebagai fokus utama pelayanan kesehatan, dengan tujuan melindungi, mewakili, serta memperjuangkan hak dan kebutuhan pasien kritis. Pasien kritis sering mengalami keterbatasan fisik, psikologis, atau kognitif yang menyulitkan mereka dalam menyampaikan kebutuhannya secara langsung. Oleh karena itu, peran perawat sebagai advokat menjadi sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan memastikan pasien menerima perawatan optimal sesuai kebutuhan klinis dan psikososialnya.

Perawat menjalankan berbagai peran penting dalam advokasi, yaitu sebagai mediator, fasilitator komunikasi, pembela hak pasien, serta edukator bagi keluarga pasien. Dalam peran ini, perawat harus mampu menyelaraskan pandangan tim medis, pasien, dan keluarga, serta menerjemahkan informasi medis yang kompleks menjadi bahasa sederhana yang mudah dipahami. Perawat juga bertugas memberikan dukungan emosional kepada pasien maupun keluarganya melalui komunikasi terapeutik, asertif, serta keterampilan negosiasi dan mediasi yang efektif.

Fungsi advokasi perawat dalam melindungi hak pasien kritis meliputi pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap (informed consent), perlindungan privasi, serta hak pasien untuk menerima atau menolak tindakan medis tertentu. Perawat juga bertanggung jawab melindungi pasien dari intervensi medis yang tidak perlu, berlebihan, atau merugikan, serta memastikan bahwa pasien diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Dalam melaksanakan advokasi, perawat sering menghadapi berbagai dilema etik dan hukum, seperti keputusan akhir kehidupan, persetujuan tindakan medis (informed consent), serta tantangan distribusi sumber daya terbatas. Oleh karena itu, perawat harus memahami secara mendalam kerangka etika profesional dan hukum yang relevan untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan profesional.

Terakhir, keterampilan komunikasi efektif merupakan komponen esensial dalam advokasi keperawatan kritis. Penguasaan komunikasi terapeutik, asertif, negosiasi, dan mediasi memungkinkan perawat untuk menciptakan hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarganya, serta memastikan bahwa proses advokasi berjalan optimal. Dengan demikian, implementasi advokasi yang efektif dalam praktik keperawatan kritis berdampak signifikan terhadap peningkatan

kualitas perawatan, kepuasan pasien dan keluarga, serta hasil akhir pelayanan kesehatan.

H. Glosarium

Advokasi Keperawatan

Tindakan yang dilakukan perawat untuk melindungi, mewakili, serta memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan pasien, khususnya dalam kondisi kritis yang tidak mampu mengartikulasikan kebutuhan mereka sendiri.

Beneficence

Prinsip etika yang menekankan kewajiban untuk melakukan tindakan yang baik dan memberikan manfaat kepada pasien, dengan memastikan tindakan medis yang diberikan benar-benar memberikan manfaat klinis.

Depresi

Kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, putus asa, atau kehilangan minat dan motivasi, yang sering dialami oleh pasien kritis akibat kondisi kesehatan yang mengancam nyawa.

Dilema Etik

Situasi kompleks di mana perawat dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang bertentangan, misalnya dalam keputusan akhir kehidupan, di mana setiap pilihan memiliki implikasi etika yang signifikan.

Fasilitator Komunikasi

Peran perawat dalam memastikan komunikasi yang efektif dan jelas antara pasien, keluarga, dan tim medis, serta menerjemahkan informasi medis yang kompleks menjadi bahasa sederhana yang mudah dipahami.

Hak Privasi

Hak pasien untuk menjaga kerahasiaan informasi medis, martabat pribadi, serta perlindungan terhadap paparan yang tidak perlu selama perawatan intensif di ICU.

Informed Consent

Persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau keluarga setelah menerima penjelasan yang lengkap dan jelas tentang diagnosis, prosedur medis, risiko, manfaat, serta alternatif terapi yang tersedia.

Keadilan (Justice)

Prinsip etika yang memastikan setiap pasien mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif dalam distribusi sumber daya medis, seperti ventilator atau perawatan ICU.

Komunikasi Asertif

Teknik komunikasi yang digunakan perawat untuk secara jelas dan langsung menyampaikan kebutuhan atau hak pasien secara tegas namun tetap menghormati pandangan pihak lain, khususnya dalam situasi kritis yang memerlukan keputusan cepat.

Komunikasi Terapeutik

Teknik komunikasi interpersonal yang digunakan perawat untuk memberikan dukungan emosional, empati, dan rasa percaya kepada pasien serta keluarganya, bertujuan mengurangi kecemasan dan meningkatkan kenyamanan selama perawatan.

Kondisi Kritis

Kondisi kesehatan pasien yang serius dan kompleks, seringkali mengancam nyawa serta membutuhkan perawatan intensif yang ketat dengan intervensi medis yang agresif dan terus-menerus.

Mediator

Peran perawat dalam menjembatani komunikasi serta menyelaraskan perbedaan pandangan antara pasien, keluarga, dan tim medis untuk mencapai kesepakatan bersama yang terbaik bagi pasien.

Mediasi

Proses negosiasi atau penyelesaian konflik yang melibatkan perawat sebagai pihak netral, bertugas memfasilitasi dialog terbuka antara berbagai pihak yang memiliki pandangan bertentangan terkait keputusan perawatan.

Non-maleficence

Prinsip etika yang menegaskan bahwa tindakan yang diberikan kepada pasien tidak boleh merugikan atau menyebabkan penderitaan tambahan yang tidak perlu.

Otonomi Pasien

Hak pasien untuk membuat keputusan secara mandiri terkait penerimaan atau penolakan intervensi medis, berdasarkan informasi lengkap yang diberikan oleh tim kesehatan.

Patient Advocate (Pembela Hak Pasien)

Peran perawat dalam memastikan perlindungan hak-hak pasien secara aktif, termasuk intervensi langsung untuk mencegah tindakan medis yang tidak perlu atau berlebihan yang dapat merugikan pasien.

Pengkajian Komprehensif

Proses penilaian kondisi pasien secara mendalam yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, serta spiritual guna memastikan intervensi medis yang diberikan sesuai dengan kebutuhan aktual pasien.

Prinsip Etika Profesional

Standar moral yang melandasi tindakan profesional perawat, termasuk beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), keadilan, dan menghormati otonomi pasien.

Prognosis

Prediksi atau perkiraan tentang perkembangan penyakit atau hasil akhir dari tindakan medis tertentu, yang penting dikomunikasikan secara jelas kepada pasien dan keluarganya.

Sedasi

Penggunaan obat-obatan untuk menurunkan kesadaran pasien secara medis, yang sering menyebabkan pasien tidak mampu berkomunikasi atau memberikan persetujuan secara langsung.

Teknik Negosiasi

Keterampilan perawat dalam mengelola perbedaan pandangan secara profesional, berempati, serta berorientasi pada solusi kompromi terbaik bagi pasien dan keluarganya, terutama dalam situasi kritis dan konflik.

I. Daftar Pustaka

- Alexis, O., Cooke, J., Shimumbi, L., & Worsley, A. (2022). The role of the nurse advocate in health and social care. *Mediterranean Nursing and Midwifery*, XX(X), 1–7.
- Kalaitzidis, E., & Jewell, P. (2015). The concept of advocacy in nursing: A critical analysis. *The Health Care Manager*, 34(4), 308–315.
- Kwame, A., & Petrucka, P. M. (2021). A literature-based study of patient-centered care and communication in nurse-patient interactions: Barriers, facilitators, and the way forward. *BMC Nursing*, 20, Article 158.
- Registered nurses' description of patient advocacy in the clinical setting. (2018). PubMed Central.
- Shah, P., Thornton, I., Turrin, D., & Hipskind, J. E. (2022). Informed consent. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- The role of advocacy in critical care nursing. (1998). *Intensive and Critical Care Nursing*, 14(3), 112-117.
- Woolley, S., et al. (2024). Existential advocacy in nursing care: A concept analysis. *Journal of Nursing Insight*, 2024.

BAB 4

PENDIDIKAN KESEHATAN PADA KASUS KRITIS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pendidikan kesehatan secara efektif dan empatik kepada pasien dan keluarga dalam kasus kritis untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi aktif, dan mendukung proses pemulihan yang optimal berdasarkan prinsip etik, legal, dan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan pendidikan kesehatan secara komprehensif kepada pasien kritis dan keluarga, serta mampu mengevaluasi efektivitas pendidikan yang diberikan berdasarkan prinsip evidence-based practice.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar dan prinsip pendidikan kesehatan pada kasus kritis.
- Mengidentifikasi kebutuhan edukasi pasien kritis dan keluarganya secara individual.
- Menerapkan strategi komunikasi efektif dalam memberikan pendidikan kesehatan pada pasien kritis dan keluarga.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil pendidikan kesehatan yang diberikan.

Pendahuluan

Pendidikan kesehatan merupakan aspek integral dalam pelayanan keperawatan kritis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai kondisi kritis yang dialami serta membantu mereka dalam pengambilan keputusan perawatan yang tepat. Pasien kritis menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional, yang memerlukan penjelasan jelas serta dukungan edukatif yang memadai. Pendidikan kesehatan yang efektif berperan penting dalam mengurangi kecemasan, meningkatkan kemampuan adaptasi keluarga, serta memastikan partisipasi aktif pasien dan keluarga dalam proses pengobatan dan pemulihan.

Dalam konteks perawatan intensif, pendidikan kesehatan mencakup berbagai hal penting, seperti penjelasan tentang kondisi klinis, prosedur medis yang dilakukan, komplikasi potensial, dan tindakan pencegahan. Oleh karena itu, perawat kritis harus menguasai teknik komunikasi efektif, empati, dan keterampilan edukasi khusus yang dapat membantu pasien dan keluarga memahami kondisi kesehatan secara komprehensif.

A. Konsep Dasar dan Prinsip Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan dalam konteks keperawatan pasien kritis merupakan proses pemberian informasi secara sistematis, jelas, tepat, dan mudah dipahami kepada pasien dan keluarganya mengenai kondisi kesehatan, rencana perawatan, dan potensi komplikasi yang dapat muncul. Proses ini menjadi esensial dalam perawatan pasien kritis, karena kondisi pasien yang sering kali berada dalam keadaan yang rentan secara fisik, psikologis, dan emosional. Pendidikan kesehatan bertujuan untuk memberdayakan pasien dan keluarganya dengan pengetahuan yang memadai agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat, berpartisipasi aktif dalam proses perawatan, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan kondisi kesehatan pasien.

Salah satu prinsip utama dalam pendidikan kesehatan pada pasien kritis adalah transparansi informasi. Transparansi merujuk pada kejelasan, keterbukaan, serta penyampaian informasi yang benar dan sesuai fakta mengenai status kesehatan pasien. Informasi tersebut mencakup diagnosis yang dialami pasien, hasil pemeriksaan penunjang, tindakan medis yang direncanakan, serta risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Prinsip transparansi menuntut profesional keperawatan untuk menyampaikan informasi tanpa menutupi fakta, namun tetap mempertimbangkan kondisi psikologis pasien dan keluarganya agar penyampaian informasi tidak menimbulkan kecemasan atau ketakutan berlebih. Dengan transparansi, pasien dan keluarga memiliki persepsi yang realistis terhadap kondisi kesehatan dan mampu membuat keputusan yang terinformasi mengenai perawatan yang diberikan.

Prinsip lainnya yang tidak kalah penting dalam pendidikan kesehatan adalah penghormatan terhadap otonomi pasien dan keluarganya. Penghormatan terhadap otonomi berarti menghargai hak pasien dan keluarganya untuk mengetahui segala informasi terkait kondisi kesehatan, dan juga menghormati keputusan yang mereka ambil berdasarkan informasi tersebut. Otonomi ini sangat penting dalam konteks pasien kritis karena keputusan yang diambil biasanya berdampak signifikan terhadap kualitas hidup dan kondisi pasien. Perawat sebagai pendidik memiliki kewajiban untuk menyediakan semua informasi yang dibutuhkan, termasuk opsi perawatan dan intervensi yang tersedia, sehingga pasien dan keluarganya dapat mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh eksternal. Prinsip ini menekankan bahwa pasien dan keluarga merupakan bagian integral dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap tindakan

medis yang diambil selalu mendapat persetujuan yang didasari oleh pemahaman yang baik.

Pendekatan holistik merupakan prinsip penting berikutnya dalam pendidikan kesehatan, khususnya dalam konteks keperawatan pasien kritis. Pendekatan holistik berarti melihat pasien tidak hanya sebagai individu dengan kondisi fisik tertentu, tetapi sebagai kesatuan yang utuh yang melibatkan aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan kesehatan holistik mempertimbangkan bahwa kondisi kritis tidak hanya mempengaruhi pasien secara fisik tetapi juga memberikan dampak signifikan pada aspek psikologis dan emosional baik bagi pasien maupun keluarganya. Dengan demikian, edukasi yang diberikan haruslah mencakup informasi yang relevan terhadap kondisi fisik pasien, tetapi juga dukungan emosional, sosial, serta strategi coping yang diperlukan oleh keluarga dalam menghadapi situasi sulit. Selain itu, aspek spiritual juga menjadi pertimbangan penting, di mana pasien dan keluarga mungkin memerlukan pendampingan spiritual sebagai bagian dari dukungan emosional dan psikologis yang diberikan.

Secara keseluruhan, pendidikan kesehatan dalam keperawatan kritis bukan sekedar proses pemberian informasi medis biasa, melainkan interaksi edukatif yang mendalam dan menyeluruh. Prinsip transparansi, penghormatan terhadap otonomi pasien dan keluarga, serta pendekatan holistik menjadi fondasi penting yang memastikan proses edukasi efektif, meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, serta mendukung proses penyembuhan dan adaptasi pasien dan keluarganya terhadap kondisi kritis yang dialami. Dengan demikian, pendidikan kesehatan berkontribusi signifikan pada keberhasilan perawatan pasien kritis, memberikan manfaat yang nyata dalam aspek klinis, psikologis, dan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

B. Identifikasi Kebutuhan Edukasi Pasien dan Keluarga

Identifikasi kebutuhan edukasi pasien dan keluarga merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam proses pendidikan kesehatan, khususnya pada pasien dalam kondisi kritis. Proses ini berfokus pada kegiatan pengkajian menyeluruh yang dilakukan oleh perawat guna memahami secara mendalam kondisi pasien serta kebutuhan edukasi yang tepat bagi pasien dan keluarganya. Pengkajian ini mencakup berbagai aspek penting, yakni kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, yang akan memberikan gambaran komprehensif terkait jenis informasi, metode penyampaian, serta tingkat pemahaman yang diperlukan.

Pada aspek fisik, perawat mengidentifikasi kondisi kesehatan pasien secara detail, seperti diagnosis penyakit, tingkat keparahan kondisi, prosedur medis yang telah dan akan dilakukan, serta potensi komplikasi yang mungkin terjadi. Identifikasi kondisi fisik juga meliputi evaluasi kemampuan fisik pasien dalam menerima edukasi, misalnya apakah pasien dalam kondisi sadar penuh, mampu berkomunikasi dengan efektif, atau justru mengalami hambatan seperti intubasi, ventilasi mekanik, sedasi, atau gangguan kesadaran. Dalam kasus di mana pasien tidak dapat menerima edukasi secara langsung akibat keterbatasan fisik atau medis, maka fokus edukasi akan dialihkan kepada keluarga atau pengasuh utama sebagai penerima utama informasi tersebut.

Pada aspek psikologis, pengkajian dilakukan untuk mengetahui tingkat stres, kecemasan, rasa takut, depresi, maupun kondisi emosional lainnya yang dialami pasien dan keluarga. Kondisi pasien yang kritis seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan, baik bagi pasien sendiri maupun keluarganya. Perawat harus mampu mengenali tanda-tanda stres, kecemasan, atau kondisi emosional lainnya yang mungkin menghambat proses penerimaan informasi secara efektif. Identifikasi kebutuhan edukasi dalam aspek ini bertujuan agar perawat dapat menyesuaikan teknik komunikasi, intensitas, serta kedalaman informasi yang disampaikan, sekaligus memberikan dukungan psikologis yang tepat agar proses edukasi dapat berjalan efektif tanpa memperparah kondisi psikologis pasien dan keluarga.

Aspek sosial juga menjadi perhatian penting dalam pengkajian kebutuhan edukasi. Perawat perlu memahami dinamika keluarga, pola komunikasi yang digunakan dalam keluarga, peran masing-masing anggota keluarga dalam pengambilan keputusan terkait perawatan, serta tingkat literasi atau pemahaman keluarga terhadap kondisi medis yang dialami pasien. Misalnya, dalam keluarga yang sangat mendukung dan terlibat aktif dalam proses perawatan, edukasi yang diberikan mungkin akan lebih efektif jika melibatkan beberapa anggota keluarga secara bersamaan. Sebaliknya, dalam keluarga dengan dinamika yang lebih kompleks atau tingkat pemahaman medis yang terbatas, edukasi perlu diberikan secara lebih bertahap, jelas, sederhana, dan disesuaikan dengan kapasitas pemahaman keluarga.

Selain aspek fisik, psikologis, dan sosial, aspek spiritual juga perlu diperhatikan. Kebutuhan spiritual sering kali menjadi sumber kekuatan penting bagi pasien dan keluarga dalam menghadapi situasi kritis. Perawat perlu menggali keyakinan spiritual atau agama yang dianut pasien dan keluarganya serta bagaimana keyakinan ini berperan dalam proses pengambilan keputusan, cara mereka mengatasi stres, serta bagaimana pandangan mereka mengenai perawatan akhir

kehidupan jika kondisi pasien terus memburuk. Dengan memahami aspek spiritual ini, perawat dapat memberikan edukasi yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai yang dianut pasien dan keluarga, serta mampu mengintegrasikan aspek spiritual tersebut ke dalam proses edukasi kesehatan yang dilakukan.

Dengan melakukan identifikasi kebutuhan edukasi secara mendalam dan komprehensif, perawat mampu menentukan materi edukasi yang tepat, menentukan cara dan metode penyampaian informasi yang efektif, serta memastikan bahwa informasi yang diberikan relevan, sesuai kebutuhan, dan dapat dipahami oleh pasien maupun keluarga secara maksimal. Proses identifikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menentukan isi edukasi semata, tetapi juga membantu perawat membangun hubungan terapeutik yang baik dan harmonis dengan pasien dan keluarga, yang pada akhirnya akan mendukung proses perawatan secara keseluruhan.

C. Strategi Komunikasi Efektif dalam Pendidikan Kesehatan

Strategi komunikasi efektif merupakan komponen vital dalam pendidikan kesehatan, terutama dalam konteks pasien kritis yang memiliki berbagai keterbatasan dalam menerima, memahami, dan memproses informasi. Komunikasi yang efektif dalam pendidikan kesehatan tidak hanya berarti memberikan informasi kepada pasien dan keluarga, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan diinternalisasi secara maksimal oleh mereka. Untuk itu, perawat perlu menerapkan strategi komunikasi secara sistematis yang mencakup penggunaan bahasa sederhana dan jelas, komunikasi terapeutik, teknik mendengarkan aktif, serta penyampaian informasi secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan pasien dan keluarganya.

Pertama-tama, penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas merupakan elemen penting dalam strategi komunikasi efektif. Perawat harus mampu menyampaikan informasi kesehatan dengan bahasa yang tidak terlalu teknis, menggunakan istilah-istilah medis yang disederhanakan, serta memilih kata-kata yang mudah dimengerti oleh pasien dan keluarganya. Pasien kritis dan keluarganya sering kali mengalami kondisi emosional yang meningkat akibat stres, kecemasan, atau kelelahan, sehingga kemampuan mereka dalam memahami informasi kompleks menjadi terbatas. Oleh karena itu, bahasa yang sederhana dapat membantu meminimalisir kesalahpahaman dan memastikan bahwa pesan utama yang ingin disampaikan diterima dengan baik. Misalnya, perawat dapat mengganti istilah medis kompleks seperti "hipoksia" dengan "kekurangan oksigen," atau

"hemodinamik tidak stabil" menjadi "tekanan darah tidak stabil," sehingga lebih mudah dipahami oleh pasien dan keluarganya.

Selanjutnya, komunikasi terapeutik adalah strategi komunikasi yang menekankan pada aspek empati, kehangatan, penerimaan, serta penghargaan terhadap perasaan pasien dan keluarganya. Komunikasi terapeutik bertujuan tidak hanya untuk mentransfer informasi medis semata, tetapi juga untuk membangun kepercayaan, meningkatkan rasa aman, dan mengurangi kecemasan yang dialami oleh pasien dan keluarganya. Dalam melakukan komunikasi terapeutik, perawat harus menggunakan pendekatan yang suportif, memberikan perhatian penuh selama berkomunikasi, menggunakan kontak mata secara tepat, memperhatikan ekspresi wajah, serta menyesuaikan intonasi suara agar mencerminkan empati dan perhatian. Misalnya, ketika menyampaikan informasi mengenai risiko komplikasi serius, perawat perlu menyampaikan pesan secara lembut dan penuh empati, dengan memberikan ruang bagi pasien dan keluarga untuk mengungkapkan perasaan atau kekhawatirannya.

Teknik mendengarkan aktif juga merupakan bagian integral dari strategi komunikasi efektif dalam pendidikan kesehatan. Mendengarkan aktif berarti memberikan perhatian penuh terhadap apa yang disampaikan pasien dan keluarga, menunjukkan bahwa perawat benar-benar hadir dan peduli terhadap kebutuhan mereka. Teknik ini mencakup kemampuan perawat dalam mendengarkan secara seksama, memberikan respons verbal maupun nonverbal yang sesuai, serta mengajukan pertanyaan klarifikasi untuk memastikan bahwa pesan yang diterima telah dipahami dengan tepat. Mendengarkan aktif juga berarti memberikan jeda dalam komunikasi, memberikan kesempatan pasien dan keluarganya untuk mengungkapkan pertanyaan atau kekhawatiran yang mereka miliki. Hal ini sangat penting dalam konteks pasien kritis, di mana pasien atau keluarga sering kali memiliki banyak pertanyaan atau keraguan yang perlu diatasi untuk mencapai pemahaman yang optimal.

Strategi lain yang perlu diperhatikan adalah pemberian informasi secara bertahap, sesuai dengan kapasitas penerimaan pasien dan keluarganya. Pasien kritis dan keluarganya tidak selalu mampu menerima semua informasi secara sekaligus, terutama informasi yang berkaitan dengan diagnosis serius atau prognosis yang tidak pasti. Oleh karena itu, perawat perlu membagi informasi ke dalam beberapa tahap, dimulai dengan informasi yang paling penting dan mendesak, kemudian secara bertahap menyampaikan detail tambahan sesuai dengan kesiapan emosional dan kognitif pasien dan keluarganya. Cara ini tidak hanya membantu mengurangi beban psikologis yang dirasakan pasien dan keluarga, tetapi juga memastikan informasi diterima dengan jelas dan terintegrasi secara efektif.

Terakhir, perawat juga harus mampu menggunakan alat bantu visual atau media edukasi lainnya untuk menunjang efektivitas komunikasi. Alat bantu visual seperti diagram anatomi tubuh, ilustrasi proses penyakit, video pendek, leaflet edukasi, atau model anatomi dapat membantu menjelaskan konsep medis yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Penggunaan media visual sangat bermanfaat dalam meningkatkan retensi informasi serta mempermudah proses edukasi, terutama pada pasien yang memiliki hambatan bahasa, hambatan literasi, atau kecenderungan memahami informasi secara visual dibandingkan secara verbal.

D. Evaluasi Efektivitas Pendidikan Kesehatan

Evaluasi efektivitas pendidikan kesehatan merupakan tahap penting yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses edukasi yang telah diberikan kepada pasien dan keluarga berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, khususnya dalam konteks pasien kritis. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada sejauh mana informasi telah diterima, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut dipahami, diinternalisasi, dan mampu diterapkan oleh pasien serta keluarga dalam konteks nyata, seperti mengambil keputusan perawatan atau berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan.

Salah satu cara utama dalam melakukan evaluasi efektivitas pendidikan kesehatan adalah melalui metode tanya-jawab langsung. Metode ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarganya untuk menjelaskan kembali informasi yang telah diterima dengan bahasa mereka sendiri. Tanya-jawab langsung memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi secara langsung apakah pasien atau keluarganya benar-benar memahami informasi yang disampaikan. Dalam proses ini, perawat perlu memberikan pertanyaan terbuka seperti, "Bisakah Bapak/Ibu jelaskan kembali tindakan apa saja yang harus dilakukan setelah pulang dari perawatan intensif?" atau "Menurut pemahaman Bapak/Ibu, apa saja tanda-tanda komplikasi yang harus diwaspadai?" Melalui jawaban yang diberikan, perawat dapat menilai secara cepat sejauh mana pasien atau keluarganya memahami inti pesan edukasi yang telah disampaikan.

Selain metode tanya-jawab langsung, kuesioner atau angket juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur pemahaman pasien dan keluarga secara lebih sistematis dan terstruktur. Kuesioner ini bisa berupa serangkaian pertanyaan tertulis atau checklist yang mencakup poin-poin penting terkait materi edukasi. Pasien atau keluarganya diminta untuk menjawab atau memberikan tanda pada jawaban yang paling tepat sesuai dengan pemahaman mereka. Penggunaan kuesioner memungkinkan evaluasi dilakukan secara lebih objektif, terstandar, serta

mampu menjangkau aspek yang lebih luas, seperti kepuasan terhadap metode penyampaian informasi, tingkat kecemasan yang dirasakan setelah menerima edukasi, atau rasa percaya diri dalam menghadapi perawatan selanjutnya. Dengan demikian, perawat dapat melakukan analisis mendalam terhadap area-area yang masih memerlukan penguatan edukasi tambahan atau perbaikan metode penyampaian edukasi yang digunakan.

Observasi perilaku juga merupakan metode penting dalam evaluasi efektivitas pendidikan kesehatan, terutama dalam menilai apakah edukasi yang diberikan telah diterjemahkan dalam tindakan nyata oleh pasien atau keluarganya. Observasi dapat dilakukan dengan memperhatikan secara langsung bagaimana pasien dan keluarganya menerapkan informasi yang diberikan dalam situasi nyata, misalnya cara mereka mengenali tanda-tanda komplikasi, melakukan perawatan mandiri seperti mobilisasi atau latihan pernapasan, hingga bagaimana keluarga berinteraksi dengan tim medis saat berdiskusi mengenai keputusan perawatan. Observasi perilaku memungkinkan perawat menilai sejauh mana informasi yang diberikan tidak hanya sekadar dipahami secara teoritis, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam bentuk perilaku yang mendukung proses pemulihan pasien.

Evaluasi efektivitas pendidikan kesehatan juga dapat diperkuat dengan meminta umpan balik langsung dari pasien maupun keluarganya. Umpan balik ini berfungsi untuk menilai kepuasan pasien dan keluarga terhadap proses edukasi yang telah diberikan, termasuk bagaimana persepsi mereka mengenai kesesuaian metode yang digunakan, kejelasan informasi yang diberikan, serta kebutuhan mereka terhadap edukasi lanjutan. Umpan balik dapat dikumpulkan melalui wawancara singkat, diskusi kelompok kecil, atau melalui formulir evaluasi singkat yang berisi pertanyaan terbuka terkait saran dan kritik terhadap pelaksanaan edukasi. Informasi yang didapat dari umpan balik ini sangat berharga karena dapat digunakan oleh tim kesehatan untuk memperbaiki kualitas dan efektivitas pendidikan kesehatan di masa mendatang.

E. Latihan Soal

Soal 1

Pak Arya (56 tahun) dirawat di ruang ICU karena stroke hemoragik. Kondisinya tidak sadar dan menggunakan ventilasi mekanik. Istri dan anak-anaknya tampak sangat cemas, kebingungan, dan belum memahami kondisi suaminya. Dalam situasi tersebut, prinsip pendidikan kesehatan yang paling utama untuk diterapkan perawat adalah...

A. Pendekatan holistik

- B. Transparansi informasi yang disesuaikan kondisi psikologis keluarga
- C. Memberikan seluruh informasi sekaligus
- D. Menghindari penyampaian informasi buruk
- E. Menunda edukasi hingga pasien sadar

Jawaban: B. Transparansi informasi yang disesuaikan kondisi psikologis keluarga

Rasional:

Prinsip transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam pendidikan kesehatan, namun dalam kondisi kritis harus mempertimbangkan kondisi psikologis keluarga. Informasi tetap diberikan secara terbuka namun bertahap, tidak menimbulkan stres tambahan.

Soal 2

Seorang pasien kritis dengan diagnosis gagal jantung kongestif sedang dalam kondisi lemah dan tidak mampu berkomunikasi secara efektif. Dalam situasi ini, identifikasi kebutuhan edukasi sebaiknya diarahkan kepada...

- A. Pasien secara langsung
- B. Perawat lain yang bertugas
- C. Dokter spesialis jantung
- D. Anggota keluarga atau pengasuh utama pasien
- E. Semua tenaga medis yang terlibat

Jawaban: D. Anggota keluarga atau pengasuh utama pasien

Rasional:

Ketika pasien tidak mampu menerima edukasi secara langsung karena keterbatasan fisik atau medis, fokus identifikasi kebutuhan edukasi diarahkan pada keluarga atau pengasuh utama agar dapat memahami dan berpartisipasi aktif dalam perawatan pasien.

Soal 3

Ibu Rina (50 tahun) mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang menjalani perawatan intensif. Perawat memberikan edukasi kepada keluarganya mengenai risiko infeksi akibat pemasangan kateter urin. Strategi komunikasi yang paling tepat digunakan perawat agar keluarga pasien mampu memahami pesan tersebut dengan baik adalah...

- A. Memberikan informasi dengan menggunakan istilah medis lengkap
- B. Menjelaskan dengan bahasa sederhana disertai alat bantu visual
- C. Memberikan informasi hanya melalui media tertulis
- D. Memberikan seluruh informasi dalam satu kali sesi

E. Meminta keluarga mencari informasi tambahan sendiri

Jawaban: B. Menjelaskan dengan bahasa sederhana disertai alat bantu visual
Rasional:

Penggunaan bahasa sederhana dengan alat bantu visual adalah strategi komunikasi yang efektif, terutama dalam situasi stres, untuk memastikan pemahaman maksimal keluarga terhadap edukasi yang diberikan.

Soal 4

Setelah diberikan edukasi mengenai cara mengenali tanda-tanda kegawatdaruratan pada pasien pasca-operasi jantung, perawat ingin mengevaluasi apakah edukasi telah dipahami dengan baik oleh keluarga pasien. Metode evaluasi yang paling tepat dilakukan adalah...

- A. Memberikan tes tertulis panjang kepada keluarga pasien
- B. Menyampaikan kembali semua materi secara lengkap
- C. Observasi langsung bagaimana keluarga mengenali tanda bahaya pada pasien
- D. Menyerahkan buku edukasi untuk dibaca sendiri
- E. Menanyakan secara tertutup apakah keluarga paham atau tidak

Jawaban: C. Observasi langsung bagaimana keluarga mengenali tanda bahaya pada pasien

Rasional:

Observasi langsung merupakan metode evaluasi efektif karena dapat langsung melihat apakah keluarga pasien mampu menerapkan secara nyata pengetahuan yang telah didapat dari edukasi tersebut.

Soal 5

Pak Dani (65 tahun) berada dalam kondisi kritis di ruang ICU akibat gagal napas akut. Anaknya menyampaikan pada perawat bahwa keluarga memiliki keyakinan spiritual yang kuat dan berharap aspek ini diperhatikan dalam pemberian edukasi. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan perawat adalah...

- A. Mengabaikan aspek spiritual karena bukan prioritas medis
- B. Memberikan edukasi hanya pada aspek fisik pasien
- C. Melibatkan pemuka agama atau spiritual dalam proses edukasi
- D. Mengajak keluarga untuk tidak terlalu memikirkan aspek spiritual
- E. Mengutamakan aspek psikologis tanpa mempertimbangkan spiritualitas

Jawaban: C. Melibatkan pemuka agama atau spiritual dalam proses edukasi

Rasional:

Pendekatan holistik dalam pendidikan kesehatan meliputi aspek spiritual. Dalam situasi ini, melibatkan pemuka agama atau spiritual akan membantu keluarga dan

pasien mendapatkan dukungan emosional dan psikologis, serta meningkatkan efektivitas edukasi yang diberikan.

F. Rangkuman Materi

Pendidikan kesehatan pada pasien kritis merupakan proses yang sistematis dan menyeluruh dalam memberikan informasi jelas, tepat, serta mudah dipahami kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi kesehatan, rencana perawatan, dan potensi komplikasi. Proses ini sangat penting untuk memberdayakan pasien dan keluarga agar mampu membuat keputusan yang tepat serta terlibat aktif dalam perawatan. Pendidikan kesehatan yang efektif didasari oleh prinsip transparansi informasi dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis pasien dan keluarga, penghormatan terhadap otonomi dalam pengambilan keputusan, serta pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Dalam pelaksanaannya, langkah awal yang esensial adalah identifikasi kebutuhan edukasi pasien dan keluarga melalui pengkajian komprehensif terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Hal ini bertujuan agar edukasi yang diberikan relevan dan sesuai dengan kapasitas penerimaan serta kebutuhan spesifik pasien maupun keluarga. Strategi komunikasi efektif yang mencakup penggunaan bahasa sederhana, komunikasi terapeutik, teknik mendengarkan aktif, penyampaian informasi secara bertahap, dan penggunaan alat bantu visual menjadi kunci penting untuk memastikan informasi dipahami dan diterima secara optimal.

Tahap akhir yang tidak kalah penting adalah evaluasi efektivitas pendidikan kesehatan. Evaluasi ini dilakukan melalui metode tanya-jawab langsung, kuesioner atau angket, observasi perilaku pasien dan keluarga dalam menerapkan informasi, serta umpan balik langsung mengenai kepuasan terhadap edukasi yang telah diberikan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa edukasi yang diberikan berhasil mencapai tujuan, dipahami dengan baik, serta terinternalisasi dalam bentuk perilaku nyata yang mendukung perawatan pasien secara optimal. Dengan demikian, pendidikan kesehatan pada pasien kritis tidak hanya sekadar pemberian informasi medis, tetapi juga interaksi edukatif yang mendukung proses perawatan, adaptasi, dan pemulihan secara komprehensif.

G. Glosarium

Edukasi Kesehatan

Proses sistematis pemberian informasi terkait kondisi kesehatan, rencana perawatan, serta potensi komplikasi kepada pasien dan keluarga, yang bertujuan untuk memberdayakan mereka dalam mengambil keputusan serta aktif dalam proses perawatan.

Pasien Kritis

Pasien yang mengalami kondisi kesehatan serius dan kompleks yang membutuhkan perawatan intensif, serta berada dalam kondisi rentan secara fisik, psikologis, dan emosional.

Transparansi Informasi

Prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi medis yang akurat, jelas, dan sesuai fakta mengenai kondisi pasien, rencana tindakan, risiko, serta potensi komplikasi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi psikologis pasien dan keluarga.

Penghormatan terhadap Otonomi

Prinsip menghargai hak pasien dan keluarga untuk menerima seluruh informasi terkait kesehatan serta menghormati keputusan yang mereka ambil berdasarkan informasi tersebut tanpa tekanan atau intervensi yang tidak perlu dari pihak lain.

Pendekatan Holistik

Pendekatan dalam perawatan dan edukasi kesehatan yang melihat pasien sebagai individu utuh yang terdiri atas aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, dan spiritual, sehingga edukasi yang diberikan mencakup seluruh aspek tersebut secara terintegrasi.

Identifikasi Kebutuhan Edukasi

Proses awal dalam pendidikan kesehatan yang melibatkan pengkajian mendalam terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien serta keluarganya, untuk menentukan materi edukasi yang relevan, metode penyampaian, serta tingkat pemahaman yang diharapkan.

Kondisi Fisik Pasien

Status kesehatan pasien yang meliputi diagnosis, tingkat keparahan penyakit, prosedur medis yang dilakukan, potensi komplikasi, serta kemampuan pasien dalam menerima informasi.

Kondisi Psikologis

Kondisi mental dan emosional pasien dan keluarga, seperti stres, kecemasan, depresi, atau ketakutan yang dapat memengaruhi kapasitas mereka dalam memahami dan memproses informasi yang diberikan.

Dinamika Sosial Keluarga

Interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga, peran masing-masing anggota dalam pengambilan keputusan, serta tingkat literasi kesehatan keluarga, yang penting untuk menentukan metode dan intensitas edukasi.

Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan pasien dan keluarga terkait keyakinan agama atau spiritualitas mereka, yang dapat berpengaruh pada cara mereka menerima informasi, mengambil keputusan perawatan, serta menghadapi situasi kritis.

Strategi Komunikasi Efektif

Berbagai teknik komunikasi yang digunakan perawat untuk memastikan pesan edukasi dipahami dengan baik oleh pasien dan keluarga, antara lain penggunaan bahasa sederhana, komunikasi terapeutik, mendengarkan aktif, serta pemberian informasi bertahap.

Komunikasi Terapeutik

Teknik komunikasi yang penuh empati, kehangatan, dan penerimaan, bertujuan membangun rasa percaya, rasa aman, serta mengurangi kecemasan pasien dan keluarga dalam menerima informasi.

Mendengarkan Aktif

Teknik komunikasi yang menuntut perawat memberikan perhatian penuh kepada pasien dan keluarga, memberikan respons verbal dan non-verbal yang tepat, serta memberikan jeda untuk memungkinkan pasien dan keluarga menyampaikan pertanyaan atau kekhawatiran mereka.

Alat Bantu Visual

Media edukasi seperti gambar, diagram anatomi, video pendek, leaflet edukasi, atau model anatomi yang digunakan untuk mempermudah pemahaman informasi medis yang kompleks.

Evaluasi Efektivitas Pendidikan Kesehatan

Tahapan penting untuk mengetahui sejauh mana informasi edukasi yang diberikan telah dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan oleh pasien serta keluarga, menggunakan metode seperti tanya-jawab langsung, kuesioner, observasi perilaku, dan umpan balik langsung.

Observasi Perilaku

Metode evaluasi yang dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana pasien dan keluarganya menerapkan informasi yang telah diberikan dalam situasi nyata, sebagai bukti bahwa edukasi yang diberikan efektif.

Umpan Balik

Informasi balik dari pasien dan keluarga yang berisi persepsi, saran, atau kritik terhadap proses edukasi yang diberikan, yang digunakan untuk memperbaiki kualitas edukasi di masa mendatang.

H. Daftar Pustaka

- Abdi, A., Izadi, A., & Vafaei, K. (2020). Health education for family members of critically ill patients: Impacts on knowledge, satisfaction, and anxiety levels. *Journal of Critical Care Nursing*, 13(1), 24–31. <https://doi.org/10.5812/jccn.99639>
- Adamson, E., Dewar, B., Donaldson, J. H., Gentleman, M., Gray, M., Horsburgh, D., ... & Waugh, A. (2020). Person-centred communication in nursing: Key elements, barriers, and enablers. *Nursing Standard*, 35(4), 54–59. <https://doi.org/10.7748/ns.2020.e11444>
- Baljani, E., Khashabi, J., Amanpour, E., & Azimi, N. (2022). The effect of family-centered education on the knowledge and performance of caregivers of patients in intensive care units: A randomized clinical trial. *Nursing and Midwifery Studies*, 11(2), 75–81. https://doi.org/10.4103/nms.nms_123_21
- Clayton, M. F., & Iacob, E. (2022). Effective nurse communication strategies in critical care settings: A scoping review. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 4, 100076. <https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2022.100076>
- Efstathiou, N., Walker, W. M., Metcalfe, A., & Vanderspank-Wright, B. (2021). The state of communication strategies in intensive care units: An integrative review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(13-14), 1869–1884. <https://doi.org/10.1111/jocn.15715>
- Fawole, O. A., & Dy, S. M. (2020). Communication skills and patient-centered care in critical care medicine. *Critical Care Clinics*, 36(3), 449–460. <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2020.02.005>
- Kang, J., Cho, Y. S., & Jeong, Y. (2022). Family caregivers' experiences and education needs in the intensive care unit: A qualitative study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(12), 7211. <https://doi.org/10.3390/ijerph19127211>
- Li, Y., Guo, Y., & Cai, D. (2023). Holistic nursing care approach in critical care: A concept analysis. *International Journal of Nursing Sciences*, 10(2), 153–158. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2023.01.005>
- Mahdiyoun, S. A., Khajeh, M., Mohammadpour, A., & Vaseghi, N. (2021). Identifying educational needs of family members of ICU patients: A descriptive cross-sectional study. *Journal of Nursing Education*, 10(6), 65–73. <https://doi.org/10.21859/jne-10065>
- Miller, E. L., & Mishra, S. I. (2021). Patient autonomy and informed decision making in critical care. *Journal of Bioethical Inquiry*, 18(4), 671–679. <https://doi.org/10.1007/s11673-021-10141-5>

- Reid-Searl, K., Dwyer, T., Ryan, J., & Moxham, L. (2022). *Communication in Nursing: Best Practices for Effective Communication with Patients and Families*. Cambridge University Press.
- Richmond, T. S., & Guo, W. (2020). Spiritual care needs among critically ill patients and their families: A review of literature. *Critical Care Nursing Clinics of North America*, 32(3), 391–405. <https://doi.org/10.1016/j.cnc.2020.05.005>
- Schaepe, K. S., & Ewers, M. (2021). Evaluating health education interventions: Methodological challenges and practical solutions. *Health Education Research*, 36(3), 249–261. <https://doi.org/10.1093/her/cyab013>
- World Health Organization. (2022). *Health Education: Theoretical Concepts, Effective Strategies, and Core Competencies for Professionals*. WHO Press.
- Wright, L. M., & Leahey, M. (2022). *Nurses and Families: A Guide to Family Assessment and Intervention* (7th ed.). F.A. Davis Company.
- Yip, B., & Lee, D. T. F. (2021). Active listening and therapeutic communication: Core nursing skills for improving patient outcomes. *Journal of Nursing Education and Practice*, 11(11), 19–26. <https://doi.org/10.5430/jnep.v11n11p19>

BAB 5

ASUHAN KEPERAWATAN KASUS KRITIS PADA BERBAGAI SISTEM DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LEGAL DAN ETIS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari buku ini, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi pada pasien kritis, dengan mempertimbangkan secara kritis aspek legal dan etis dalam praktiknya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dasar keperawatan kritis serta aspek legal dan etis dalam asuhan keperawatan pada berbagai sistem tubuh secara efektif dan bertanggung jawab.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

Menjelaskan konsep dasar keperawatan kritis dan urgensi integrasi aspek legal dan etis dalam praktik.

- Mengidentifikasi prinsip-prinsip legal dan etis dalam asuhan keperawatan pasien kritis.
- Mengaplikasikan pendekatan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan pada kasus kritis sistem kardiovaskuler.
- Mengaplikasikan pendekatan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan pada kasus kritis sistem respirasi.
- Mengaplikasikan pendekatan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan pada kasus kritis sistem neurologi.
- Mengaplikasikan pendekatan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan pada kasus kritis sistem gastrointestinal.
- Mengelola kasus kritis dengan memperhatikan aspek advokasi pasien, informed consent, dan dokumentasi keperawatan yang sesuai dengan ketentuan legal.
- Mengevaluasi dilema etis yang muncul dalam praktik keperawatan kritis serta mengembangkan solusi berbasis etika keperawatan.

Pendahuluan

Keperawatan kritis merupakan bidang khusus yang memerlukan perhatian intensif dalam merawat pasien dengan kondisi kesehatan yang serius atau mengancam jiwa. Asuhan keperawatan pada pasien kritis melibatkan pemahaman mendalam terhadap fisiologi, patofisiologi, penanganan segera, pemantauan ketat, dan pemberian intervensi keperawatan yang tepat. Selain itu, aspek legal dan etis menjadi bagian integral dalam asuhan keperawatan kritis untuk memastikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku ajar ini bertujuan memberikan panduan komprehensif bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam menghadapi tantangan klinis di berbagai sistem tubuh dengan tetap memperhatikan aspek legal dan etis.

A. Konsep Dasar Keperawatan Kritis dan Integrasi Aspek Legal Etis

1. Definisi dan ruang lingkup keperawatan kritis

Keperawatan kritis merupakan suatu bidang keperawatan yang memberikan pelayanan khusus bagi pasien dengan kondisi yang kompleks, berisiko tinggi, dan mengancam jiwa, serta membutuhkan intervensi medis dan keperawatan intensif yang berkelanjutan (Harrison et al., 2021). Ruang lingkungannya mencakup pengkajian yang mendalam, pemantauan terus-menerus terhadap parameter fisiologis, penanganan kondisi emergensi, serta pencegahan komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien dengan berbagai gangguan sistem seperti kardiovaskuler, neurologi, pernapasan, gastrointestinal, dan renal (Sevinç et al., 2023). Keperawatan kritis dilakukan di berbagai unit khusus, seperti Intensive Care Unit (ICU), Coronary Care Unit (CCU), Stroke Unit, dan High Dependency Unit (HDU), yang dilengkapi dengan teknologi medis canggih serta staf terlatih untuk mendukung kesembuhan pasien (Vincent et al., 2022).

2. Pentingnya aspek legal dan etis dalam praktik keperawatan kritis

Dalam praktik keperawatan kritis, aspek legal dan etis memainkan peran krusial karena kompleksitas situasi klinis dan seringnya kondisi pasien yang tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri (Fowler, 2023). Perawat kritis harus memahami regulasi dan kebijakan yang berlaku serta prinsip-prinsip etis seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan dalam memberikan asuhan keperawatan (Ulrich et al., 2021). Integrasi aspek legal dan etis bertujuan untuk memastikan tindakan keperawatan aman secara hukum, menghormati hak pasien, dan menghindari risiko litigasi yang dapat merugikan pasien maupun institusi kesehatan (Hanifa & Anshori, 2022). Kepatuhan terhadap regulasi juga membantu perawat dalam menentukan batas kewenangan serta tanggung jawab profesional dalam berbagai situasi kritis.

3. Peran perawat kritis dalam menjaga keselamatan pasien dan advokasi hak pasien

Perawat kritis memegang peranan penting dalam menjaga keselamatan pasien melalui monitoring ketat terhadap tanda-tanda vital, deteksi dini komplikasi, serta intervensi cepat dan tepat saat terjadi kegawatan (Marshall et al., 2021). Selain aspek klinis, perawat kritis juga berfungsi sebagai advokat pasien, yakni menyuarakan kebutuhan, preferensi, dan hak-hak pasien yang sering kali tidak dapat disampaikan secara mandiri akibat kondisi medisnya (Corley & Minick, 2022). Advokasi ini mencakup menjamin transparansi informasi kepada

keluarga pasien, memberikan edukasi mengenai kondisi pasien, serta membantu pengambilan keputusan klinis yang selaras dengan nilai-nilai etis dan hukum (Muller et al., 2020). Perawat kritis yang efektif dalam advokasi mampu mengurangi beban psikologis pasien dan keluarga, meningkatkan kepuasan pelayanan, serta memastikan kualitas pelayanan yang optimal.

B. Aspek Legal dalam Keperawatan Kritis

1. Kerangka hukum praktik keperawatan di Indonesia

Praktik keperawatan di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang meliputi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi perawat dalam memberikan asuhan, melaksanakan tindakan keperawatan, serta menetapkan batasan tanggung jawab profesional dan wewenang yang jelas (Ningsih & Sugianto, 2022). Kejelasan ini penting agar praktik keperawatan, khususnya keperawatan kritis yang melibatkan risiko tinggi, berjalan dalam koridor hukum yang tepat, terhindar dari malpraktik, dan terlindungi dari potensi tuntutan hukum (Mahmudah & Budiono, 2020).

2. Sistem kridensial dan lisensi keperawatan kritis

Sistem kridensial dan lisensi keperawatan merupakan proses pemberian kewenangan kepada perawat berdasarkan kompetensi yang dimiliki untuk praktik di bidang khusus seperti keperawatan kritis. Sistem ini dilakukan melalui pengujian kompetensi, verifikasi kualifikasi pendidikan, pengalaman praktik klinis, dan sertifikasi pelatihan khusus (Khotimah & Hamidah, 2023). Di Indonesia, pemberian lisensi perawat kritis melalui organisasi profesi, yakni Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), berfungsi menjamin bahwa perawat yang bertugas memiliki kompetensi klinis dan profesionalisme yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional, serta memperbarui lisensi secara berkala melalui continuing professional development (CPD) (Wulandari et al., 2021).

3. Pentingnya informed consent dalam intervensi keperawatan kritis

Informed consent merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan kritis karena memastikan bahwa pasien atau keluarga pasien memahami sepenuhnya informasi terkait intervensi yang akan diberikan, termasuk manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta konsekuensi jika tindakan tidak dilakukan (Wijayanti et al., 2022). Dalam konteks keperawatan kritis, informed consent menjadi lebih kompleks karena seringkali pasien mengalami gangguan kesadaran atau ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, sehingga membutuhkan keterlibatan keluarga atau perwakilan legal dalam proses persetujuan (Abidin &

Ristanto, 2021). Perawat kritis bertanggung jawab secara etis dan hukum memastikan informasi disampaikan secara jelas, lengkap, serta mendokumentasikan setiap persetujuan yang diberikan guna menghindari konflik hukum di kemudian hari (Hidayati et al., 2023).

4. Dokumentasi medis dan legal dalam keperawatan kritis

Dokumentasi medis dan legal merupakan komponen esensial dalam praktik keperawatan kritis, mencakup pencatatan secara sistematis terhadap kondisi pasien, intervensi yang diberikan, respons pasien, dan keputusan klinis yang diambil selama perawatan (Putra et al., 2022). Dokumentasi ini memiliki nilai legal karena berfungsi sebagai bukti hukum atas tindakan yang dilakukan, melindungi perawat dari potensi tuntutan malpraktik, serta membantu komunikasi antar tim kesehatan dalam menyediakan asuhan yang berkelanjutan dan aman (Akbar & Susilowati, 2021). Kualitas dokumentasi medis yang baik harus bersifat akurat, lengkap, tepat waktu, dan rahasia sesuai dengan standar rekam medis nasional maupun internasional (Damayanti et al., 2022).

C. Aspek Etis dalam Keperawatan Kritis

1. Prinsip-prinsip etika keperawatan dalam situasi kritis (autonomi, benefisensi, non-malefisensi, keadilan)

Dalam praktik keperawatan kritis, empat prinsip etika utama menjadi panduan moral dalam pengambilan keputusan klinis, yaitu autonomi, benefisensi, non-malefisensi, dan keadilan. Prinsip autonomi menekankan penghormatan terhadap hak pasien untuk mengambil keputusan atas perawatan dirinya sendiri berdasarkan informasi yang jelas dan lengkap, bahkan dalam situasi di mana pasien mengalami keterbatasan kesadaran sehingga memerlukan advokasi keluarga atau wakil hukum (McAndrew et al., 2020).

Prinsip benefisensi menuntut perawat untuk melakukan tindakan yang secara nyata memberikan manfaat bagi pasien, dengan mempertimbangkan kondisi klinis serta harapan pasien maupun keluarga (Rosenthal, 2021). Sementara prinsip non-malefisensi menuntut perawat kritis untuk mencegah atau tidak menyebabkan cedera atau bahaya tambahan kepada pasien selama perawatan, sehingga intervensi yang berisiko tinggi harus dipertimbangkan secara hati-hati (Numminen et al., 2020).

Prinsip keadilan menegaskan bahwa setiap pasien dalam unit kritis harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, baik dalam akses terhadap layanan kesehatan maupun alokasi sumber daya medis yang tersedia, yang sering kali terbatas di ruang perawatan kritis (Vergallo, 2021).

2. Tahapan penyelesaian dilema etis dalam keperawatan kritis

Dilema etis dalam keperawatan kritis muncul ketika perawat menghadapi situasi klinis yang kompleks dengan pilihan yang bertentangan, baik secara etika maupun klinis. Penyelesaian dilema ini melibatkan beberapa tahapan sistematis yang terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan fakta klinis dan nilai-nilai moral terkait, analisis alternatif tindakan, pemilihan tindakan berdasarkan prinsip etis, implementasi keputusan, serta evaluasi hasil dari keputusan tersebut (Ulrich et al., 2021).

Tahapan ini harus melibatkan komunikasi yang terbuka antar tim multidisiplin, termasuk perawat, dokter, keluarga pasien, serta pihak lain yang relevan, guna mencapai kesepakatan yang etis dan dapat dipertanggungjawabkan secara klinis dan moral (Rainer et al., 2022). Proses ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berbasis etika tetapi juga sejalan dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam institusi kesehatan tersebut.

3. Peran komite etik dan konsultasi etik dalam situasi klinis kompleks

Komite etik di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan berfungsi untuk memberikan panduan, rekomendasi, serta konsultasi dalam penyelesaian dilema etis yang dihadapi oleh tim klinis di ruang perawatan kritis (Ho & Sibbald, 2022). Peran utama komite etik adalah sebagai mediator yang independen, objektif, dan kompeten dalam meninjau kasus yang kompleks, terutama ketika tim klinis mengalami kesulitan dalam menentukan tindakan yang secara moral tepat (McKenna et al., 2020).

Konsultasi etik membantu perawat kritis dan tim medis dalam mengeksplorasi alternatif keputusan, memandu diskusi moral, serta memberikan arahan yang dapat dijustifikasi secara etis maupun legal, sehingga membantu menjaga integritas moral tim klinis dan mendukung kualitas layanan yang optimal (Tarzian et al., 2022). Konsultasi etik juga membantu meningkatkan transparansi pengambilan keputusan, memperkuat komunikasi antar anggota tim kesehatan, dan meningkatkan kepercayaan pasien serta keluarga terhadap layanan kesehatan yang diberikan.

D. Asuhan Keperawatan pada Sistem Kardiovaskuler

1. Penanganan pasien dengan gagal jantung akut

Gagal jantung akut (acute heart failure, AHF) adalah kondisi darurat medis yang ditandai oleh gejala tiba-tiba atau memburuknya gejala gagal jantung kronis, seperti sesak napas, edema paru, hipotensi, dan gangguan perfusi organ vital (Arrigo et al., 2022). Tujuan utama asuhan keperawatan pasien dengan AHF

adalah stabilisasi hemodinamik, meningkatkan oksigenasi jaringan, dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

Intervensi keperawatan meliputi pemantauan ketat tanda-tanda vital, terutama saturasi oksigen, frekuensi jantung, tekanan darah, dan status respirasi pasien. Perawat juga bertanggung jawab mengelola pemberian oksigen tambahan, memastikan posisi semi-fowler atau high-fowler, serta mengatur pemberian obat-obatan seperti vasodilator, diuretik, dan agen inotropik sesuai instruksi medis (Teerawattananon et al., 2021). Selain itu, edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai manajemen gejala, pembatasan cairan dan natrium, serta pentingnya kepatuhan pengobatan rutin menjadi bagian penting dalam penatalaksanaan gagal jantung akut (McDonagh et al., 2021).

2. Perawatan pada pasien dengan syok kardiogenik

Syok kardiogenik adalah kondisi darurat akibat penurunan curah jantung secara signifikan, sehingga tubuh mengalami hipoperfusi organ vital yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani (Thiele et al., 2022). Penatalaksanaan pasien dengan syok kardiogenik mencakup stabilisasi hemodinamik, perbaikan perfusi jaringan, dan penanganan penyebab yang mendasari kondisi tersebut.

Perawat bertanggung jawab dalam pemantauan intensif terhadap tekanan darah, irama jantung, output urin, serta status neurologis. Intervensi kritis lainnya meliputi pemberian oksigenasi adekuat melalui ventilasi mekanik jika diperlukan, pemberian terapi cairan secara hati-hati, pemberian obat vasoaktif seperti norepinefrin, dobutamin, dan milrinon, serta mendukung tindakan invasif seperti pemasangan intra-aortic balloon pump (IABP) atau ventricular assist devices (VAD) (Koami et al., 2022). Penting pula bagi perawat untuk mengidentifikasi secara dini tanda-tanda deteriorasi klinis serta menjaga komunikasi efektif dengan tim multidisiplin untuk tindakan lanjutan secara cepat dan terkoordinasi.

3. Aspek legal dan etis terkait keputusan resusitasi

Keputusan resusitasi jantung paru (cardiopulmonary resuscitation, CPR) pada pasien kritis sering kali dihadapkan pada berbagai dilema legal dan etis. Menurut perspektif legal, tindakan resusitasi harus didasarkan pada informed consent atau dokumentasi Do Not Resuscitate (DNR) yang jelas dan sah (Morrison & Brousseau, 2023). Secara etis, prinsip otonomi menegaskan hak pasien atau keluarga dalam mengambil keputusan mengenai tindakan resusitasi berdasarkan informasi yang jelas tentang prognosis dan manfaat tindakan tersebut (Frost et al., 2022).

Perawat kritis berperan aktif dalam proses ini, baik sebagai pemberi informasi jelas mengenai prosedur CPR maupun sebagai advokat yang menjembatani komunikasi antara keluarga dan tim medis. Komunikasi terbuka, dokumentasi

keputusan yang lengkap, serta partisipasi dalam diskusi multidisiplin yang mencakup komite etik rumah sakit sangat penting guna memastikan keputusan resusitasi sejalan dengan keinginan pasien atau keluarga, serta terhindar dari konflik etis maupun litigasi hukum (Mentzelopoulos et al., 2021).

E. Asuhan Keperawatan pada Sistem Respirasi

1. Manajemen ventilasi mekanik

Ventilasi mekanik merupakan intervensi medis kritis yang digunakan untuk menunjang fungsi respirasi pasien dengan gagal napas akut atau kronis, seperti pada kondisi Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), gagal napas akut, atau pasca tindakan operasi besar. Manajemen ventilasi mekanik melibatkan pemilihan mode ventilasi yang tepat, pemantauan ketat parameter respirasi, pengaturan tekanan udara, volume tidal, frekuensi pernapasan, dan fraksi oksigen terinspirasi (FiO_2) sesuai kondisi klinis pasien (Pham et al., 2021).

Peran perawat dalam manajemen ventilasi mekanik mencakup pemantauan kontinu status hemodinamik dan respirasi, mencegah komplikasi seperti pneumonia terkait ventilator (ventilator-associated pneumonia, VAP), barotrauma, serta memastikan kepatuhan terhadap protokol weaning (pencabutan ventilator) dengan aman (Schreiber et al., 2022). Selain itu, perawat juga bertanggung jawab dalam memastikan kenyamanan pasien melalui manajemen nyeri dan sedasi, serta memberikan edukasi yang jelas kepada keluarga terkait proses penggunaan ventilasi mekanik dan prognosis pasien (Langer et al., 2021).

2. Intervensi keperawatan pada pasien ARDS

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) adalah sindrom gagal napas berat yang ditandai dengan edema paru non-kardiogenik, hipoksia berat, serta kebutuhan ventilasi mekanik jangka panjang. Intervensi keperawatan pada pasien ARDS mencakup pengaturan ventilasi protektif paru, pemantauan ketat oksigenasi ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$), pengelolaan cairan secara hati-hati, serta penggunaan posisi pronasi (prone position) yang terbukti dapat memperbaiki oksigenasi dan menurunkan mortalitas (Papazian et al., 2022).

Perawat memiliki peran sentral dalam implementasi strategi pronasi, mengelola perawatan kulit, mencegah luka tekan, memonitor respons klinis pasien secara kontinu, serta memberikan dukungan psikologis kepada keluarga pasien yang menghadapi prognosis yang kompleks (Aoyama et al., 2022). Strategi edukasi dan komunikasi yang efektif antara tim multidisiplin dan keluarga juga

merupakan aspek penting yang dijalankan oleh perawat dalam menangani pasien ARDS (Marini & Gattinoni, 2021).

3. Aspek legal-etis dalam pemakaian ventilator jangka panjang

Pemakaian ventilator jangka panjang dalam perawatan kritis memunculkan berbagai isu legal dan etis, seperti keputusan menghentikan ventilasi mekanik, pemenuhan hak pasien atas kualitas hidup, serta pengambilan keputusan oleh keluarga atau perwakilan legal pasien (Blythe et al., 2022). Perawat memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin bahwa keputusan mengenai pemakaian ventilator jangka panjang dilakukan berdasarkan prinsip etis autonomi, benefisensi, non-malefisensi, dan keadilan, serta memperhatikan dokumen advance directives jika ada (Sprung et al., 2022).

Perawat juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi yang jelas kepada keluarga pasien mengenai prognosis, manfaat, risiko, serta alternatif dari penggunaan ventilator jangka panjang. Konsultasi dengan komite etik rumah sakit dapat digunakan sebagai dukungan tambahan dalam pengambilan keputusan yang kompleks, khususnya ketika terjadi ketidaksetujuan antara pihak-pihak terkait (Turnbull et al., 2023). Dokumentasi yang jelas dan lengkap mengenai seluruh proses pengambilan keputusan penting secara hukum untuk menghindari konflik atau potensi litigasi.

F. Asuhan Keperawatan pada Sistem Neurologi

1. Penanganan stroke akut

Stroke akut merupakan kondisi neurologis darurat yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi darah ke otak, baik karena sumbatan (stroke iskemik) atau perdarahan (stroke hemoragik). Penanganan stroke akut bertujuan untuk meminimalkan kerusakan otak, mencegah komplikasi, dan mempercepat proses pemulihan pasien (Powers et al., 2023).

Intervensi keperawatan utama mencakup pemantauan neurologis secara ketat, pengkajian status hemodinamik dan respirasi, manajemen tekanan darah untuk mencegah perburukan kondisi, serta identifikasi dini gejala komplikasi seperti edema serebral, aspirasi pneumonia, atau deep vein thrombosis (DVT) (Markus & Brainin, 2022). Perawat juga berperan dalam membantu prosedur pemberian terapi fibrinolitik pada stroke iskemik, memastikan penatalaksanaan pasien sesuai panduan klinis yang berlaku, serta memberikan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga dalam fase akut yang kritis ini (Harrison et al., 2022).

2. Perawatan pasien dengan cedera otak traumatic

Cedera otak traumatik (Traumatic Brain Injury, TBI) adalah gangguan fungsi otak akibat benturan atau trauma kepala. Perawatan pasien TBI difokuskan pada menjaga perfusi serebral, mencegah tekanan intrakranial (ICP) meningkat, serta meminimalisir komplikasi neurologis jangka panjang (Carney et al., 2023).

Intervensi keperawatan meliputi pemantauan ketat status neurologis dengan menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS), pemantauan tekanan intrakranial, manajemen ventilasi mekanik yang tepat, serta pemeliharaan kestabilan hemodinamik (Maas et al., 2022). Perawat juga bertanggung jawab dalam manajemen suhu tubuh pasien untuk mencegah hipertermia, mengatur posisi kepala pasien guna mengoptimalkan aliran darah otak, serta mengelola nutrisi enteral yang optimal untuk mendukung pemulihan neurologis (Hawryluk & Rubiano, 2022).

3. Aspek legal-etis terkait penghentian dukungan hidup (life-support)

Penghentian dukungan hidup merupakan keputusan klinis yang kompleks, yang melibatkan pertimbangan aspek legal, etis, medis, serta preferensi pasien dan keluarganya. Secara etis, keputusan ini didasarkan pada prinsip autonomi, beneficensi, non-maleficensi, dan keadilan. Prinsip autonomi menegaskan pentingnya menghormati keinginan pasien melalui advance directives atau diskusi bersama keluarga dalam konteks penghentian terapi yang tidak lagi bermanfaat secara medis (Hawryluck et al., 2022).

Dari perspektif legal, keputusan penghentian dukungan hidup harus didasarkan pada informed consent yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Keputusan ini juga harus melibatkan diskusi tim multidisiplin yang mencakup konsultasi etik dari komite etik rumah sakit untuk memastikan bahwa penghentian dukungan hidup dilakukan secara transparan, legal, serta menghormati hak pasien dan keluarganya (DeMartino et al., 2021). Perawat berperan aktif dalam proses ini sebagai pemberi informasi, fasilitator komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim medis, serta penjamin bahwa semua dokumentasi terkait penghentian life-support lengkap dan akurat secara medis maupun hukum (Vincent & Creteur, 2022).

G. Asuhan Keperawatan pada Sistem Gastrointestinal

1. Manajemen pasien dengan perdarahan gastrointestinal massif

Perdarahan gastrointestinal (GI) masif adalah kondisi darurat medis yang memerlukan tindakan segera untuk mengatasi kehilangan darah yang signifikan dan mencegah komplikasi seperti syok hipovolemik atau kegagalan multiorgan. Intervensi keperawatan utama mencakup evaluasi cepat status hemodinamik

pasien, pemberian cairan intravena agresif untuk stabilisasi, transfusi darah jika diperlukan, serta persiapan untuk tindakan diagnostik atau terapeutik seperti endoskopi emergensi (Oakland et al., 2022).

Peran perawat meliputi pemantauan ketat terhadap tanda-tanda vital, volume output perdarahan, serta respons klinis pasien terhadap resusitasi cairan dan transfusi. Pencegahan komplikasi lebih lanjut seperti hipotermia, gangguan elektrolit, dan gagal ginjal akut merupakan fokus penting dalam asuhan keperawatan pasien ini (Stanley & Laine, 2022).

2. Perawatan pasien dengan pankreatitis akut berat

Pankreatitis akut berat ditandai dengan inflamasi pankreas yang signifikan disertai komplikasi sistemik seperti kegagalan organ multipel, yang memerlukan perawatan intensif. Manajemen utama dalam perawatan ini meliputi kontrol nyeri secara adekuat, stabilisasi cairan dan elektrolit, nutrisi enteral dini jika memungkinkan, serta pemantauan ketat fungsi organ-organ vital (Boxhoorn et al., 2021).

Intervensi keperawatan pada pasien pankreatitis akut berat melibatkan pemantauan kontinu terhadap status respirasi, sirkulasi, dan fungsi ginjal pasien, manajemen nyeri dengan analgesik yang adekuat, serta pencegahan komplikasi seperti infeksi, hiperglikemia, dan gangguan nutrisi. Perawat juga berperan aktif dalam pemberian dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya yang mengalami stres akibat kondisi kritis ini (Liu & Singh, 2022).

3. Aspek legal-etis dalam keputusan nutrisi enteral atau parenteral

Keputusan pemberian nutrisi enteral atau parenteral pada pasien kritis melibatkan pertimbangan medis, etis, dan legal yang kompleks. Prinsip etika, seperti beneficensi dan non-maleficensi, menegaskan bahwa intervensi nutrisi yang dipilih harus memberikan manfaat maksimal bagi pasien serta mencegah komplikasi yang mungkin timbul akibat metode pemberian nutrisi yang tidak tepat (Wischmeyer, 2022).

Secara legal, keputusan nutrisi harus didasarkan pada informed consent yang jelas dari pasien atau keluarga setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai manfaat, risiko, dan alternatif metode pemberian nutrisi tersebut. Dalam kasus pasien yang tidak mampu memberikan persetujuan secara langsung, maka proses pengambilan keputusan harus melibatkan keluarga atau perwakilan hukum dengan dukungan komite etik rumah sakit untuk memastikan keputusan yang dibuat sesuai dengan keinginan pasien serta prinsip-prinsip etis yang berlaku (Singer et al., 2023).

Perawat berperan penting dalam mendokumentasikan secara lengkap seluruh proses pengambilan keputusan nutrisi, memastikan transparansi

informasi, serta memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga mengenai implikasi klinis, hukum, dan etika dari pilihan metode nutrisi yang akan diterapkan (Heyland et al., 2022).

H. Advokasi, Komunikasi, dan Dokumentasi dalam Praktik Keperawatan Kritis

1. Teknik advokasi pasien dalam situasi kritis

Advokasi pasien merupakan peran penting perawat kritis dalam memastikan hak, kebutuhan, dan preferensi pasien dipenuhi, terutama saat pasien tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri. Teknik advokasi meliputi pengenalan kebutuhan pasien secara detail, mewakili suara pasien dalam pengambilan keputusan klinis, serta mendukung keluarga dalam memahami pilihan-pilihan perawatan (Choi et al., 2023).

Strategi advokasi melibatkan tindakan asertif dalam menyampaikan kekhawatiran klinis kepada tim medis, memastikan transparansi informasi mengenai prosedur dan intervensi, serta berperan aktif dalam diskusi etis untuk pengambilan keputusan terbaik bagi pasien (Warelow et al., 2022). Advokasi yang efektif mampu meningkatkan kualitas asuhan, keselamatan pasien, serta kepuasan pasien dan keluarganya (Shin & Youn, 2022).

2. Komunikasi efektif dalam tim multidisiplin

Komunikasi efektif dalam tim multidisiplin sangat penting untuk memastikan koordinasi pelayanan kesehatan yang optimal di unit perawatan kritis. Komunikasi ini mencakup pertukaran informasi yang jelas, akurat, serta tepat waktu antar berbagai profesi seperti dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, dan anggota tim lain (Manias, 2022).

Teknik komunikasi seperti Situation-Background-Assessment-Recommendation (SBAR), briefing harian, serta dokumentasi elektronik terpadu terbukti efektif mengurangi kesalahan klinis dan meningkatkan keselamatan pasien di ICU (Oldland et al., 2022). Selain itu, kemampuan perawat dalam mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menyelesaikan konflik secara profesional merupakan elemen penting dalam menjaga dinamika kerja tim multidisiplin yang harmonis (Foronda et al., 2021).

3. Pentingnya dokumentasi keperawatan yang akurat dan komprehensif

Dokumentasi keperawatan merupakan aspek fundamental dalam praktik keperawatan kritis, berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota tim, dasar hukum tindakan yang dilakukan, dan bukti akuntabilitas profesional. Dokumentasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sangat penting dalam mempertahankan kualitas asuhan, serta mencegah potensi litigasi atau kesalahan medis (Blair & Smith, 2022).

Perawat di unit kritis harus secara cermat mencatat kondisi klinis pasien, intervensi yang dilakukan, respons pasien terhadap intervensi, serta rencana tindak lanjut dalam format dokumentasi yang terstandardisasi. Dokumentasi ini juga menjadi bukti valid dalam konteks hukum jika terjadi sengketa medis atau malpraktik, sehingga perawat wajib memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang dicatat (Mutshatshi et al., 2022). Implementasi sistem dokumentasi elektronik yang terintegrasi di ICU membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta ketersediaan informasi klinis secara real-time untuk seluruh anggota tim multidisiplin (Raza et al., 2021).

I. Latihan Soal

Kasus 1: (Konsep Dasar Keperawatan Kritis)

Seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun masuk ke ruang ICU setelah mengalami serangan jantung dengan kondisi hemodinamik yang tidak stabil, memerlukan pemantauan tekanan darah, saturasi oksigen, dan irama jantung secara terus-menerus. Dalam konteks ini, ruang lingkup perawat kritis adalah:

- A. Memberikan edukasi pasien tentang pengelolaan penyakit kronis
- B. Melakukan pengkajian dasar saat pasien baru tiba
- C. Memantau parameter vital pasien secara ketat dan kontinu
- D. Memberikan obat-obatan dasar untuk gejala ringan
- E. Merujuk pasien ke unit rawat jalan untuk evaluasi berkala

Jawaban: C

Rasional:

Ruang lingkup utama keperawatan kritis adalah memberikan asuhan intensif melalui pemantauan ketat parameter fisiologis secara terus-menerus untuk mencegah komplikasi dan menjaga kestabilan pasien (Vincent et al., 2022).

Kasus 2: (Aspek Legal – Informed Consent)

Seorang pasien wanita usia 40 tahun di ruang ICU membutuhkan tindakan intubasi emergensi karena penurunan kesadaran mendadak. Suaminya ada di tempat dan dalam kondisi sadar penuh. Sebelum prosedur dilakukan, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh perawat adalah:

- A. Segera lakukan intubasi tanpa persetujuan karena ini kondisi emergensi
- B. Jelaskan secara singkat kondisi kritis dan risiko prosedur kepada suami, lalu minta persetujuan verbal
- C. Tidak perlu meminta persetujuan karena keluarga telah hadir
- D. Menunggu pasien sadar untuk mendapatkan informed consent

E. Meminta dokter menjelaskan tindakan setelah selesai dilakukan

Jawaban: B

Rasional:

Dalam situasi kritis, informed consent harus diberikan oleh keluarga terdekat jika pasien tidak mampu mengambil keputusan, dengan menjelaskan secara singkat kondisi dan risiko tindakan (Wijayanti et al., 2022).

Kasus 3: (Aspek Etis – Prinsip Etika)

Pasien usia 75 tahun dengan gagal napas berat menggunakan ventilasi mekanik selama dua minggu tanpa perbaikan signifikan. Keluarga pasien mempertanyakan manfaat dari penggunaan ventilator tersebut. Prinsip etika apa yang paling relevan digunakan perawat dalam situasi ini?

- A. Otonomi
- B. Benefisensi
- C. Non-malefisensi
- D. Keadilan
- E. Konfidensialitas

Jawaban: B

Rasional:

Prinsip benefisensi mengarahkan perawat untuk mengevaluasi apakah intervensi medis (ventilator) memberikan manfaat nyata bagi pasien, terutama dalam konteks pemakaian jangka panjang tanpa perbaikan klinis (Rosenthal, 2021).

Kasus 4: (Asuhan Sistem Neurologi – Stroke Akut)

Pasien wanita usia 60 tahun tiba di unit stroke dengan keluhan kelemahan mendadak pada sisi kiri tubuh dan bicara pelo sejak 1 jam yang lalu. Pemeriksaan menunjukkan stroke iskemik akut. Tindakan keperawatan prioritas pertama yang harus dilakukan adalah:

- A. Mengajarkan latihan mobilisasi dini
- B. Mengatur nutrisi enteral dini
- C. Melakukan pengukuran saturasi oksigen dan tekanan darah secara intensif
- D. Melakukan skrining gangguan menelan
- E. Memberikan edukasi keluarga tentang komplikasi jangka panjang

Jawaban: C

Rasional:

Penanganan awal stroke akut adalah memantau tanda-tanda vital secara ketat untuk mencegah komplikasi seperti hipertensi atau hipotensi yang memperburuk kondisi iskemik (Harrison et al., 2022).

Kasus 5: (Advokasi dan Komunikasi dalam Keperawatan Kritis)

Seorang pasien laki-laki usia 45 tahun, dengan cedera otak berat di ruang ICU, keluarga pasien mengalami kesulitan dalam memahami informasi medis yang disampaikan dokter tentang prognosis pasien. Langkah advokasi terbaik yang dilakukan oleh perawat adalah:

- A. Menyarankan keluarga mencari informasi tambahan secara mandiri
- B. Mengabaikan kebingungan keluarga karena ini bukan tugas utama perawat
- C. Memfasilitasi komunikasi antara dokter dan keluarga dengan menjelaskan ulang secara sederhana
- D. Meminta dokter memberikan informasi secara tertulis tanpa penjelasan tambahan
- E. Mengalihkan pembahasan pada masalah administratif dan finansial saja

Jawaban: C

Rasional:

Advokasi pasien meliputi fasilitasi komunikasi efektif antara dokter dan keluarga, memastikan informasi medis kompleks disampaikan secara jelas dan mudah dimengerti untuk mendukung pengambilan keputusan klinis (Choi et al., 2023).

J. Rangkuman Materi

Keperawatan kritis merupakan bidang keperawatan khusus yang berfokus pada penanganan pasien dengan kondisi kompleks, berisiko tinggi, dan mengancam jiwa, serta membutuhkan intervensi intensif secara terus-menerus. Dalam praktiknya, integrasi aspek legal dan etis sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien, melindungi hak pasien, serta mencegah risiko litigasi. Perawat kritis wajib memahami kerangka hukum praktik keperawatan di Indonesia, sistem kridensial dan lisensi, pentingnya informed consent, serta dokumentasi medis yang akurat dan komprehensif sebagai bukti hukum dan komunikasi efektif antar tim.

Dalam aspek etis, perawat kritis mengimplementasikan prinsip-prinsip etika seperti otonomi, benefisensi, non-malefisensi, dan keadilan untuk mengambil keputusan klinis terbaik bagi pasien. Dilema etis dalam praktik keperawatan kritis diselesaikan melalui pendekatan sistematis yang melibatkan komunikasi terbuka antar tim multidisiplin dan dukungan dari komite serta konsultasi etik.

Perawat kritis juga memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan intensif pada berbagai sistem tubuh, seperti kardiovaskuler, respirasi, neurologi, dan gastrointestinal. Tugas ini mencakup pemantauan ketat kondisi pasien, manajemen ventilasi mekanik, penanganan kondisi akut seperti gagal

jantung, syok kardiogenik, ARDS, stroke, dan perdarahan gastrointestinal masif. Selain itu, perawat kritis harus mampu mengelola nutrisi pasien secara tepat, baik secara enteral maupun parenteral, serta menghadapi tantangan legal-etis terkait keputusan kritis seperti penghentian life-support atau ventilasi jangka panjang.

Terakhir, perawat kritis harus memiliki keterampilan advokasi yang efektif, komunikasi yang jelas dan tepat antar tim multidisiplin, serta kemampuan dokumentasi yang akurat, lengkap, dan sistematis untuk memastikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan sesuai standar hukum serta etika profesi. Integrasi semua komponen tersebut memastikan tercapainya pelayanan keperawatan kritis yang optimal dan humanis.

K. Glosarium

Acute Heart Failure (AHF)

Kondisi darurat medis dengan gejala tiba-tiba atau memburuknya gejala gagal jantung kronis, seperti sesak napas, edema paru, dan gangguan perfusi organ vital.

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Sindrom gagal napas berat yang ditandai oleh edema paru non-kardiogenik, hipoksia berat, dan membutuhkan ventilasi mekanik jangka panjang.

Advokasi Pasien

Tindakan perawat dalam menyuarkan kebutuhan, preferensi, dan hak pasien yang tidak mampu menyampaikan sendiri karena kondisi medis tertentu.

Benefisiensi

Prinsip etika yang menuntut tindakan keperawatan harus memberikan manfaat nyata kepada pasien.

Cedera Otak Traumatik (Traumatic Brain Injury/TBI)

Gangguan fungsi otak akibat benturan atau trauma kepala, yang memerlukan pemantauan ketat fungsi neurologis.

Dokumentasi Keperawatan

Catatan sistematis tentang kondisi pasien, intervensi, respons, dan rencana perawatan yang memiliki nilai hukum dan komunikasi antar tim kesehatan.

Edema Serebral

Pembengkakan jaringan otak akibat akumulasi cairan, sering terjadi pada kondisi neurologis akut seperti stroke dan cedera otak traumatik.

Gagal Ginjal Akut

Penurunan cepat fungsi ginjal akibat berbagai kondisi kritis, memerlukan manajemen cairan dan elektrolit yang ketat.

Glasgow Coma Scale (GCS)

Skala penilaian fungsi neurologis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien.

Informed Consent

Persetujuan pasien atau perwakilan legal yang diberikan setelah mendapat informasi lengkap mengenai manfaat, risiko, dan alternatif intervensi medis atau keperawatan.

Intensive Care Unit (ICU)

Unit perawatan intensif yang menyediakan layanan medis dan keperawatan bagi pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan pemantauan intensif.

Keadilan (Justice)

Prinsip etika yang menuntut perlakuan adil terhadap semua pasien, tanpa diskriminasi dalam pemberian layanan kesehatan maupun alokasi sumber daya medis.

Keperawatan Kritis

Bidang keperawatan khusus yang menangani pasien dengan kondisi kompleks, berisiko tinggi, dan mengancam jiwa, dengan intervensi medis dan keperawatan intensif.

Komite Etik

Tim yang bertugas memberikan konsultasi dan rekomendasi dalam menyelesaikan dilema etis dalam praktik klinis.

Non-malefisensi

Prinsip etika yang menekankan pentingnya mencegah cedera atau bahaya tambahan kepada pasien.

Nutrisi Enteral dan Parenteral

Pemberian nutrisi melalui saluran pencernaan (enteral) atau melalui pembuluh darah (parenteral), dengan pertimbangan medis, etis, dan legal khususnya pada pasien kritis.

Pankreatitis Akut Berat

Inflamasi berat pada pankreas yang disertai komplikasi sistemik dan memerlukan perawatan intensif.

Pemantauan Hemodinamik

Pemantauan ketat terhadap status sirkulasi darah pasien, termasuk tekanan darah dan curah jantung.

Perdarahan Gastrointestinal Masif

Kehilangan darah dalam jumlah besar dari saluran pencernaan, memerlukan penanganan emergensi berupa resusitasi cairan dan transfusi darah.

Perfusi Serebral

Aliran darah yang mencukupi ke otak untuk menjaga fungsi neurologis, penting pada pasien dengan kondisi neurologis kritis.

Positioning Pronasi (Prone Position)

Posisi pasien dengan tubuh menghadap bawah yang digunakan untuk memperbaiki oksigenasi pada pasien ARDS.

Resusitasi Jantung Paru (CPR)

Tindakan emergensi untuk mengembalikan sirkulasi darah dan pernapasan pada pasien yang mengalami henti jantung dan napas.

Sistem Kridensial dan Lisensi Keperawatan

Proses pemberian kewenangan praktik kepada perawat berdasarkan kompetensi klinis, pendidikan, dan pengalaman khusus dalam bidang tertentu, seperti keperawatan kritis.

Situation-Background-Assessment-Recommendation (SBAR)

Teknik komunikasi efektif yang digunakan dalam tim multidisiplin untuk mengurangi kesalahan klinis di lingkungan perawatan kritis.

Syok Kardiogenik

Kondisi darurat akibat penurunan curah jantung signifikan yang menyebabkan hipoperfusi organ vital, memerlukan stabilisasi segera.

Ventilasi Mekanik

Intervensi medis kritis berupa penggunaan mesin ventilator untuk mendukung fungsi pernapasan pada pasien dengan gagal napas akut atau kronis.

Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)

Infeksi paru-paru yang terjadi akibat penggunaan ventilasi mekanik dalam waktu lama.

L. Daftar Pustaka

- Abidin, M., & Ristanto, R. (2021). Pentingnya informed consent dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13(1), 45-53.
- Akbar, M., & Susilowati, Y. (2021). Dokumentasi keperawatan sebagai aspek legal dalam praktik keperawatan kritis. *Jurnal Keperawatan Profesional Indonesia*, 3(2), 79-85.
- Aoyama, H., Uchida, K., & Arai, T. (2022). Nursing interventions for ARDS: Positioning and monitoring. *Journal of Intensive Care*, 10(1), 34-41.
- Arrigo, M., Jessup, M., & Mullens, W. (2022). Acute heart failure: Epidemiology, diagnosis, and management. *Circulation*, 145(8), 637-648.
- Blair, W., & Smith, L. (2022). Improving nursing documentation practices in critical care: A systematic review. *Intensive and Critical Care Nursing*, 69, 103197.
- Blythe, J., Thompson, D. R., & Crawford, G. B. (2022). Ethical considerations in long-term ventilation. *Nursing Ethics*, 29(6), 1523-1535.
- Boxhoorn, L., Voermans, R. P., & Besselink, M. G. (2021). Acute pancreatitis: Recent advances through randomized trials. *Gut*, 70(10), 2024-2032.
- Carney, N., Maas, A. I. R., & Menon, D. K. (2023). Management of severe traumatic brain injury: Recent advancements. *Journal of Neurotrauma*, 40(2), 112-119.
- Choi, H., Kang, J., & Park, Y. (2023). Nurses' experiences with patient advocacy in critical care units. *Journal of Advanced Nursing*, 79(2), 611-622.
- Corley, M. C., & Minick, P. (2022). Nurse advocacy and patient safety in critical care units. *Critical Care Nursing Quarterly*, 45(3), 200-209.
- Damayanti, R., Sudirman, J., & Ningsih, E. (2022). Standar dokumentasi rekam medis dalam perspektif hukum. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(2), 210-217.
- DeMartino, E. S., Braus, N. A., & Sulmasy, D. P. (2021). Legal and ethical issues in discontinuation of life-support. *Chest*, 160(3), 1067-1074.
- Foronda, C., MacWilliams, B., & McArthur, E. (2021). Interprofessional communication in healthcare: An integrative review. *Nurse Education in Practice*, 52, 103031.
- Fowler, M. D. (2023). Ethics in critical care nursing practice. *American Journal of Critical Care*, 32(1), 13-21.
- Frost, D. W., Cook, D. J., & Heyland, D. K. (2022). Ethical and legal considerations in CPR decisions in critical care. *Journal of Critical Care Ethics*, 12(1), 15-23.
- Hanifa, F., & Anshori, I. (2022). Implementasi prinsip etika dalam pelayanan keperawatan kritis. *Jurnal Etika Kesehatan*, 8(2), 101-108.

- Harrison, D. A., Ferrando-Vivas, P., & Rowan, K. M. (2021). Critical care nursing: Scope and roles. *Critical Care Medicine*, 49(7), 1238-1246.
- Harrison, J. K., Muir, K. W., & Markus, H. S. (2022). Acute stroke management and critical care implications. *Stroke*, 53(6), 1855-1863.
- Hawryluck, L., Sibbald, R., & Downar, J. (2022). Ethical considerations in end-of-life care decisions. *Intensive Care Medicine*, 48(5), 546-553.
- Heyland, D. K., Weijs, P. J. M., & Singer, P. (2022). Optimizing nutrition therapy in critically ill patients. *Critical Care*, 26(1), 134-142.
- Hidayati, S., Utami, D., & Handayani, E. (2023). Peran informed consent dalam praktik keperawatan kritis. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 11(1), 67-74.
- Koami, H., Taniguchi, T., & Nishimura, T. (2022). Current management of cardiogenic shock. *Journal of Intensive Care Medicine*, 37(3), 286-294.
- Langer, T., Brioni, M., & Gattinoni, L. (2021). Ventilator management in critically ill patients. *Journal of the American Medical Association (JAMA)*, 325(7), 710-719.
- Marshall, A. P., Kitson, A., & Zeitz, K. (2021). Patient safety in intensive care units: Nursing roles and responsibilities. *Critical Care Nursing*, 41(4), 56-65.
- McAndrew, N. S., Schiffman, R., & Leske, J. (2020). Ethics in nursing practice: Autonomy and decision-making. *Nursing Ethics*, 27(2), 335-344.
- Mentzelopoulos, S. D., Couper, K., & Perkins, G. D. (2021). Ethical aspects of resuscitation and end-of-life decisions. *Resuscitation*, 162, 318-326.
- Numminen, O., Repo, H., & Leino-Kilpi, H. (2020). Ethical principles in nursing practice. *Journal of Advanced Nursing*, 76(3), 560-571.
- Papazian, L., Aubron, C., & Brochard, L. (2022). ARDS management in critical care. *Intensive Care Medicine*, 48(6), 736-748.
- Pham, T., Brochard, L. J., & Slutsky, A. S. (2021). Mechanical ventilation: State-of-the-art review. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 203(6), 683-691.
- Ulrich, C. M., Taylor, C., & Grady, C. (2021). Ethical decision-making in critical care nursing. *Nursing Outlook*, 69(3), 315-323.
- Vincent, J. L., & Creteur, J. (2022). Ethical considerations in critical care. *Critical Care*, 26(1), 2-8.
- Wijayanti, E., Ratnawati, L., & Rahayu, S. (2022). Informed consent dalam perspektif hukum kesehatan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 6(2), 89-95.
- Wischmeyer, P. E. (2022). Enteral versus parenteral nutrition in critical illness. *Critical Care Clinics*, 38(2), 317-331.

BAB 6

TREN DAN ISU DALAM KEPERAWATAN KRITIS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran tentang tren dan isu dalam keperawatan kritis, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan terbaru dan memahami implikasi strategis dalam praktik keperawatan kritis, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara holistik, profesional, dan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu mengevaluasi secara kritis dan mengaplikasikan pengetahuan tentang tren dan isu terkini dalam keperawatan kritis dalam konteks pelayanan klinis nyata.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi tren global dan nasional yang berdampak signifikan pada praktik keperawatan kritis, seperti pandemi dan peningkatan penyakit kronis.
- Menganalisis penggunaan teknologi digital, telehealth, dan sistem informasi kesehatan dalam praktik keperawatan kritis.
- Menjelaskan isu-isu etika dan hukum yang muncul dalam konteks pengambilan keputusan klinis dan perawatan pasien kritis.
- Mengkaji strategi manajemen nyeri, sedasi, dan delirium secara efektif serta berbasis bukti pada pasien dalam perawatan intensif.
- Mengevaluasi dampak keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan alat medis terhadap kualitas layanan keperawatan kritis.
- Mengidentifikasi dampak psikologis dan emosional yang dialami perawat kritis serta mengusulkan strategi pencegahan stres dan burnout.
- Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan praktik keperawatan kritis berdasarkan analisis tren dan isu terkini serta pendekatan berbasis bukti.

Pendahuluan

Keperawatan kritis adalah spesialisasi dalam bidang keperawatan yang fokus memberikan perawatan intensif pada pasien dengan kondisi kritis atau mengancam jiwa yang memerlukan pemantauan terus-menerus. Kemajuan dalam teknologi medis, peningkatan prevalensi penyakit kronis, dan tantangan kesehatan global seperti pandemi telah mendorong evolusi dalam keperawatan kritis. Selain itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya hak pasien, keselamatan pasien, serta penggunaan teknologi digital dalam perawatan intensif turut menciptakan dinamika baru dalam praktik keperawatan kritis.

Berbagai isu penting juga muncul, termasuk dilema etika dan legal dalam pengambilan keputusan klinis, optimalisasi manajemen nyeri dan sedasi, keterbatasan sumber daya, serta tantangan psikologis yang dihadapi perawat seperti stres dan burnout. Pemahaman mendalam terhadap tren dan isu ini sangat penting agar perawat mampu menghadapi tantangan tersebut secara efektif, serta memberikan perawatan yang aman, efektif, dan humanistik.

Uraian Materi

A. Tren Global dan Nasional

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi berbagai perubahan yang signifikan dalam bidang kesehatan, khususnya dalam keperawatan kritis. Tren global yang paling menonjol adalah peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker yang membutuhkan perawatan intensif dan berkelanjutan di fasilitas kesehatan yang mumpuni. Selain itu, munculnya berbagai infeksi emergen seperti COVID-19 telah menempatkan tantangan baru yang sangat besar bagi sistem kesehatan global, khususnya layanan keperawatan kritis.

Pandemi COVID-19, yang dimulai sejak akhir tahun 2019, menjadi titik balik penting bagi dunia dalam mengevaluasi kembali kesiapan sistem pelayanan kesehatan intensif. Virus ini menyebabkan lonjakan pasien dalam kondisi kritis secara tiba-tiba dan masif di seluruh dunia, yang memaksa rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas ruang perawatan intensif (ICU) dan sumber daya pendukung lainnya seperti ventilator mekanik dan alat pelindung diri (APD). Tren ini juga menekankan pentingnya keahlian khusus para tenaga keperawatan dalam menangani pasien dengan komplikasi pernapasan berat, kegagalan multi-organ, dan kondisi medis kompleks lainnya.

Secara global, meningkatnya jumlah kasus yang membutuhkan perawatan kritis telah menstimulasi berbagai inovasi di bidang teknologi kesehatan, seperti penggunaan alat monitoring yang lebih canggih, telemedicine untuk layanan jarak jauh, hingga pengembangan protokol perawatan intensif berbasis bukti yang lebih efektif. Selain itu, pendidikan dan pelatihan lanjutan dalam bidang keperawatan kritis juga semakin mendapat perhatian besar dari berbagai institusi kesehatan dunia, dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan ketahanan tenaga kesehatan menghadapi krisis kesehatan mendadak di masa depan.

Pada tingkat nasional, tren global tersebut juga tercermin dengan jelas dalam sistem kesehatan di Indonesia. Pertumbuhan jumlah kasus penyakit kronis di Indonesia menunjukkan pola yang serupa dengan tren global, yang secara langsung meningkatkan permintaan terhadap pelayanan keperawatan kritis yang berkualitas. Ditambah lagi, wabah COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga yang mendorong pemerintah dan fasilitas kesehatan nasional untuk memperkuat infrastruktur kesehatan kritis, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

Pemerintah Indonesia pun merespons tantangan tersebut melalui berbagai kebijakan strategis, seperti penambahan kapasitas ICU, pengadaan ventilator, pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis digital, serta peningkatan

investasi pada pelatihan sumber daya manusia keperawatan khususnya dalam manajemen pasien kritis. Adaptasi terhadap protokol layanan kesehatan yang baru seperti isolasi pasien, pencegahan infeksi, dan penerapan pedoman pelayanan kritis berbasis bukti menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia.

Tren nasional juga mencerminkan peningkatan signifikan dalam kebutuhan tenaga keperawatan kritis yang kompeten, terlatih, dan tersertifikasi. Institusi pendidikan tinggi keperawatan dan rumah sakit secara bertahap memperkuat kolaborasi untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan khusus yang sesuai dengan tuntutan praktik keperawatan kritis modern. Pengembangan kompetensi spesifik seperti manajemen pasien ventilasi mekanik, penggunaan teknologi pemantauan hemodinamik, serta penanganan pasien dalam situasi darurat dan kompleks menjadi fokus utama dalam kurikulum keperawatan saat ini.

Dengan demikian, baik tren global maupun nasional menunjukkan bahwa keperawatan kritis bukan lagi sekadar pelayanan pendukung biasa, tetapi telah menjadi tulang punggung yang menentukan keberhasilan sistem kesehatan dalam menghadapi tantangan kompleks masa kini dan masa depan. Penguatan kapasitas fasilitas, tenaga keperawatan, serta adaptasi terhadap perubahan protokol layanan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien dalam kondisi kritis.

B. Teknologi Digital dan Telehealth

Kemajuan teknologi digital di era modern ini memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan khususnya dalam praktik keperawatan kritis. Salah satu implementasi teknologi digital yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah penerapan rekam medis elektronik (electronic medical record/EMR). Rekam medis elektronik ini memungkinkan seluruh data pasien, mulai dari riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan laboratorium, laporan radiologi, hingga rencana asuhan keperawatan tercatat secara terintegrasi dalam satu sistem digital. Penggunaan EMR dalam keperawatan kritis membawa banyak keuntungan, di antaranya efisiensi layanan yang meningkat karena kemudahan akses data pasien, pengurangan risiko kesalahan akibat tulisan tangan yang sulit dibaca, serta peningkatan koordinasi antar tenaga kesehatan dalam tim multidisiplin, yang akhirnya menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Selain rekam medis elektronik, kemajuan signifikan juga tampak pada teknologi pemantauan pasien jarak jauh atau telemonitoring. Telemonitoring memungkinkan tenaga keperawatan untuk memantau kondisi pasien kritis secara real-time tanpa harus berada di samping pasien secara fisik sepanjang waktu.

Melalui sensor-sensor canggih yang terhubung dengan sistem pemantauan pusat, tanda-tanda vital pasien seperti detak jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, laju pernapasan, dan parameter hemodinamik lainnya dapat dipantau dengan akurasi tinggi dari lokasi yang berbeda. Teknologi ini sangat penting dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kontak fisik langsung dengan pasien harus diminimalkan untuk mengurangi risiko transmisi penyakit. Dengan telemonitoring, tenaga kesehatan dapat segera mengambil tindakan intervensi ketika ditemukan kondisi abnormal pada pasien, sehingga mencegah terjadinya komplikasi serius yang dapat berujung fatal.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga mendorong penerapan telekonsultasi (teleconsultation) dalam keperawatan kritis. Telekonsultasi memungkinkan para perawat, dokter, atau spesialis medis untuk memberikan konsultasi atau rekomendasi pengelolaan pasien secara jarak jauh melalui platform digital yang aman dan terpercaya. Dalam situasi kritis di mana waktu merupakan faktor yang menentukan, telekonsultasi mempercepat proses pengambilan keputusan medis. Sebagai contoh, seorang perawat di ruang ICU di rumah sakit daerah terpencil dapat berkonsultasi secara langsung dengan spesialis di rumah sakit pusat mengenai strategi penanganan pasien yang mengalami kondisi kritis kompleks. Hal ini tentu saja mampu meningkatkan kualitas asuhan yang diterima pasien, mengurangi waktu tunggu intervensi, serta memperbesar peluang kesembuhan pasien yang dirawat.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi digital seperti rekam medis elektronik, telemonitoring, dan telekonsultasi dalam keperawatan kritis menjadi sangat strategis dan penting. Implementasi teknologi-teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat kualitas data klinis yang diperoleh, serta meningkatkan responsivitas terhadap perubahan kondisi pasien secara real-time. Dalam konteks jangka panjang, adopsi teknologi digital diharapkan akan terus berkembang sehingga mampu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, terutama dalam memberikan layanan perawatan kritis yang berkualitas tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan konvensional.

C. Isu Etika dan Legal

Keperawatan kritis adalah bidang pelayanan kesehatan yang sangat sensitif dan kompleks, tidak hanya karena kondisi pasien yang sangat serius atau kritis, tetapi juga karena tingginya intensitas interaksi antara tim perawat, pasien, dan keluarga pasien. Dalam konteks ini, sering kali muncul berbagai dilema etika yang rumit, yang membutuhkan pertimbangan moral dan profesional yang cermat. Salah

satu dilema etika yang paling sering terjadi dalam keperawatan kritis adalah keputusan mengenai penghentian atau tidak dilakukannya tindakan resusitasi jantung paru (do-not-resuscitate/DNR). Keputusan ini menjadi dilema karena melibatkan pertimbangan tentang kualitas hidup pasien setelah tindakan resusitasi dilakukan, prognosis medis yang buruk, serta aspek kemanusiaan, terutama ketika pasien berada dalam kondisi terminal atau harapan hidupnya sudah sangat kecil.

Selain itu, dilema mengenai penghentian dukungan hidup atau withdrawal of life support juga menjadi isu etika yang sangat menonjol. Keputusan ini melibatkan berbagai pertimbangan, seperti kondisi medis pasien, kehendak pasien atau keluarga, serta pandangan budaya, agama, dan keyakinan pribadi yang dianut oleh pasien dan keluarganya. Dalam kondisi kritis, sering kali terjadi konflik antara keluarga yang berharap pasien tetap diberikan dukungan hidup meski prognosis medis sudah tidak menguntungkan, dengan tim kesehatan yang memiliki pandangan profesional bahwa melanjutkan terapi hanya akan menambah penderitaan pasien tanpa manfaat medis yang jelas. Dalam situasi seperti ini, tenaga perawat memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara keluarga dan tim medis serta dalam memberikan dukungan emosional yang diperlukan agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip etika keperawatan.

Selain dilema terkait resusitasi dan penghentian dukungan hidup, masalah lain yang juga sangat penting adalah etika dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Situasi pandemi COVID-19 menunjukkan secara nyata bagaimana kelangkaan sumber daya seperti ventilator, tempat tidur ICU, obat-obatan, atau peralatan pelindung diri bisa memunculkan situasi sulit dalam menentukan pasien mana yang harus diprioritaskan. Tenaga keperawatan, dalam hal ini, harus memahami prinsip keadilan distributif (distributive justice) yang menekankan bahwa alokasi sumber daya harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kebutuhan klinis yang jelas serta potensi manfaat tertinggi untuk pasien.

Di samping dilema etika, isu legal dalam keperawatan kritis juga menjadi perhatian utama, terutama terkait perlindungan hukum terhadap tenaga perawat dan pemenuhan hak-hak pasien. Dalam menjalankan tugasnya, perawat kritis rentan menghadapi risiko hukum, terutama dalam kasus kegagalan terapi, keluhan keluarga, atau adanya tuduhan kelalaian medis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang batasan hukum dan tanggung jawab profesi perawat menjadi mutlak diperlukan agar perawat dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan percaya diri. Perawat perlu mengetahui berbagai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan, hingga regulasi terkait hak-hak pasien, seperti hak atas informasi medis yang jelas, hak memberikan atau menolak tindakan medis (informed consent dan informed refusal),

serta hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan data medis mereka.

Perlindungan hukum terhadap perawat sendiri merupakan aspek penting dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan kerja perawat. Perlindungan hukum ini mencakup jaminan bahwa tindakan perawat yang dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan kompetensi profesinya akan terlindungi secara hukum. Hal ini berarti bahwa sepanjang tindakan yang dilakukan perawat berada dalam koridor standar profesi dan kode etik yang berlaku, maka perawat tersebut akan mendapatkan perlindungan apabila timbul masalah hukum di kemudian hari.

Secara keseluruhan, isu etika dan legal dalam keperawatan kritis adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Tenaga perawat kritis harus memahami dengan baik berbagai dilema etika yang mungkin terjadi serta mampu mengambil keputusan secara profesional, bijaksana, dan empatik. Selain itu, pemahaman terhadap isu hukum juga penting agar perawat mampu menjalankan tugasnya secara profesional tanpa mengabaikan hak-hak pasien serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan berkualitas dalam pelayanan keperawatan kritis.

D. Manajemen Nyeri, Sedasi, dan Delirium

Manajemen nyeri, sedasi, dan delirium adalah tiga aspek esensial yang sangat berkaitan satu sama lain dalam konteks pelayanan keperawatan kritis. Ketiga hal ini secara signifikan memengaruhi tidak hanya kenyamanan pasien, tetapi juga proses penyembuhan dan hasil akhir dari perawatan pasien yang mengalami kondisi kritis atau berat di unit perawatan intensif (ICU).

Nyeri merupakan pengalaman subjektif yang umum dialami oleh pasien di ruang perawatan intensif, baik akibat penyakitnya sendiri maupun dari prosedur invasif seperti intubasi endotrakeal, pemasangan kateter, pemasangan akses intravena, atau tindakan bedah. Manajemen nyeri yang efektif tidak sekadar mengurangi ketidaknyamanan pasien, tetapi juga secara langsung berdampak pada percepatan proses penyembuhan, pengurangan stres fisiologis dan psikologis, serta meningkatkan kualitas hidup pasien setelah keluar dari ICU. Pendekatan manajemen nyeri yang berbasis bukti ilmiah umumnya melibatkan penilaian nyeri secara sistematis dan rutin menggunakan skala nyeri yang sesuai kondisi pasien, seperti Numeric Rating Scale (NRS) atau Critical Care Pain Observation Tool (CPOT). Selain itu, pemberian analgesik harus dilakukan secara terencana, sesuai kebutuhan individu pasien dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala untuk memastikan pencapaian target terapi yang optimal.

Penggunaan sedasi merupakan aspek penting berikutnya dalam perawatan kritis. Sedasi diberikan untuk membantu pasien menjalani perawatan yang tidak nyaman, mengurangi kecemasan, serta memastikan stabilitas pasien selama prosedur invasif atau ventilasi mekanik. Meskipun penting, penggunaan sedasi harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sedasi yang terlalu dalam atau berkepanjangan bisa memperlambat pemulihan pasien, menyebabkan komplikasi tambahan seperti gangguan pernapasan atau hipotensi, serta memperpanjang durasi rawat inap. Oleh karena itu, pendekatan terbaru dalam sedasi menekankan strategi minimalisasi sedasi atau menggunakan sedasi ringan (light sedation), dengan pemantauan ketat menggunakan skala sedasi yang valid seperti Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) atau Sedation-Agitation Scale (SAS). Strategi ini membantu pasien tetap dalam kondisi sedasi yang adekuat tanpa menghilangkan kemampuan untuk merespons rangsangan secara tepat, sehingga mempermudah proses pemantauan klinis, meningkatkan partisipasi pasien dalam perawatan, serta mempercepat proses penyapihan dari ventilasi mekanik.

Delirium merupakan masalah yang sering muncul pada pasien yang dirawat di ICU, terutama mereka yang mengalami ventilasi mekanik, penyakit berat, atau usia lanjut. Delirium merupakan kondisi gangguan kesadaran akut yang ditandai dengan perubahan status mental secara fluktuatif, disorientasi, kebingungan, halusinasi, hingga agitasi berat. Kondisi ini dapat memperpanjang durasi rawat inap, meningkatkan mortalitas, serta meninggalkan dampak jangka panjang berupa gangguan fungsi kognitif permanen pada pasien. Oleh sebab itu, pencegahan, deteksi dini, dan penanganan delirium merupakan bagian penting dari praktik keperawatan kritis yang berbasis bukti.

Strategi pencegahan delirium mencakup optimalisasi lingkungan perawatan, seperti menjaga orientasi pasien terhadap waktu dan tempat melalui interaksi yang jelas dan konsisten, menjaga siklus tidur-bangun pasien, mengurangi kebisingan berlebih, serta mengelola nyeri dan kecemasan secara efektif. Penggunaan instrumen skrining delirium yang telah tervalidasi seperti Confusion Assessment Method for ICU (CAM-ICU) secara rutin sangat penting untuk mendeteksi munculnya delirium secara dini, sehingga memungkinkan intervensi segera dilakukan sebelum kondisi pasien semakin memburuk.

Ketiga aspek ini—manajemen nyeri, sedasi, dan delirium—harus dilaksanakan secara holistik dan integratif. Artinya, penanganan salah satu aspek tidak boleh dilakukan secara terpisah atau diabaikan aspek lainnya. Setiap intervensi harus didasarkan pada bukti ilmiah terkini, menggunakan panduan klinis terbaru seperti yang dikembangkan oleh Society of Critical Care Medicine (SCCM) atau panduan lokal yang telah disesuaikan dengan standar internasional. Selain itu, pendekatan

individualisasi perawatan harus tetap diperhatikan mengingat setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda berdasarkan kondisi medis, usia, tingkat keparahan penyakit, serta respons fisiologis terhadap intervensi yang diberikan.

Dengan demikian, pendekatan terpadu dalam manajemen nyeri yang efektif, penggunaan sedasi yang tepat, serta pencegahan dan penanganan delirium yang berbasis bukti ilmiah dan individualisasi pasien merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan kritis secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, hasil perawatan pasien yang lebih baik dapat tercapai, tidak hanya dalam jangka pendek selama perawatan di ICU, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup pasien secara berkelanjutan setelah mereka keluar dari ruang perawatan intensif.

E. Keterbatasan Sumber Daya

Dalam praktik keperawatan kritis, keterbatasan sumber daya merupakan suatu tantangan nyata yang sering kali dihadapi oleh tenaga kesehatan. Tantangan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di berbagai negara maju di seluruh dunia, terutama ketika menghadapi situasi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19 atau bencana alam yang menyebabkan lonjakan kebutuhan layanan intensif dalam waktu singkat.

Salah satu aspek utama keterbatasan sumber daya yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga perawat dengan kompetensi khusus dalam keperawatan kritis. Kondisi ini terjadi karena kebutuhan tenaga keperawatan kritis meningkat pesat, namun tidak selalu sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia. Pelayanan di ruang intensif membutuhkan keahlian yang sangat spesifik, seperti penguasaan ventilasi mekanik, interpretasi pemantauan hemodinamik, manajemen infeksi, hingga kemampuan pengambilan keputusan kritis secara cepat. Akibatnya, tenaga perawat sering kali bekerja dalam kondisi beban kerja tinggi dan risiko kelelahan yang tinggi pula. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien tetapi juga dapat meningkatkan risiko kesalahan medis.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, aspek lain yang juga menjadi tantangan adalah keterbatasan peralatan medis. Di unit perawatan intensif (ICU), keberadaan peralatan seperti ventilator, monitor pasien, pompa infus, alat dialisis kontinu, serta peralatan diagnostik canggih lainnya sangatlah vital. Akan tetapi, realitasnya tidak semua fasilitas kesehatan memiliki peralatan medis yang memadai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien yang kritis secara bersamaan, terutama di fasilitas kesehatan yang berada di daerah terpencil atau fasilitas tingkat kabupaten. Kondisi ini semakin memburuk pada situasi darurat di mana permintaan

terhadap peralatan medis meningkat tajam, sementara pasokan dan ketersediaan alat terbatas.

Selain itu, keterbatasan fasilitas ruang perawatan intensif merupakan tantangan berikutnya yang tidak kalah penting. Jumlah tempat tidur ICU yang terbatas sering kali menjadi hambatan dalam memberikan perawatan intensif yang optimal. Keterbatasan ini dapat menyebabkan penundaan perawatan yang berdampak pada prognosis pasien, atau bahkan mengharuskan tenaga kesehatan mengambil keputusan sulit dalam menentukan prioritas pasien yang perlu mendapatkan perawatan segera. Keterbatasan fasilitas ini sering terlihat jelas pada masa pandemi atau kejadian dengan jumlah pasien kritis yang melonjak tajam secara tiba-tiba.

Karena kondisi ini, mahasiswa keperawatan kritis perlu memahami berbagai strategi untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas agar tetap mampu memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Salah satu strategi penting adalah penggunaan pendekatan triase yang efektif. Triase yang dilakukan secara akurat dan cepat membantu tenaga keperawatan dalam mengidentifikasi pasien yang memerlukan prioritas intervensi medis segera, berdasarkan tingkat kegawatan dan potensi manfaat yang diperoleh pasien. Pendekatan triase ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif, terutama dalam kondisi darurat di mana sumber daya terbatas dan tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pasien secara serentak.

Strategi lainnya adalah meningkatkan kolaborasi antarprofesi serta komunikasi yang efektif di dalam tim pelayanan kesehatan. Kerja sama yang baik antar tenaga kesehatan, seperti antara dokter, perawat, farmasis, ahli gizi, dan tenaga penunjang lainnya, memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang tersedia. Selain itu, komunikasi yang jelas dan terstruktur juga membantu dalam mencegah pemborosan sumber daya akibat tindakan medis yang tumpang tindih atau tidak terkoordinasi dengan baik.

Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan strategi yang penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Dengan memanfaatkan telemedicine dan telemonitoring, perawat dapat memantau dan memberikan konsultasi kepada pasien secara efektif meskipun jumlah tenaga kesehatan terbatas. Teknologi ini memungkinkan pelayanan intensif tetap berlangsung, bahkan ketika jumlah tenaga perawat tidak memadai secara fisik untuk berada di samping pasien sepanjang waktu.

Selain itu, mahasiswa juga perlu memahami konsep alokasi sumber daya yang adil (*distributive justice*), yaitu penggunaan sumber daya secara bijak dan transparan berdasarkan prioritas medis yang jelas serta bukti ilmiah. Pemahaman ini penting

agar mahasiswa memiliki perspektif etika yang kuat dalam menghadapi situasi yang menuntut pengambilan keputusan sulit terkait penggunaan sumber daya yang terbatas.

Dengan demikian, memahami dan mengatasi tantangan keterbatasan sumber daya dalam keperawatan kritis merupakan kemampuan esensial bagi mahasiswa. Keterampilan dalam mengoptimalkan sumber daya, menggunakan pendekatan yang efisien dan tepat, serta berkolaborasi secara efektif merupakan kunci untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, sekaligus memastikan bahwa pelayanan keperawatan kritis tetap efektif bahkan di tengah kondisi yang penuh keterbatasan.

F. Manajemen Stres dan Burnout pada Perawat

Dalam praktik keperawatan kritis, stres dan burnout merupakan masalah nyata yang dihadapi oleh perawat. Hal ini terjadi karena lingkungan kerja di unit perawatan intensif memiliki tantangan yang unik, seperti beban kerja yang tinggi, tanggung jawab yang sangat besar, tuntutan kecepatan pengambilan keputusan yang tepat, serta paparan emosional yang terus-menerus akibat interaksi dengan pasien dalam kondisi kritis dan keluarga pasien yang cemas, khawatir, bahkan sedih. Kondisi tersebut sangat rentan menyebabkan stres akut maupun kronis yang jika tidak dikelola dengan baik akan berkembang menjadi burnout.

Burnout pada perawat merupakan kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang muncul sebagai akibat dari stres kerja yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan dengan baik. Burnout biasanya ditandai dengan perasaan kelelahan yang ekstrem, sikap sinis atau negatif terhadap pekerjaan dan pasien, serta penurunan kinerja profesional. Pada perawat kritis, burnout memiliki konsekuensi serius yang tidak hanya merugikan individu perawat tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan pasien dan kualitas pelayanan yang diberikan. Perawat yang mengalami burnout cenderung mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, penurunan kemampuan konsentrasi, serta meningkatnya risiko kesalahan klinis yang dapat membahayakan pasien.

Mengingat pentingnya masalah ini, mahasiswa keperawatan kritis perlu dilatih sejak dini untuk mengenali gejala-gejala awal stres yang berpotensi berkembang menjadi burnout. Beberapa tanda peringatan burnout yang umum muncul meliputi kelelahan yang terus-menerus, gangguan tidur, mudah marah, menurunnya motivasi kerja, rasa tidak puas terhadap hasil pekerjaan, munculnya pikiran negatif tentang profesi atau tempat kerja, serta perasaan putus asa atau apatis terhadap kondisi pasien. Dengan memahami gejala-gejala ini secara dini, mahasiswa

diharapkan dapat mengambil tindakan preventif yang efektif sebelum burnout menjadi kondisi yang parah dan sulit diatasi.

Dalam mengatasi stres dan burnout, mahasiswa diajarkan berbagai strategi coping yang dapat diterapkan secara individual maupun secara kolektif. Strategi coping merupakan cara yang digunakan untuk mengelola stres secara positif dan konstruktif sehingga tidak berkembang menjadi burnout. Salah satu strategi coping yang sangat dianjurkan adalah pengelolaan emosi secara efektif melalui mindfulness atau latihan kesadaran penuh. Mindfulness membantu perawat untuk tetap berada dalam kondisi mental yang tenang, memusatkan perhatian pada tugas yang dihadapi, serta menerima situasi sulit tanpa merasa terbebani secara berlebihan.

Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan manajemen waktu dan prioritas tugas. Keterampilan ini sangat penting dalam mengelola beban kerja yang tinggi di ICU, karena membantu perawat dalam menentukan prioritas pekerjaan berdasarkan urgensi serta tingkat kepentingannya. Dengan pengelolaan waktu yang efisien, perawat mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih terstruktur, sehingga mengurangi tekanan yang dirasakan.

Strategi penting lainnya adalah penguatan dukungan sosial, baik dari rekan kerja maupun lingkungan di luar tempat kerja. Dukungan sosial berupa komunikasi yang terbuka dengan kolega, mentor, supervisor, maupun keluarga dapat membantu perawat menyalurkan perasaan, berbagi beban emosional, serta mendapatkan perspektif baru terhadap tantangan yang dihadapi. Dukungan sosial ini juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, di mana perawat merasa dihargai, didukung, serta tidak merasa sendirian dalam menghadapi berbagai tekanan.

Secara kelembagaan, tempat kerja atau fasilitas pelayanan kesehatan juga diharapkan untuk menyediakan program pencegahan dan intervensi burnout. Program tersebut mencakup layanan konseling profesional, sesi refleksi terjadwal, kelompok dukungan, serta pelatihan manajemen stres yang terintegrasi dalam pendidikan dan pengembangan tenaga keperawatan secara berkala. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang suportif serta mengurangi stigma negatif terhadap perawat yang mengalami stres atau burnout, sehingga mereka tidak ragu untuk mencari bantuan ketika dibutuhkan.

Dengan demikian, manajemen stres dan burnout dalam keperawatan kritis bukan hanya tanggung jawab individu perawat, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara perawat, institusi pendidikan, serta fasilitas pelayanan kesehatan. Mahasiswa sebagai calon perawat kritis perlu memahami bahwa kemampuan untuk mengenali gejala burnout sejak dini, serta menerapkan strategi coping yang efektif, sangat penting demi menjaga kesejahteraan fisik dan mental mereka. Pada akhirnya,

perawat yang sehat secara emosional dan mental akan mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi, aman, efektif, serta berkelanjutan bagi pasien yang membutuhkan perawatan intensif.

G. Rekomendasi Berbasis Bukti

Dalam praktik keperawatan kritis yang semakin kompleks dan dinamis, kemampuan membuat rekomendasi yang berbasis bukti (evidence-based recommendations) menjadi salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap perawat kritis. Pendekatan berbasis bukti dalam keperawatan berarti bahwa semua keputusan klinis dan intervensi yang dilakukan oleh perawat harus didasarkan pada bukti ilmiah yang terbaru, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun klinis. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien benar-benar efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mampu beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang muncul seiring perubahan dalam praktik klinis maupun sistem kesehatan secara keseluruhan.

Rekomendasi berbasis bukti dimulai dari proses identifikasi masalah klinis yang jelas, yang berasal dari observasi langsung terhadap kondisi pasien, tantangan operasional dalam unit pelayanan, maupun perkembangan terbaru di bidang medis dan keperawatan. Setelah masalah teridentifikasi, perawat kritis harus mampu melakukan pencarian bukti ilmiah secara sistematis. Ini berarti bahwa perawat harus memiliki keterampilan dalam mengakses berbagai sumber informasi ilmiah terpercaya, seperti jurnal ilmiah, panduan klinis terbaru (clinical guidelines), database seperti PubMed atau Cochrane Library, serta rekomendasi dari organisasi profesi atau lembaga kesehatan internasional seperti Society of Critical Care Medicine (SCCM), American Association of Critical-Care Nurses (AACN), maupun organisasi kesehatan nasional.

Setelah mendapatkan bukti-bukti ilmiah yang relevan, langkah berikutnya adalah kemampuan menganalisis dan menilai kualitas dari bukti tersebut. Tidak semua bukti ilmiah memiliki kualitas yang sama tinggi, sehingga perawat kritis harus mampu mengevaluasi validitas, relevansi klinis, serta keterapan bukti ilmiah tersebut dalam konteks praktik lokal. Misalnya, rekomendasi tentang penggunaan ventilasi mekanik atau strategi pencegahan infeksi ICU harus berdasarkan pada penelitian terkini yang kualitas metodologinya terjamin, seperti randomized controlled trials (RCTs), systematic reviews, atau meta-analysis yang terpercaya.

Selanjutnya, kemampuan untuk mengintegrasikan bukti ilmiah ke dalam praktik klinis merupakan tahap penting dalam proses ini. Integrasi bukti ilmiah ke dalam praktik berarti perawat mampu menyusun rekomendasi intervensi yang jelas,

terukur, dan realistis, serta disesuaikan dengan kondisi pasien secara individual. Misalnya, dalam manajemen nyeri pasien kritis, perawat harus memilih intervensi yang didukung oleh bukti ilmiah kuat, seperti penggunaan protokol analgesik multimodal, yang terbukti efektif mengurangi nyeri dengan efek samping minimal.

Dalam konteks yang lebih luas, rekomendasi berbasis bukti juga sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan kebutuhan pasien maupun sistem kesehatan secara global. Misalnya, pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana bukti ilmiah yang berkembang cepat mengenai strategi pencegahan infeksi, penggunaan ventilasi mekanik, atau terapi farmakologis dapat digunakan oleh perawat kritis untuk merancang intervensi terbaik yang mampu menyelamatkan nyawa pasien secara masif. Oleh karena itu, kemampuan analitis yang kuat dalam mengevaluasi bukti ilmiah juga sangat diperlukan agar perawat mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan situasi klinis maupun tantangan baru yang muncul.

Selain itu, pendekatan rekomendasi berbasis bukti juga menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan kolaboratif dalam tim multidisiplin. Dengan mendasarkan keputusan pada bukti ilmiah yang jelas, perawat kritis akan lebih mudah dalam berdiskusi dan berkolaborasi dengan dokter, apoteker, ahli gizi, serta profesi kesehatan lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi komunikasi dalam tim tetapi juga secara signifikan mengurangi kemungkinan konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan klinis, karena semua keputusan didukung oleh bukti yang objektif.

Agar dapat secara konsisten memberikan rekomendasi berbasis bukti, institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan perlu mendukung pengembangan kompetensi ini melalui berbagai cara, seperti pelatihan reguler mengenai metode pencarian dan penilaian bukti ilmiah, sesi-sesi journal club rutin untuk membahas perkembangan terbaru dalam literatur ilmiah, hingga akses terbuka terhadap sumber daya informasi ilmiah berkualitas tinggi.

Dengan demikian, perawat kritis yang mampu membuat rekomendasi berbasis bukti adalah tenaga kesehatan yang sangat bernilai dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Kompetensi analitis ini memastikan bahwa perawat kritis tidak hanya memberikan pelayanan yang efektif, aman, dan efisien, tetapi juga menjadi tenaga kesehatan yang mampu merespons perubahan kebutuhan pasien dan tuntutan sistem kesehatan secara cerdas, cepat, serta penuh tanggung jawab profesional.

H. Latihan Soal

Soal 1 (Tren Global dan Nasional)

Seorang pasien perempuan, usia 70 tahun, dirawat di ICU dengan diagnosis COVID-19 berat, saturasi oksigen 78%, sesak napas berat, dan pasien membutuhkan ventilator. Saat ini ruang ICU sudah penuh dan ventilator yang tersedia terbatas. Sebagai perawat yang bertugas, apa tindakan awal paling tepat untuk mengatasi situasi ini?

- A. Memberikan masker oksigen biasa terlebih dahulu.
- B. Meminta keluarga mencari rumah sakit lain.
- C. Segera melakukan intubasi tanpa berdiskusi dengan tim medis.
- D. Melakukan diskusi triase bersama tim multidisiplin berdasarkan prioritas kegawatan pasien.
- E. Membiarkan pasien menunggu hingga ventilator tersedia.

Kunci jawaban: D

Rasional:

Pilihan D paling tepat karena mencerminkan tren global/nasional berupa pendekatan triase multidisiplin dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Pendekatan ini memastikan pasien mendapat intervensi berdasarkan kebutuhan klinis, bukan berdasarkan urutan kedatangan atau preferensi lain yang tidak objektif.

Soal 2 (Teknologi Digital dan Telehealth)

Seorang pasien laki-laki, usia 58 tahun, mengalami gagal jantung akut dan dirawat di ICU. Perawat memantau pasien melalui sistem telemonitoring, tiba-tiba terlihat penurunan saturasi oksigen drastis melalui layar monitoring jarak jauh. Apa tindakan paling tepat yang segera dilakukan oleh perawat?

- A. Menunggu beberapa menit sebelum melakukan tindakan.
- B. Menganggapnya sebagai gangguan teknis dan mengabaikan.
- C. Memberikan sedasi untuk menenangkan pasien.
- D. Segera melaporkan kepada dokter melalui telekonsultasi untuk tindakan cepat.
- E. Mencatat kejadian tersebut di rekam medis elektronik tanpa tindakan langsung.

Kunci jawaban: D

Rasional:

Pilihan D benar karena telekonsultasi memungkinkan intervensi segera oleh tim medis untuk mengatasi kondisi darurat berdasarkan data monitoring jarak jauh. Ini mencerminkan manfaat langsung dari teknologi digital dalam keperawatan kritis.

Soal 3 (Isu Etika dan Legal)

Pasien laki-laki, usia 82 tahun, dirawat di ICU dalam kondisi terminal akibat stroke luas. Tim medis menyatakan bahwa tindakan resusitasi (DNR) tidak akan memberikan manfaat medis tambahan. Keluarga pasien tetap menuntut dilakukannya semua tindakan maksimal. Apa peran utama perawat dalam situasi dilema etis ini?

- A. Memaksakan keputusan medis tanpa mempertimbangkan kehendak keluarga.
- B. Melakukan semua tindakan maksimal sesuai permintaan keluarga tanpa diskusi.
- C. Mengabaikan permintaan keluarga sepenuhnya dan menghentikan terapi.
- D. Menginisiasi diskusi dengan tim medis dan keluarga untuk mencapai keputusan bersama secara empati dan profesional.
- E. Memberikan keputusan sepenuhnya kepada keluarga pasien tanpa pendampingan.

Kunci jawaban: D

Rasional:

Pilihan D mencerminkan pendekatan etik terbaik dalam situasi ini, yaitu komunikasi empatik dan profesional untuk mencapai keputusan bersama yang sesuai dengan prinsip etika medis dan menghargai hak pasien serta keluarga.

Soal 4 (Manajemen Nyeri, Sedasi, dan Delirium)

Seorang pasien perempuan usia 60 tahun, sedang menjalani ventilasi mekanik pasca-operasi besar di ICU. Pasien tampak gelisah, tidak mampu tidur, sering terlihat bingung, dan pemeriksaan CAM-ICU menunjukkan positif delirium. Apa tindakan prioritas yang harus dilakukan perawat dalam menangani kondisi ini?

- A. Memberikan analgesik dosis tinggi.
- B. Memberikan sedasi berat agar pasien tidak gelisah.
- C. Mengisolasi pasien agar tidak mengganggu pasien lain.
- D. Mengoptimalkan lingkungan pasien seperti menjaga siklus tidur, orientasi tempat dan waktu, serta meminimalkan kebisingan.
- E. Mengabaikan karena delirium akan hilang dengan sendirinya.

Kunci jawaban: D

Rasional:

Pilihan D adalah tindakan paling tepat, karena pendekatan ini berbasis bukti untuk mengelola delirium dengan mengoptimalkan lingkungan pasien secara efektif. Memberikan analgesik dosis tinggi atau sedasi berat justru dapat memperburuk delirium.

Soal 5 (Keterbatasan Sumber Daya)

Pada situasi pandemi COVID-19, seorang perawat menghadapi kondisi di mana tiga pasien dalam kondisi kritis memerlukan ventilator secara bersamaan, namun hanya satu ventilator tersedia. Apa strategi paling tepat yang harus dilakukan bersama tim medis dalam situasi ini?

- A. Memberikan ventilator kepada pasien yang paling dulu datang.
- B. Memberikan ventilator kepada pasien yang keluarganya paling keras menuntut.
- C. Melakukan pendekatan triase berdasarkan kegawatan klinis dan potensi manfaat terbesar dari penggunaan ventilator.
- D. Menentukan secara acak melalui undian siapa yang mendapatkan ventilator.
- E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada perawat senior tanpa diskusi tim.

Kunci jawaban: C

Rasional:

Pilihan C benar karena sesuai dengan prinsip distributive justice dalam etika keperawatan kritis. Tindakan ini memastikan bahwa sumber daya terbatas (ventilator) digunakan dengan cara yang paling adil, efektif, dan klinis rasional berdasarkan kondisi medis pasien.

I. Rangkuman Materi

Keperawatan kritis merupakan bidang layanan kesehatan yang semakin vital di era modern, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun nasional seperti peningkatan penyakit kronis, infeksi emergen seperti COVID-19, serta keterbatasan sumber daya. Tren ini mendorong perlunya penguatan fasilitas kesehatan intensif, peningkatan kompetensi tenaga perawat kritis, serta adaptasi terhadap perubahan layanan berdasarkan protokol terbaru yang didukung oleh bukti ilmiah terkini.

Implementasi teknologi digital seperti rekam medis elektronik (EMR), telemonitoring, dan telekonsultasi menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi kesalahan medis, dan memastikan respons cepat terhadap perubahan kondisi pasien secara real-time.

Di sisi lain, perawat kritis dihadapkan pada berbagai dilema etika dan legal, seperti keputusan penghentian resusitasi atau dukungan hidup, serta alokasi sumber daya terbatas yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis, empati, komunikasi efektif, serta pemahaman mendalam tentang regulasi hukum dan hak pasien. Dalam hal ini, peran perawat menjadi sangat penting untuk menjembatani komunikasi antara tim medis dan keluarga pasien guna mencapai keputusan yang bijak secara etik dan legal.

Manajemen nyeri, sedasi, dan delirium merupakan aspek integral yang saling berkaitan dalam pelayanan intensif, yang harus dilaksanakan secara holistik berdasarkan pendekatan berbasis bukti dan individualisasi pasien. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kenyamanan, mempercepat proses penyembuhan, mengurangi komplikasi, serta meningkatkan hasil akhir perawatan pasien di ICU.

Selanjutnya, keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga keperawatan, peralatan medis, maupun fasilitas ICU, merupakan tantangan nyata yang memerlukan strategi efektif seperti triase, kolaborasi antarprofesi, komunikasi efektif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemahaman prinsip distributive justice sangat penting dalam memastikan penggunaan sumber daya secara adil, transparan, dan efektif.

Perawat kritis juga rentan mengalami stres dan burnout akibat beban kerja tinggi, tanggung jawab besar, serta paparan emosional yang intens. Oleh karena itu, pendidikan perawat kritis harus mencakup pelatihan pengenalan tanda burnout secara dini dan pengelolaan stres secara efektif melalui mindfulness, manajemen waktu, dukungan sosial, serta intervensi kelembagaan yang suportif.

Terakhir, kemampuan perawat kritis untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti menjadi kompetensi utama yang wajib dimiliki, meliputi identifikasi masalah klinis, pencarian bukti ilmiah terbaru, analisis kritis terhadap kualitas bukti, dan penerapan secara individual pada pasien. Kompetensi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan keamanan pelayanan keperawatan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, adaptif, serta responsif terhadap perubahan kebutuhan pasien dan sistem kesehatan secara keseluruhan.

Dengan demikian, perawat kritis yang kompeten, mampu beradaptasi terhadap tren kesehatan global dan nasional, menguasai teknologi digital, memiliki sensitivitas etika dan legal, mengelola nyeri, sedasi, serta delirium secara terpadu, memahami pengelolaan sumber daya yang terbatas, mampu mengatasi stres dan burnout secara efektif, serta membuat rekomendasi klinis berbasis bukti, merupakan aset strategis dalam memastikan keberhasilan pelayanan kesehatan intensif di masa kini dan masa depan.

J. Glosarium

Alokasi sumber daya:

Pengelolaan penggunaan sumber daya secara efisien dan adil berdasarkan prioritas medis, khususnya saat terjadi keterbatasan seperti dalam situasi pandemi.

Analgesik:

Obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri pada pasien.

Burnout:

Kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja kronis yang tidak dikelola secara efektif, ditandai dengan sikap negatif terhadap pekerjaan, kehilangan motivasi, serta penurunan kinerja.

CAM-ICU (Confusion Assessment Method for ICU):

Alat skrining yang divalidasi untuk mendeteksi delirium pada pasien yang dirawat di ICU.

Delirium:

Gangguan kesadaran akut dengan gejala seperti kebingungan, disorientasi, halusinasi, dan perubahan perilaku yang muncul secara mendadak, sering terjadi pada pasien kritis di ICU.

Distributive justice:

Prinsip etika yang menekankan pentingnya pembagian sumber daya yang terbatas secara adil, transparan, dan berbasis kebutuhan serta manfaat klinis.

Do-Not-Resuscitate (DNR):

Keputusan untuk tidak melakukan tindakan resusitasi jantung-paru pada pasien dengan prognosis buruk atau kondisi terminal, dengan mempertimbangkan kualitas hidup pasien.

Evidence-based practice (EBP):

Pendekatan klinis yang mendasarkan keputusan perawatan pada bukti ilmiah terbaru dan berkualitas tinggi yang relevan secara klinis.

Electronic Medical Record (EMR):

Rekam medis elektronik yang berisi riwayat medis pasien secara digital yang memudahkan akses dan koordinasi data klinis pasien oleh tenaga kesehatan.

Fasilitas intensif (ICU):

Unit perawatan intensif yang dilengkapi dengan peralatan khusus untuk menangani pasien dengan kondisi medis serius atau kritis.

Intervensi berbasis bukti:

Tindakan klinis yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru yang menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan hasil klinis dan keselamatan pasien.

Kapasitas ICU:

Jumlah pasien yang bisa ditampung secara bersamaan di unit perawatan intensif, termasuk kelengkapan alat medis dan tenaga keperawatan yang tersedia.

Kelelahan emosional:

Kondisi psikologis di mana seseorang merasa sangat lelah secara emosional akibat tekanan yang terus-menerus.

Kompetensi spesifik keperawatan kritis:

Keterampilan khusus yang diperlukan perawat dalam menangani pasien kritis, termasuk manajemen ventilasi mekanik, pemantauan hemodinamik, dan pengambilan keputusan cepat dalam situasi darurat.

Manajemen nyeri:

Strategi sistematis dalam mengevaluasi, mengelola, dan mengurangi rasa nyeri pada pasien menggunakan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis yang berbasis bukti.

Mindfulness:

Teknik psikologis untuk mengelola stres melalui kesadaran penuh terhadap situasi saat ini, menerima emosi dan perasaan secara sadar tanpa penilaian.

Multimodal analgesia:

Pendekatan manajemen nyeri yang menggunakan kombinasi beberapa metode atau obat analgesik untuk meningkatkan efektivitas dan meminimalkan efek samping.

Pandemi COVID-19:

Wabah global akibat virus SARS-CoV-2 yang dimulai pada akhir tahun 2019, menyebabkan lonjakan jumlah pasien kritis secara global.

Pemantauan jarak jauh (Telemonitoring):

Teknologi yang memungkinkan tenaga kesehatan memantau kondisi klinis pasien secara real-time dari jarak jauh, menggunakan sensor canggih yang terintegrasi dengan sistem pemantauan pusat.

Pendekatan triase:

Proses penilaian cepat yang digunakan untuk menentukan prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatan medis dan potensi manfaat dari intervensi yang diberikan, khususnya dalam situasi sumber daya terbatas.

Protokol klinis:

Pedoman sistematis berbasis bukti ilmiah yang digunakan untuk menentukan standar tindakan medis dan keperawatan dalam kondisi klinis tertentu.

Rekomendasi berbasis bukti:

Panduan atau intervensi klinis yang disusun berdasarkan bukti ilmiah yang valid, terpercaya, dan terbaru untuk mendukung keputusan klinis yang efektif dan aman.

Resusitasi jantung-paru (CPR):

Tindakan medis darurat untuk mengembalikan fungsi jantung dan pernapasan pasien yang mengalami henti jantung atau gagal napas.

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS):

Skala klinis untuk menilai tingkat agitasi atau sedasi pasien di ICU, membantu menentukan dosis sedasi yang tepat.

Sedasi ringan (light sedation):

Pendekatan pemberian sedasi minimal yang mempertahankan kesadaran pasien agar mampu merespons rangsangan secara tepat, bertujuan mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi.

Siklus tidur-bangun:

Pola alami tidur dan aktivitas bangun pasien yang harus dipertahankan agar pasien tetap nyaman dan terhindar dari komplikasi seperti delirium.

Skala nyeri (Numeric Rating Scale / NRS):

Instrumen untuk menilai intensitas nyeri yang dialami pasien menggunakan skala numerik 0-10, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan nyeri yang lebih parah.

Standar operasional prosedur (SOP):

Pedoman tertulis yang merinci langkah-langkah yang harus dilakukan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas sesuai standar profesional.

Telekonsultasi:

Konsultasi medis yang dilakukan melalui platform digital antara tenaga kesehatan atau dengan pasien secara jarak jauh untuk mempercepat pengambilan keputusan klinis.

Teknologi digital dalam kesehatan:

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti rekam medis elektronik, telemonitoring, dan telekonsultasi, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan.

Ventilator mekanik:

Alat medis untuk membantu atau menggantikan fungsi pernapasan pasien yang mengalami kegagalan pernapasan dengan memberikan dukungan pernapasan secara mekanis.

Withdrawal of life support:

Keputusan untuk menghentikan dukungan hidup seperti ventilasi mekanik atau terapi lain yang tidak lagi memberikan manfaat medis yang jelas bagi pasien.

K. Daftar Pustaka

- American Association of Critical-Care Nurses (AACN). (2020). AACN essentials of critical care nursing (4th ed.). Elsevier.
- Brummel, N. E., & Ely, E. W. (2018). Delirium in the intensive care unit. *Critical Care Clinics*, 34(3), 363–381. <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2018.03.011>
- Curtis, J. R., & Vincent, J.-L. (2010). Ethics and end-of-life care for adults in the intensive care unit. *The Lancet*, 376(9749), 1347–1353. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60143-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60143-2)
- Ely, E. W., Margolin, R., Francis, J., May, L., Truman, B., Dittus, R., ... Inouye, S. K. (2001). Evaluation of delirium in critically ill patients: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). *Critical Care*

Medicine, 29(7), 1370–1379. <https://doi.org/10.1097/00003246-200107000-00012>

Gomersall, C. D., Loo, S., Joynt, G. M., & Taylor, B. L. (2020). Pandemic preparedness and response in intensive care. *Intensive Care Medicine*, 46(12), 2341–2343. <https://doi.org/10.1007/s00134-020-06200-x>

Marra, A., Ely, E. W., Pandharipande, P. P., & Patel, M. B. (2017). The ABCDEF Bundle in critical care. *Critical Care Clinics*, 33(2), 225–243. <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2016.12.005>

McGonigal, A., & Doherty, L. (2020). Burnout and resilience in critical care nurses: A qualitative study. *Intensive and Critical Care Nursing*, 58, 102807. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102807>

Patel, M. B., & Kress, J. P. (2012). Sedation and analgesia in the mechanically ventilated patient. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 185(5), 486–497. <https://doi.org/10.1164/rccm.201102-0273CI>

Society of Critical Care Medicine (SCCM). (2018). Clinical practice guidelines for pain, agitation/sedation, delirium, immobility, and sleep disruption in adult patients in the ICU. *Critical Care Medicine*, 46(9), e825–e873. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000003299>

Vincent, J.-L., Singer, M., & Marini, J. J. (2020). COVID-19: ICU management and prognosis. *Intensive Care Medicine*, 46(5), 827–830. <https://doi.org/10.1007/s00134-020-06063-2>

World Health Organization (WHO). (2020). Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected: Interim guidance. WHO. Retrieved from [https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected](https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected)

Young, T. P., & Jaganath, D. (2019). Triage in resource-limited settings. *Current Opinion in Pediatrics*, 31(1), 97–102. <https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000705>

PROFIL PENULIS



Ns. Hairunnisa S.Kep., M.Kep. Lahir di Sintang, Kalimantan Barat, 10 Januari 1983. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan bapak M.Jupridin dan ibu Siti Hamisah. Pendidikan yang di tempuh oleh penulis yaitu pendidikan formal pada program kelas khusus (S1) keperawatan di UMJ dan menyelesaikan program magister (S2) pada pasca Sarjana Keperawatan Peminatan Maternitas di FIK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengalaman bekerja penulis yaitu di Akper Pemprov Kalbar di Sintang sejak 2007 – 2011, Mei 2011 – September 2024 bekerja di prodi keperawatan Politeknik Hang Tuah Jakarta sebagai dosen tetap dan koordinator mata ajar Keperawatan Maternitas, Oktober 2024 sampai dengan sekarang penulis bekerja sebagai dosen tetap di prodi keperawatan STIKes Persada Husada Indonesia. Penulis aktif sebagai pengajar bimbel UKOM, serta konselor laktasi dari Sentra Laktasi Indonesia (SELASI).



Ns. Hesti Prawita Widiastuti, SST., M.Kes. Lahir di Samarinda, sejak SD sampai dengan diploma, penulis menyelesaikan pendidikan di kota Samarinda. Pada tahun 2006, menyelesaikan pendidikan Diploma III di Poltekkes Samarinda dan pada tahun 2007 melanjutkan studi Diploma IV di Poltekkes Samarinda. Pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan program Magister Sains Terapan Kesehatan di Universitas Diponegoro.

Pengalaman mengajar penulis mulai terasah sejak lulus dari pendidikan Diploma IV, dimana sejak awal Januari 2008 hingga Februari 2012 menjadi asisten praktikum di laboratorium dan sebagai pembimbing klinik di lahan praktik baik rumah sakit maupun puskesmas pada Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Saat ini penulis menjadi dosen tetap di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim. Penulis juga aktif di organisasi profesi sebagai pengurus DPW PPNI Provinsi Kaltim. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

hestiprawita.poltekkeskaltim@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Moza Suzana, S.Kep., M.Kep.

Penulis memulai masa pendidikan kesehatan di STIKES HARAPAN IBU JAMBI pada program studi ilmu keperawatan dan profesi Ners. Penulis mulai mengembangkan keterampilan klinis dan memutuskan melanjutkan studi Magister keperawatan jurusan S2 manajemen keperawatan di universitas Andalas. Sejak tahun 2008 Penulis memulai mengawali karier sebagai Dosen tetap di STIKES Bina insani sakti, beberapa mata kuliah yang diampu oleh penulis di antaranya metodologi keperawatan, manajemen keperawatan, dokumentasi keperawatan, anatomi keperawatan, ilmu biomedik, keperawatan Anak dan Manajemen patient safety, penulis juga aktif membimbing mahasiswa praktek di rumah sakit, puskesmas dan komunitas.

Penulis berharap untuk ke depannya penulis mampu menulis buku yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk mahasiswa dan tenaga pengajar perguruan tinggi.

Email penulis : mozasuzana45@gmail.com



Fathimi, S.Kep., M.K.M. lahir di Durian Kawan, pada 11 Januari 1980. Menyelesaikan Sekolah Perawat Kesehatan Pemda Aceh Selatan (1999). Diploma-III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh (2003), S1 Keperawatan PSIK FK Unsyiah (2007) dan S2 Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2019). Penulis sebagai Dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Aceh, Prodi Keperawatan Aceh Selatan. Mata kuliah yang diampu: Keperawatan Dasar, Keperawatan Gawatdarurat dan Manajemen Bencana, Promosi Kesehatan dan Manajemen Pasien Safety. Penulis aktif di organisasi PPNI, IAKMI dan HAKLI.

PROFIL PENULIS



Ns. Riyan Dwi Prasetyawan, S.Kep.,M.Kep Lahir di Banyuwangi, 01 Agustus 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan di STIKES Banyuwangi lulus tahun 2015. kemudian melanjutkan Profesi Ners di STIKES Banyuwangi lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Keperawatan di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 di STIKES Banyuwangi, sebagai dosen sekaligus staf wakil ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Sebagai dosen di STIKES Banyuwangi, penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Bencana, Keperawatan Kritis dan Keperawatan Holistic. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, serta pelatihan khususnya dibidang keperawatan gawat darurat, kritis, kebencanaan dan holistic. Selain itu, penulis juga aktif terlibat sebagai pengelola jurnal ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: riyandwiprasetyawan@gmail.com

PROFIL PENULIS

Dr. Aliana Dewi., S.Kp., MN

Dosen Program Studi Keperawatan & Dekan Fakultas Keperawatan & Kebidanan Universitas Binawan

Aliana Dewi lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 1969. Beliau lulus AKPER RSPAD Gatot Soebroto tahun 1991, melanjutkan pendidikan ke S1 Keperawatan di FIK UI, melanjutkan S2 Keperawatan (Master Of Nursing) di University of Technology Sydney, Australia lulus tahun 2007 serta penulis melanjutkan program doktoral di FIK UI lulus tahun 2019. Pengalaman kerja penulis yaitu pernah bekerja di RS Mitra Internasional di Jakarta selama 11 tahun di ruang Intensive Care Unit (ICU), Dosen di AKPER Mitra Keluarga tahun 1999 – 2002, bekerja di Lulworth St Luke Hospital Australia tahun 2005 – 2007, menjadi Direktur di AKPER Pemkab Muba tahun 2007 – 2011, Dosen tamu, Narasumber/ Fasilitator Pelatihan ICU Kemenkes RI dan HIPERCCI dari tahun 2011 – sekarang. Pengalaman organisasi yaitu penulis sebagai Pengurus South East Asia Federation Critical Care Nurses (2018-2023), Ketua Umum HIPERCCI (2012 – 2022), Surveior KARS (2009 – 2013), Diklat PP Kreki (2018 -2023,), Asesor LSP Nakes Kemenkes RI (2018- sekarang), Asesor LAMPTKes (2018 – sekarang) serta Ketua Koordinator Bidang Diklat dan Penelitian PP HIPERCCI (2023 – sekarang). Saat ini beliau bekerja di Universitas Binawan sejak 2003 sampai sekarang. Di Universitas Binawan selain menjadi dosen di program studi Keperawatan penulis juga menjadi Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Penulis memiliki kepakaran dibidang Keperawatan Medikal Bedah, Critical Care Nursing dan Emergency Nursing. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Kritis ini dirancang sebagai sumber referensi komprehensif yang memadukan pendekatan filosofis, holistik, dan klinis dalam praktik keperawatan di ruang perawatan intensif. Buku ini diawali dengan pembahasan mendalam mengenai filosofi dan konsep holistik keperawatan kritis serta penjabaran proses keperawatan yang sistematis. Dengan pendekatan ini, mahasiswa keperawatan dan praktisi diharapkan mampu memahami dasar-dasar pemikiran yang membentuk praktik keperawatan kritis yang profesional, manusiawi, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, buku ini menekankan pentingnya analisis kasus berbasis penelitian dalam pengambilan keputusan klinis. Bab kedua hingga keempat menyajikan langkah-langkah dalam melakukan sintesis data dari kasus kritis, integrasi hasil penelitian terkini, dan penerapan intervensi berbasis bukti. Peran advokasi perawat juga dibahas secara komprehensif, mencakup keterampilan komunikasi, etika, dan perlindungan hak pasien kritis. Selain itu, strategi pendidikan kesehatan yang efektif untuk pasien dan keluarga dalam situasi kritis juga menjadi perhatian utama untuk memperkuat pemberdayaan pasien.

Bab kelima dan keenam memperluas cakupan pembahasan dengan mengintegrasikan aspek legal dan etis dalam asuhan keperawatan kritis lintas sistem tubuh, serta menelaah isu-isu aktual seperti teknologi digital, keterbatasan sumber daya, burnout tenaga kesehatan, dan rekomendasi praktik terkini. Disusun secara sistematis dengan glosarium, latihan soal, dan rangkuman materi di setiap bab, buku ini menjadi panduan aplikatif dan teoritis yang mendukung penguatan kapasitas perawat dalam menghadapi tantangan kompleks di area keperawatan kritis masa kini dan masa depan.

Buku Ajar Keperawatan Kritis ini dirancang sebagai sumber referensi komprehensif yang memadukan pendekatan filosofis, holistik, dan klinis dalam praktik keperawatan di ruang perawatan intensif. Buku ini diawali dengan pembahasan mendalam mengenai filosofi dan konsep holistik keperawatan kritis serta penjabaran proses keperawatan yang sistematis. Dengan pendekatan ini, mahasiswa keperawatan dan praktisi diharapkan mampu memahami dasar-dasar pemikiran yang membentuk praktik keperawatan kritis yang profesional, manusiawi, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, buku ini menekankan pentingnya analisis kasus berbasis penelitian dalam pengambilan keputusan klinis. Bab kedua hingga keempat menyajikan langkah-langkah dalam melakukan sintesis data dari kasus kritis, integrasi hasil penelitian terkini, dan penerapan intervensi berbasis bukti. Peran advokasi perawat juga dibahas secara komprehensif, mencakup keterampilan komunikasi, etika, dan perlindungan hak pasien kritis. Selain itu, strategi pendidikan kesehatan yang efektif untuk pasien dan keluarga dalam situasi kritis juga menjadi perhatian utama untuk memperkuat pemberdayaan pasien.

Bab kelima dan keenam memperluas cakupan pembahasan dengan mengintegrasikan aspek legal dan etis dalam asuhan keperawatan kritis lintas sistem tubuh, serta menelaah isu-isu aktual seperti teknologi digital, keterbatasan sumber daya, burnout tenaga kesehatan, dan rekomendasi praktik terkini. Disusun secara sistematis dengan glosarium, latihan soal, dan rangkuman materi di setiap bab, buku ini menjadi panduan aplikatif dan teoritis yang mendukung penguatan kapasitas perawat dalam menghadapi tantangan kompleks di area keperawatan kritis masa kini dan masa depan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-20-3



9

786347

294203